1주차 1교시	가족치료의 특성	
	수업목표	가족치료만의 특성을 이해하고 개인치료와의 차이점을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족상담 및 치료란 무엇인가? 2. 개인치료와 가족치료의 차이는 무엇인가?

1. 가족상담 및 치료란 무엇인가?

◆ 가족상담 및 치료의 정의

- 가족체계와 가족체계 내 개인의 문제를 회복시켜 가족의 건강한 생활 영위를 목적으로 하는 상담의 한 형태(상담학 사전, 2016, 학지사)
- 가족원 간의 관계와 상호작용을 변화시켜 대인관계 기술과 적응능력을 향상하게 하고, 개인과 가족이 건강하고 기능적인 생활을 하도록 전문적인 도움을 주는 활동(곽라은 외, 2018, 양성원)

◆ 상담과 치료의 개념 비교

- 상담사가 도움을 필요로 하는 사람에게 전문적 지식과 기능을 가지고 내담자와 환경에 대한 이해를 증진시키며, 합리적이고 현실적이며 효율적인 행동양식을 증진시키거나 의사결정을 내릴 수 있도록 원조하는 활동

❖ 상담 vs. 심리치료

① 모든 행동변화나 의사결정은 내담자가 원하는 것이어야 함

② 상담은 자발적 변화가 일어날 수 있는 조건을 제공하는 것이어야 하며 내담자가 선택하고 결정할 권리를 존중해야 됨

③ 합리적 계획, 문제해결, 의사결정, 환경적 압력에 대한 대응, 일상 행동습관 등과 같은 일상생활의 문제에 중점을 둠

- 상담은 흔히 심리치료와 유사하게 사용하기도 하지만 흔히 다음과 같이 내담자의 특성에 따라 구분함

- 상담 : 정신질환이 없는 정상적 사람을 대상으로 하는 것
- 심리치료 : 신경증이나 정신병 같은 이상행동(異常行動)을 보이는 사람들을 대상으로 함 (교육학용어사전, 1995. 서울대학교 교육연구소)

	사용 분야	내담자 특성	목표
상담	심리학, 교육학	도움이 필요한 내담자	긍정적 변화, 적응, 성장
치료	정신의학	병리증상이나 정신장애 문제를 가진 환자	증상 완화, 기능 회복

❖ 가족상담 vs. 가족치료

- 가족상담
  - 신경 정신적 장애진단이 나타나지 않은 문제(결혼적응, 부부관계, 부모-자녀관계, 고부관계 등)가 발생하였을 때 가족생활과 관련된 문제 해결을 지원하고, 가족원의 관계증진과 기능향상, 성장을 목표로 도움을 줌
- 가족치료
  - 신경 정신장애 환자의 치료 목적을 위해 가족체계의 이론과 기술을 개인, 부부, 가족에 적용하는 한 가지 전문 서비스로서 증상 완화는 물론 성격의 심층적 변화와 관계증진, 가족의 기능향상을 목표로 함

- 가족 상담 및 치료분야를 선도하는 미국의 흐름은 가족상담과 가족치료를 혼용하고 있으므로, 본 수업에서는 가족 상담과 가족치료를 혼용하여 사용함

2. 개인치료와 가족치료의 차이는 무엇인가?

◆ 개인치료와 구별되는 가족치료의 특징

1) 문제 초점의 차이
- 개인 상담 : 개인의 성격발달과정과 정신 내면의 역동
- 가족 상담 : 가족 관계 및 체계, 상호작용, 문제해결
- 가족상담은 해결에 초점을 두며, 구체적이고 성취 가능한 목표 설정

2) 개입대상의 차이
- 개인 상담 : 개인의 과거와 현재의 결함
- 가족 상담 : 가족 구성원 중 문제시되고 있는 지적된 환자(IP: Identified Patient)와의 반복적인 상호작용 양상

3) 상담 단위의 차이
- 개인 상담 : 개인
- 가족 상담 : 개인, 부부치료, 가족치료 등 혼합
- 가족 상담은 반드시 가족 전원을 대상으로 하는 것이 아니라, 현재의 문제와 관련되어 상호작용 양상을 바꾸는 데 꼭 필요한 가족원

4) 상담 기간의 차이
- 개인 상담 : 개인의 내면 갈등을 해결하고자 하므로 많은 시간이 필요함
- 가족 상담 : 현재의 역기능적인 상호작용 양상을 중심으로 치료를 시도하므로 단기간 소요(일반적으로 12회기 이내)
- 가족원의 오래된 내면의 갈등 해결보다는 개인을 둘러싼 상호작용관계의 문제를 해결하는 데 초점을 둠

5) 기본 철학과 가정의 차이

특성	개인 상담	가족 상담
인간관	결정론적, 반응적 존재	선택의 자유, 능동적 존재
세계관	기계론	유기체적

기본가정	개인적, 환원적	관계적, 맥락적
인과관계	직선적 인과론	순환적 인과론
접근방법	주체 / 객체의 이원론	전체성, 상호의존적 전일성

◆ **집단치료와 구별되는 가족치료의 특징**

❖ 공통점

- 여러 사람이 참여하여 상담사와 내담자의 관계 형성이 단순하지 않음

• 집단치료

- 낯선 사람들로 구성, 동등한 존재로 참여, 스트레스를 주는 환경에서 분리되어 있음

• 가족치료

- 친밀한 사람들로 구성, 위계가 있음 스트레스 상황 자체가 치료대상이 됨

❖ 가족치료, 개인치료, 집단치료의 특성 비교

	치료 목표	초점	상담사 역할	주요 문제
가족치료	가족 기능 향상	의사소통 행동유형 상호작용 패턴 가족체계	적극적 참여관찰자	부부문제, 부모-자녀갈등, 고부갈등, 가족불화, 가족 정서 행동 문제
개인치료	성격의 재구조화 행동수정 증상 제거 인지 변화	무의식, 감정전이, 행동학습, 기능회복, 인지, 사고 개인	비지시적 소극적 적극적 지시적	성격, 무의식적 갈등, 행동 문제, 부적응, 스트레스 관련 불안, 정서 행동 문제
집단치료	사회적 기능 향상	집단참여, 피드백, 집단 역동, group	유동적 촉진자	대인관계 문제, 부적응, 불안, 행동 문제

3. 가족치료를 적용할 수 있는 문제는?

◆ **가족치료 적용 가능한 문제**

- 가족치료는 많은 정신건강 문제를 치료하는 데 있어 개인 중심 치료만큼 효과적이며, 어떤 경우에는 더 효과적
- 성인의 조현병, 정서장애(예: 우울증, 불안), 성인 알코올 중독과 약물남용, 아동의 품행장애, 청소년 약물 남용, 젊은 성인 여성의 식이장애, 부부불화와 갈등, 부모자녀 간 문제, 청소년 문제행동 등에 적용 가능

가족치료 적용 문제	개인치료 적용 문제
자녀의 정서·행동 문제 및 학교 부적응, 성적인 문제, 가족원 간의 의사소통 문제, 만성적 직장 부적응, 알코올 문제 등	모래알처럼 분리되고 무관심한 가족, 의료적 주의가 필요한 만성적 정신건강 문제, 가족저항이 커서 상담 참여 시 정신신체화 증상이나 다른 문제 발생 가능성이 있을 때,

	가족원 간 적대적 행동과 불신 수준이 높은 경우

◆ 가족치료의 효과

- 많은 연구는 정신장애와 정서장애 및 건강 문제를 치료하는 데 가족치료가 효과적이었다는 것을 증명함
  · 가족치료를 받은 내담자들은 정서적 건강 향상, 신체건강 향상, 직장에서 능률 향상, 부부관계 향상, 자녀의 행동과 학업수행능력 향상, 자녀의 또래 관계 향상 등의 효과 검증

1주차 2교시	서구 가족치료의 발달과정	
	수업목표	가족치료의 발달배경과 서구의 가족치료 발달과정을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 가족치료의 발달배경 2. 서구 가족치료의 발달단계

1. 가족치료의 발달배경

◆ 서구 가족치료 발현의 흐름

- 전통적인 개인 심리치료의 한계로 느껴 새로운 움직임이 발생
- 기계론적 세계관과 다른 유기체론적 세계관 확산

◆ 가족치료에 영향을 미친 변화들

❖ 개인치료적 접근의 한계를 벗어나기 위한 다양한 시도들 (집단역동운동, 아동지도운동, 부부상담, 사회복지실천적 개입)이 가족치료의 탄생에 영향을 미쳤음

1) 집단역동운동

- 개입의 대상 : 개인이 아닌 집단
- 모레노(Jacob Moreno)가 최초 도입
- 사이코드라마 개발로 가족치료 발전에 기여
  - 사이코드라마
    - 이 기법은 자신의 갈등상황을 말로 설명하는 것이 아니라 연기로 표현함으로써 자신이 갖고 있는 문제의 심리적 차원을 탐구함
    - 자신의 현실, 좌절당한 상황, 소망 등 자신이 직면하고 있는 문제를 연기로 표현하는 과정을 통해 내재된 자신의 감정, 무의식적 충동 등을 깨닫게 되고, 현재 문제와 관련된 환상이나 기억을 찾아냄
    - 이렇게 함으로써 현재 문제를 해결하기 위한 여러 가지 대안을 모색하고, 보다 건강한 방식으로 적응해 나감 (상담학 사전, 2016. 김춘경 외, 학지사)
- 집단역동에 관한 이론적 접근은 레빈(Kurt Lewin)의 장이론(field theory)이 기초가 됨
  - 장이론
    - 장은 하나의 전체이며, 그것의 부분들은 즉각적인 관계를 맺고 있어서 서로에게 반응하고, 장의 다른 곳에서 일어나는 일에 영향을 받는 관계적인 특성을 가짐(상담학 사전, 2016. 김춘경 외, 학지사)
    - 즉, 인간의 행동은 개인과 환경 간 상호작용의 산물이므로, 개인이 아니라 가족 전체를 치료의 대상으로 여겨야 한다는 것
- 장이론은 부분과 요소는 별개로 존재하지 않고 전체로 통합되며, 행동은 기계적으로 이루어지기보다 역동적이라는 시각을 가짐

2) 아동지도운동

- 정서적 문제는 아동기에 시작되며 아동에게 있어 부모의 영향이 중요함을 강조함

□ 프로이트(Sigmund Freud)

- 아동기의 해결되지 않은 문제가 성인기의 심리적 문제와 관련이 있음을 최초로 주장함

□ 아들러(Alfred Adler)

- 아동발달에 미치는 부모와 가족의 영향력 강조

3) 부부상담의 필요성 확산

- 결혼생활의 문제는 부부 상호작용의 문제에 기인한 것이므로 개인의 정신치료적 접근으로 다루기에는 한계가 있음

  ⇨ 따라서 부부가 함께 참여할 때 변화가 일어날 것을 강조

- 부부상담 → 생태학 모델의 발전 → 가족치료의 기초가 됨

4) 사회복지실천적 개입

- 사회복지실천은 전통적으로 개입의 초점이 가족
- 가족 문제를 정확하게 이해하기 위해 부모를 면접하는 것을 중요하게 여김

◆ 체계론적 사고의 등장

- 앞서 제시한 여러 가지 개입들은 개인의 변화는 가족 전체의 체계를 변화시키고, 개인을 변화시키기 위해서는 가족이 변화하는 것이 가장 효과적인 방법임이 인식하게 함

• 기존의 패러다임

· 기계론적 패러다임(모든 현상은 기계적 원리, 즉 물질의 운동과 그 법칙으로 설명될 수 있다는 주장, 교육학용어사전, 1995. 서울대학교 교육연구소, 하우동설)

- 체계론적 사고관 새롭게 등장
- 세계를 모든 현상의 상호 연관성과 상호 의존성으로 파악
- 이로 인해 전통적인 심리치료와 다른 가족치료가 탄생하게 됨

2. 서구 가족치료의 발달단계

◆ 가족치료의 발달과정과 주요인물

1986년	프로이트 정신분석 이론 탄생
1915년	아인슈타인, 일반상대성 이론 발표
1920년~30년대	체계론적 사고 등장
1940년대	**가족치료 파종기**
1945년	제2차 세계대전 종전
1950년대	**가족치료 발아기**
1960년대	**가족치료 모종기**
1970년대	**가족치료 개화기**
1980년대	포스트모더니즘 사고 확산
1980년대 중반	**가족치료 전환기**
1990년대	가족치료 통합기



❖ 출처 : 가족치료의 이해, 정문자 · 정혜정 · 이선혜 · 전영주, 학지사, p. 27

◆ 가족치료 파종기 : 1940년대까지

- 이전에 지배적이던 기계론적 세계관의 한계를 인식하며, 체계이론과 사이버네틱스가 개인문제해결에 영향을 미침

• 사이버네틱스

· 기존의 심리상담이론이 직선적 인과관계에 근거하여 심리적 고통 혹은 증상의 원인을 명확하게 하고 제거하여 증상(결과)을 제거하는 접근이라면, 사이버네틱스 이론은 순환적 인과관계와 피드백에 근거함 (자세한 설명은 3주차에서 다룸)

❖ 사이버네틱스의 원리는 개별적으로 존재하는 대상에 초점을 두는 전통적인 심리치료적 접근에서 벗어나, 사람 간의 상호작용이나 관계 패턴에 초점을 두는 가족치료의 태동에 직접적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있음

• 궁극적인 관심

- 분리되어 존재하는 실체를 탐구하는 것이 아닌 다양성 속에서 공통적인 조직원리를 발견하는 것 = 서로를 연결 짓는 패턴(patterns which connect)

• 가족치료에 공헌점

- 개별적으로 존재하는 대상이나 실체에 초점을 두는 전통적인 심리치료적 접근에서 벗어나 사람 간 상호작용이나 관계패턴으로 초점의 전환

◆ 가족치료 모종기 : 1950년대

❖ 일반체계이론과 사이버네틱스 개념이 행동과학에 적용되기 시작

- 미국은 전쟁 이후 증가하는 가족생활의 변화(재결합 가족의 문제, 전쟁으로 인한 결혼 지연, 베이비붐 등)를 경험하면서 사회의 기본단위인 가족의 안정성 회복에 관심을 가지게 됨

□ 베이트슨과 동료들

- 조현병이 가족환경 안에서 발생할 수 있다는 연구가설을 세움
- 조현병이 개인의 정신내적 질병이라기보다 대인적·관계적 현상이라고 봄

□ 애커만(Nathan Ackerman)

- 개인의 정신역동에 가족환경이 미치는 영향을 중시하면서 가족평가와 치료를 주도함

□ 보웬(Murray Bowen)

- 개인의 정신역동에 가족환경이 미치는 영향을 중시하면서 가족평가와 치료를 주도함

□ 휘태커(Carl Whitaker)

- 조현병 치료를 위해 가족을 변화시키는데 초점을 둠
- 이론의 구축보다 치료기법 개발에 집중
- 조현병 환자 치료를 위해 놀이치료 실시하고, 환자와 가족 함께 참여시킴

◆ 가족치료 발아기 : 1960년대

❖ 가족치료가 독립된 전문 분야로 자리 잡기 시작

- 미국의 서부 팔로알토(Palo Alto)에 가족치료 전문가 집단이 결집

• 정신건강연구소(Mental Research Institute : MRI)

· 헤일리, 잭슨, 사티어가 주로 활동
· 청소년 비행과 학교 문제, 부부 문제에 관한 연구 수행

□ 사티어(Virginia Satir)
- 경험적 가족치료 모델. 가장 영향력 있는 가족치료 전문가
- 인생 초기 부모와의 의사소통과 상호작용을 통해 정서적 성장과 자아존중감이 형성된다고 주장

□ 미누친(Salvador Minuchin)_미국 동부지역에서 활동
- 구조적 가족치료 모델
- 저소득층 비행청소년 집단을 치료하는 과정에서 정신분석치료 기법이 효과적이지 못함을 발견
- 청소년 비행 뒤에는 역기능적인 가족구조가 있음을 발견함

◆ 가족치료 개화기 : 1970년대

- 가족치료 선구자들이 발전시킨 이론적 모델을 배우고자 하는 학생들이 증가하고, 가족치료 관련 연구와 서적 증가
- 가족치료 모델 간 경계가 분명해짐

◆ 가족치료 전환기 : 1980-1990년대

❖ 초기 모델의 통합

- 특정 모델을 추구하기보다 내담자의 증상에 따라 여러 모델을 통합하고 필요에 따라 적절한 모델을 사용할 필요성을 느낌

❖ 후기 모델의 출현

- 포스트모더니즘의 등장으로 개인이 의미를 부여하는 세계가 곧 진실이요 실재라는 믿음이 확산
- 개인이 자신의 가족이나 관계를 어떻게 경험하는지, 자신의 경험의 세계에 어떤 의미를 부여하며 자신의 경험의 세계를 구성하는지를 파악하는 것이 문제해결 과정에서 더 중요하게 여김
- 치료자는 내담자보다 더 유능한 전문가이기보다 내담자의 경험세계를 재창조하는 과정에서 협력해야 할 동반자임을 강조

• 대표적인 치료 모델 : 해결지향 모델, 해결중심 모델, 이야기치료, 협력언어체계 모델 등

1주차 3교시	가족치료에 영향을 준 상담이론	
	수업목표	가족치료에 영향을 준 상담이론을 통해 상담이론 간 차이점을 구별할 수 있다.
	세부내용	1. 초기모델 2. 후기모델

1. 초기모델

◆ 다세대 모델

1) 대표인물

- 보웬(Bowen), 보스조메니 나지(Boszomenyi-Nagy)

2) 주제

- 다세대에 걸친 정서과정에서 집중적인 투사의 대상이 된 가족원에게 증상이 나타남
- 가족원의 자기분화를 촉진하여 가족체계의 변화를 유도하여 문제를 해결하고자 함

3) 주요 개념

- 자기분화, 삼각관계, 핵가족 정서체계, 가족투사과정, 다세대 전수과정
- 개인의 정신 내적 과정과 대인관계 양식이 여러 세대에 걸친 가족의 상호작용 과정을 통해 전달되는 것으로 가정함
- 인간은 누구나 대인관계 장부를 가지고 있으며, 장부가 공평하게 경험되기를 원하는 실존적 욕구를 가지고 있음
- 공평하지 못하다고 느끼게 되면 문제나 증상이 발생함

4) 치료 목표

- 다세대 정서과정을 이해함으로써 자기분화의 촉진과 탈삼각화 촉진

5) 개입 방법

- 가족의 정서 관계와 증상 발현의 맥락을 이해하기 위해 가계도를 주요 치료기법으로 사용함
- 가계도를 통한 가족정서체계 평가, 불안과 정서적 반응성을 낮춤, 치료적 삼각관계와 코칭을 통한 가족원의 자기 분화 촉진

◆ 경험적 모델

1) 대표인물

- 사티어(Satir), 휘태커(Whitaker)

2) 주제

- 미해결된 주제가 문제가 되어 현재의 기능을 방해하므로 이것을 지금-여기에서 경험하고 작업하여 일치적으로 만듦

3) 주요 개념

- 가족치료가 이론에 근거하기보다 치료자의 개방성과 진실성, 그리고 직관을 기초로 내담자

와 자연스럽게 관계를 맺는 것으로 시작해야 함을 강조함
- 자아존중감, 가족규칙, 의사소통 및 대처유형, 자기 선택과 결정
4) 치료 목표
- 자아존중감 증진, 선택능력 향상, 책임감 소유, 일치적인 존재가 되는 것
- 치료과정을 통해 내담자가 분명하게 의사소통하고 따듯함과 보살핌을 경험하도록 도움
5) 개입 방법
- 빙산 탐색, 가족규칙, 가족조각, 유머, 원가족 도표, 의시소통, 명상 등

◆ 구조적 모델
1) 대표인물
- 미누친(Minuchin), 아폰테(Aponte)
2) 주제
- 증상이나 문제는 가족의 역기능적 상호작용 구조에서 비롯됨
  ⇨ 따라서 가족의 재구조화를 통한 문제해결에 초점
3) 주요 개념
- 가족구조, 경계선, 하위체계, 위계구조, 연합, 동맹, 가족적응, 재구조화, 합류
- 가족구조는 눈에 보이지 않지만 가족의 상호작용을 반복적으로 관찰하다 보면 파악할 수 있는 가족의 기능
- 가족구조를 파악하기 위해 가족의 하위체계와 경계선, 위계구조를 살펴봄
4) 치료 목표
- 경계선 및 하위체계 기능 변화를 통한 역기능적 가족구조의 재구조화
5) 개입 방법
- 합류와 적응, 구조적 지도를 통한 가족평가, 가족재구조화 기법 활용
- 구조적 모델은 비행청소년 가족, 식이장애 가족, 약물중독이나 알코올중독자 가족 등에 효과 입증됨
- 구조적 모델은 이후 헤일리의 전략적 모델에 영향을 미침

◆ 전략적 모델
1) 대표인물
- 잭슨(Jackson), 헤일리(Haley)
2) 주제
- 헤일리, MRI(Mental Research Institute), 밀란 모델을 전략적 모델로 구분하며, 문제해결을 위한 치료자의 치료전략 고안과 지도적 위치를 중시함
3) 주요 개념
- 의사소통, 가족규칙, 권력과 통제, 가설설정-순환성-중립성
- 치료자가 치료목적을 정하고 치료목표 달성을 위해 효과적인 기법을 고안함
4) 치료 목표
- 증상을 지속시키는 역기능적 연쇄과정에 전략적으로 개입하여 단기간에 제시된 문제를 해

결함

5) 개입 방법

- 구체적인 문제 정의와 가설 설정, 가족의 연쇄과정 파악, 역설적 개입(고된 체험 기법, 위장 기법)을 통한 전략적 개입

2. 후기모델

◆ 해결중심 모델

❖ 포스트모더니즘의 확산으로 발전된 가족치료 후기 모델은 1980년대 중반부터 구체화됨

1) 대표인물

- 드 세이저(de Shazer), 버그(Berg)

2) 주제

- 내담자는 자기 문제의 전문가이며 문제해결 능력을 갖고 있다고 믿으며, 그의 장점, 자원, 성공적 경험을 활용하여 목표를 달성하도록 도움

3) 주요 개념

- 이론이나 규범을 벗어나 내담자 중심, 문제보다 해결에 초점을 둠
- 내담자의 장점이나 건강한 특성을 활용하여 해결책을 모색
- 치료자와 내담자 간 협력적 치료관계를 중시함
- 긍정적인 것에 관심, 강점과 자원 활용, 탈이론적, 현재와 미래에 초점, 변화의 불가피성, 단순하고 실현 가능한 해결방법을 먼저 사용, 알지 못함의 자세, 내담자에 대한 존중과 수용

4) 치료 목표

- 강점과 자원을 활용하고 문제가 없는 예외 상황을 찾아 문제를 협동적으로 해결함

5) 개입 방법

- 치료자-내담자 관계유형 파악, 해결 지향적 질문(상담 전 변화, 예외질문, 관계성질문, 악몽질문, 간접적인 칭찬 등)을 사용하여 목표를 설정하고 달성함

◆ 이야기치료

1) 대표인물

- 프리드만(Freedman), 짐머만(Zimmerman)

2) 주제

- 내담자 자신이나 주변인이 문제로 가득 찬 이야기를 내담자의 정체성과 동일시할 때 문제 발생
- 당사자의 삶의 지식과 목적이 담긴 대안적 이야기의 구축에 초점을 둠

3) 주요 개념

- 실재란 객관적으로 존재하는 것이 아니라 사회적 상호작용과 언어를 통해 개인이 구성하고 경험하는 의미의 세계로 봄
- 개인을 지배하여 왔던 문제중심의 지배적 이야기에서 벗어나 문제를 외현화하고 색다른 결

과를 발견하며, 새로운 시각에서 대안적인 삶의 이야기를 다시 쓰도록 도와주는 것
- 지배적 이야기, 색다른 결과, 대안적 이야기, 행동의 전망, 재진술

4) 치료 목표
- 문제이야기 해체, 부수적 이야기와 대안적 이야기의 풍부한 발달, 대안적 정체성의 구성과 사회적 공유

5) 개입 방법
- 외재화 대화, 독특한 결과 대화, 정의예식, 거푸집짓기(스케폴딩), 치료적 문서 활용

◆ 협력언어체계 모델(협력적 모델)

1) 대표인물
- 앤더슨(Anderson), 굴리시안(Goolishian)

2) 주제
- 동일한 상황에 대해 다양한 관점이 존재한다고 주장
- 자신과 타인에 대한 시각이 사회적으로 구성되거나 언어로 구성된다고 믿음
- 체계가 문제를 만들기도 보다는 문제가 체계를 만든다고 가정함

3) 주요 개념
- 협력적 대화, 알지 못함의 자세(not-knowing posture), 불확실성, 잠정적인 태도

4) 치료 목표
- 특정한 기법이나 틀을 갖지 않고, 치료자가 내담자와 공감적이고 보살핌의 대화를 하면서 새로운 의미를 찾도록 함

5) 개입 방법
- 반영팀(관찰실에서 상담 장면을 관찰하던 치료 팀의 생각과 느낌을 내담자와 그 가족이 듣도록 함)

2주차 1교시	가족의 개념과 가족의 기능	
	수업목표	가족의 개념을 설명할 수 있고 다양한 가족의 기능을 나열할 수 있다.
	세부내용	1. 가족의 개념 2. 가족의 기능 3. 가정생활 건강성과 심리적 안녕감

1. 가족의 개념

◆ 가족의 개념

- 가족은 사회조직의 가장 기본적인 집단인 동시에 한 인간이 사회의 구성원으로 살아가기 위한 사회화 과정의 기초 조건이 됨
- 가족을 통한 기능은 자녀의 양육과 가족 구성원 각각의 정신적, 정서적, 신체적 건강을 유지하고 능력을 개발시키며, 자아실현을 도모하는 본질적 기능을 수행하는 동시에 사회적 책임을 다하고 인격 형성을 완성함
- 이상적 가정은 각종 사회문제를 예방할 수 있고 문제를 치유받는 곳
- 인간의 기본적 인성은 가족관계를 통하여 형성되고 발달하므로 가족과 가족관계가 사회의 상호작용의 기초를 형성하는 것임에 틀림없음
- 가족은 사회의 가장 작은 단위이기도 하므로 가족이 그 기능을 다하고 올바른 가족관계가 형성될 때 선순환으로 사회적으로도 커다란 에너지가 될 것임

◆ 가족관계와 인간의 성장

- 가족관의 상호작용 관계를 통하여 개인은 성장함
- 가족 구성원간 갈등이나 사회적 관계, 경제관계, 심리적 상황은 다른 구성원에게도 영향을 미치게 되므로 가족간의 관계는 매우 중요함

⇨ 따라서 가정은 가족의 구성원들에게 성장을 위한 터전이 되어야 하며 관계 속에서 신뢰감을 배우고 자율성과 균형을 배우는 것이어야 함

⇨ 현대사회에서의 각종 가족 문제는 개인의 가족 내에서의 문제뿐 아니라 사회적인 차원에서도 중요하게 인식되어야 함

2. 가족의 기능

◆ 전통적 관점

- 가족은 성이 다른 두 사람의 성인과 그들이 출산한 자녀들이 물리적 거주지를 공유하고 상호 간에 동의한 목표를 지니는 사회적 체계
- 두 사람의 성인 사이의 헌신적 관계로 시작됨

◆ **현대적 관점**

- 가족에 대한 신념과 가치관이 급변하고 있어 전통적 개념의 수정이 요구됨
- 가족은 '무엇인가'보다 '무엇을' 가족으로 볼 수 있는가에 초점을 둠

❖ 스트롱(Strong)과 디볼트(DeVault) : 가족이 담당하는 기능

1) 친밀한 관계의 근원을 제공
   - 현대사회에서 타인과 개인적 수준에서 친밀성을 공유하는 것은 쉬운 일이 아님
   - 가족체계 내에서 서로를 완전히 노출한 상태에서 파트너와 희망을 공유하고 자녀를 양육하면서 나이를 먹어감
2) 경제적 협조의 단위
   - 생산기능과 소비기능 모두를 담당
3) 자녀를 출산하고 그들을 사회화시킴
   - 가족의 기능은 인간을 인간답게 만드는 중요한 역할
4) 가족구성원에게 지위와 사회적 역할을 할당함
   - 가족구성원으로서의 다양한 역할 수행을 통해 개인적 및 사회적 정체감의 많은 부분이 형성됨

❖ 패터슨(Pattertson) : 가족의 기능

1) 재생산과 가족집단 형성 기능
   - 가족구성원을 재생산하여 사회가 유지되도록 함
   - 가족이라는 친밀한 집단에서 소속감과 정체성을 확보하게 함
2) 경제지지 기능
   - 개인에게 필요한 경제적 자원과 물질을 제공하여 사회구성원으로서의 건강한 성장을 지원함
3) 양육, 교육과 사회화의 기능
   - 개인의 신체적, 정신적, 심리적, 사회적 발달과 사회의 가치관과 규범을 교육함
4) 노약자 보호 기능
   - 가족의 노인과 아동, 장애인 등 가족 내의 노약자에 대한 보호 및 돌봄 기능을 하여 사회적 부담 경감

⇨ 따라서 가족의 기능은

- 가족구성원을 재생산하여 사회가 유지되도록 하는 '가족 재생산 기능'
- 가족구성원 개개인에게 필요한 경제적 자원과 물질을 제공하는 '경제지지 기능'
- 가족구성원에서 지위와 사회적 역할을 할당하는 '사회화 기능'
- 가족구성원에게 친밀한 관계의 근원을 제공하는 '정서적 기능'
- 노약자를 보호하는 '돌봄과 복지 기능'을 함

3. 가정생활 건강성과 심리적 안녕감

◆ **가정생활 건강성**

- 가정생활건강의 구성요인은 유대감, 시간공유, 의사소통, 위기대처능력이며 이는 심리적 안

녕감에 영향을 미침

1) 가족유대감

- 가족간의 친근감

2) 시간공유

- 가족단위의 여가생활과 공동의 관심사 및 함께 보내는 시간의 유익성

3) 의사소통

- 상대방의 이야기에 경청하는 정도, 수용 및 타협의 정도, 솔직성의 정도

4) 위기대처능력

- 위기문제에 당면한 상황에서의 태도, 인내심, 해결노력, 자원공유 등

◆ 심리적 안녕감

- 가정생활건강의 구성요인은 유대감, 시간공유, 의사소통, 위기대처능력이며 이는 심리적 안녕감에 영향을 미침

1) 심리적 안녕감

- 일상생활의 사건에 사람들이 적응하면서 느끼는 정서이며, 환경의 자극이나 개인의 반응 사이의 상호작용의 결과로 개인이 지각하는 총체적 감정

• 이러한 인간의 심리적 안녕감은 가정으로부터 형성되는 개념으로 가족 간의 관계는 심리적 건강과 밀접하게 관련되어 있음

2주차 2교시	가족체계의 역기능	
	수업목표	가족체계에서 발생할 수 있는 역기능 상황을 설명하는 용어를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족체계의 특징 2. 역기능적 의사소통

1. 가족체계의 특징

◆ 가족체계

- 가족은 다양한 체계로 구성이 되어 있고 가족 체계는 다른 체계와 구별되는 특징이 있음

1) 체계와 하위체계

- 체계는 상호작용하는 부분들의 집합이며 체계는 여러 수준이 있음
- 더 높은 수준을 상위체계, 더 낮은 수준을 하위체계라 함
  · 가족의 하위체계는 부부, 부모, 부모-자녀, 형제자매 하위체계로 구분

2) 전체성-전체는 부분의 합보다 크다

- 체계를 여러 가지 요소로 분해해서 이해하면 체계의 특성이 파괴됨
- 사람이라는 생명체는 신체의 각 기관을 합쳐놓은 것 이상인 것과 같음

3) 상호의존성

- 가족관계가 상호의존적이므로 가족문제의 핵심은 개별 가족 구성원에 있는 것이 아니라, 가족 구성원들의 관계적 상호작용 내에 있음
  · 마치 실로 연결된 모빌 같음

4) 순환적 인과관계

- 선형적 인과관계
  - 결과에 대한 선행 사건이 있고, 결과가 문제라면 선행사건(원인)을 찾아 교정하면 문제가 해결된다고 가정
    예) 아내가 잔소리를 하는 것이 남편이 술을 마셨기 때문이므로 남편이 술을 마시지 않으면 된다고 가정
- 순환적 인과관계
  - 원인과 결과는 서로 연결되어 있어서 마침표를 어디에 찍는가에 따라 원인도 달라질 수 있음
    예) 남편이 술 마시는 행동 이전에 또 어떤 원인, 월급을 줄어든 사건이 있었다고 가정. 이는 업무를 잘 이해하지 못했기 때문이고, 또 몸이 아파 일을 잘 할 수 없었음
  - 특정 원인을 구별해내는 것이 쉽지 않음

5) 피드백

- 피드백의 결과에 대해 체계가 어떻게 반응하는가에 따라 체계의 항상성(안정성)이 유지되기도 하고, 변화되기도 함
- 가족체계는 안정성을 유지하면서도 변화해야 함

- 자녀가 성장하면서 변화하기도 하고 생활주기의 시점마다 안정성이 유지되는 것이 필요하기도 함

• 부적 피드백
  - 안정성을 유지하는 방향
  - 피드백으로 인해서 정보나 활동의 양이 줄어든 경우
  - 안정 지향적이고 체계와 항상성을 유지하기 위해 체념하고 그대로 가려고 함

  예) 모험을 추구하는 사춘기 자녀에게 원래의 순종적이고 의존적인 행동을 요구하는 부모의 피드백

• 정적 피드백
  - 체계를 변화시키려는 방향
  - 피드백으로 인하여 정보나 활동(상호작용)의 양이 많아지는 경우

  예) 모험을 추구하는 사춘기 자녀에게 자율적이고 허용적인 방향의 부모의 피드백

  ⇨ 따라서 건강한 가족체계를 위해서는 부적 피드백과 정적 피드백이 적절하게 사용되어야 함

6) 의사소통

- 가족 구성원 간 상호작용은 의사소통 과정을 통해 이루어짐
- 가족치료에서는 어떤 메시지를 전달하였나보다, 동일한 내용의 메시지를 어떻게 전달하는가에 따라 메시지의 효과가 달라질 수 있음에 초점을 둠

  ※ 가족상담사가 의사소통을 보는 관점

  · 의사소통의 과정과 형태에 초점을 둠

  · 현재의 행동을 이해하기 위해 순환적 인과관계 측면에서 접근

2. 역기능적 의사소통

◆ 역기능적 의사소통

- 가족의 역기능은 경제적인 문제나 외부 환경보다 가족의 역기능적인 의사소통 패턴에 있음

  · 역기능적인 의사소통의 패턴은 가족 구성원을 두려움과 불안에 빠뜨리고, 이는 가족의 진정한 소통을 방해하여 가족의 건강하고 일관된 규칙 및 정체성 형성을 방해함
- 이러한 역기능 개념은 내면세계의 두려움과 불안에서 기인되며, 이것은 가족의 의사소통을 방해하며 가족을 위한 기준이나 지침을 마련하지 못하게 함
- 특히 이중구속 의사소통(대표적인 역기능적 의사소통 방식)은 조현병(정신분열증) 뿐 아니라 각종 임상적인 병리현상에 좋지 않은 영향을 미침

◆ 이중구속

- 상호 관계상의 어려움은 이중구속에서 일어나는 경우가 많음
- 전달되는 언어적 메시지와 비언어적 메시지가 서로 일치하지 않고 모순될 때, 어떤 메시지가 진짜 메시지인지 분간하지 못하고 적절한 반응을 할 수 없는 상황에 처하게 되어 정체성의 혼란을 경험하게 됨

예) 자녀가 어머니에게 “엄마 나 사랑해?”라고 물었을 때 어머니가 “사랑한다니까 왜 이렇게 달라붙어서 귀찮게 해. 사랑해! 됐지?” 라고 말했을 때 자녀는 어머니가 자신을 정말로 사랑하는지 아닌지 혼란스럽게 느끼게 됨

- 이러한 의사소통에 늘 노출되어 있는 경우 무기력을 느끼며 현실에 적응장애현상을 보임

◆ 부부 균열과 부부 불균형

1) 부부 균영(부부 분열)

- 부부가 서로 역할을 교환할 수 없고 목표를 공유하거나 보완할 수 없는 상황 (부부가 서로 힘이 거의 동등한 경우)
- 부부가 자신의 욕구를 충족시키기 위해 서로의 가치를 격하시키고 상대방을 손상시키는 것
- 행복한 부부관계는 부부의 역할이 서로 균형을 이룰 때 이루어짐

예) 부부가 서로 자녀를 자기편을 만들기 위해 선물, 애정공세 등을 이용해 경쟁하는 경우

2) 부부 불균형(부부 왜곡)

- 부부간의 권력이 지나치게 불균형을 이룬 상황으로, 부부 중 한 사람은 강하고 다른 한 사람은 약한 위치에 있는 경우(한쪽이 힘이 많고 다른 쪽은 의존적인 경우)

예) 아버지가 권위적, 폭력이거나 경제력이 있어서 어머니가 아버지의 눈치를 보면서 의존적인 역할을 하는 경우

◆ 거짓 적대성과 거짓 상호성

1) 거짓 적대성

- 행복한 부부관계는 부부의 역할이 서로 균형을 이룰 때 이루어짐

예) 부부가 상대방의 애정을 바라는 마음을 감추고, 애정을 주지 않는 상대 배우자를 과도하게 비난하는 경우“저 인간하고 더 이상 못 살아요. 미워 죽겠어요”(진심은 상대의 애정을 갈구함)

2) 거짓 상호성(거짓 상보성)

- 가짜 친밀감. 겉으로 드러난 가족원 간의 친밀한 상호작용이 거짓인 경우
  - 가족원 개인의 정체성을 인정하면 가족 전체의 결속에 방해가 된다고 믿어서, 자신의 생각이나 느낌을 표현하지 않으면서 서로 친밀한 것처럼 행동함
  - 친밀한 모습에 지나치게 몰두하거나, 갈등을 표현하기를 두려워하여 역할에 융통성이 없고 자발성이 부족함
  - 가족원 개인의 정체성과 독자성을 찾으려는 시도는 무시되고 가족이 무조건 함께해야 함
- 가족이 내면의 갈등이 있음에도 겉으로는 좋은 관계를 맺고 있는 것으로 보여짐으로써 자신과 타인을 속이는 경우
  - 내면세계의 부정적 감정과 이기적인 생각, 관계 갈등 대신 자신과 배우자, 다른 사람들에게 미소와 농담, 함께 하는 행동으로 위장하여 위선적 행동이 습관으로 굳어지고 결국 지치게 됨
  - 기능적인 관계를 위해서는 자신을 합리화하고 잘못을 상대의 탓으로 돌렸던 것을 인정하고, 서로를 존중하고 예의를 갖추어 진정한 관계를 맺는 것이 필요함

- 개인의 내적 갈등을 감추고 친밀한 결속을 보이려는 경우
  예) 아들 : 엄마, 그 모임 저 못 가요. 숙제해야 해요엄마 : 가족동반 모임인데 네가 빠지면 다른 사람들이 우리 가족을 이상하게 볼 거야. 그러니까 꼭 같이 가야해

◆ 고무울타리

- 문제를 깨닫고 변화를 시도하지만 습관과 가족 항상성으로 인하여 필요에 따라 피드백을 받아들인 듯하여 늘어났다가 줄어드는 것
- 가족에게 허용할 수 있는 행동이나 정보는 받아들여지지만, 허용할 수 없는 정보는 폐쇄하여 배척하기 때문에 가족의 경계가 바뀌게 되고, 고무가 늘어났다 줄었다 하는 것
  ※ 경계선
  · 가족체계는 경계선에 의해 다른 가족체계나 사회체계들과 구분됨
  · 가족 내의 경계는 투명성과 융통성에 따라 모호한 경계선, 명확한 경계선, 경직된 경계선으로 구분됨 건강하지 못한 경계(경직된 경계선 = 가족체계가 정보의 유입과 분출을 제대로 수행하지 못함, 모호한 경계 = 경계가 지나치게 개방되어 정체성을 잃음)를 가지고 있으면 가족이 역기능적으로 상호작용하게 됨
  ⇨ 따라서 명확한 경계선을 가지고 유용한 정보와 의사소통을 수용하고, 해로운 것을 배출하는 자율통제기능이 원활할 때 가족이 건강해짐

◆ 결론

- 따라서 가족상담사는 문제의 대상자들이 상호 감정을 자제하고 나 전달법을 통하여 비난을 피하면서도 정확하고 일치되며 일관적인 메시지를 전달하는 방식에 주의를 기울여 개입해야 함

2주차 3교시	가족문제에 대한 관점과 가족문제의 원인	
	수업목표	가족위기론과 가족진보론 입장에서 가족문제를 살펴보고 가족문제의 발생원인을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족문제를 보는 관점 2. 가족문제의 원인

1. 가족문제를 보는 관점

◆ 가족문제를 보는 관점

- 가족의 구조와 가족의 기능의 변화 등 가족의 변화를 위기라고 보는 가족위기론
- 사회의 변화와 함께 변화하는 것은 자연스러운 것이라고 보는 가족진보론

◆ 가족위기론

- 가족의 위기는 단순한 표면적 변화를 말하는 것이 아니라 근본적인 구조 및 기능상의 쇠퇴와 그에 따른 삶의 방식에서의 혼란과 갈등을 의미함

1) 가족위기론자의 특징

① 가족 변화의 원인을 극단적인 개인주의와 이기주의 및 인간의 쾌락주의에서 찾음
  · 현대사회에서 개인을 중시하고 가족유대보다 개인의 자아실현을 가치있게 보는 사회적 분위기 확산을 지적
  · 결혼을 하더라도 자녀양육의 번거로움을 피하기 위한 자발적인 무자녀 부부의 증가, 자녀의 복리보다 스스로의 행복을 중시하는 경향

② 아동의 빈곤을 가장 심각한 문제 중 하나로 제기함
  · 가족의 해체로 아동이 빈곤하게 되는 경우가 많고 이로 인한 아동의 고통과 어려움을 지적

③ 중심적인 가족가치로 전통적 가족구조에 기초한 정서적 유대와 상호의존성에 의한 가족안정성
  · 가족만이 제공할 수 있다고 생각하는 특별한 정서적 유대가 흔들리고 그것을 대체할 수 있는 다른 인간관계나 사회제도가 등장하지 않는 상황에서 한부모가족, 동거부부, 동성애 부부 등 새로운 가족형태는 극단적인 일탈 혹은 병리적 현상으로 간주

④ 이혼 후 형성된 한부모 여성가장가구의 빈곤 문제를 해결하기 위한 국가의 짐이 늘어나 국가 재정이 낭비되고 있다고 비판

⑤ 전형적 가족을 강조하려는 경향이 강하고 정상가족에 대한 신화를 바탕으로 함
  · 정상가족 : 남성=생계부양, 여성=가족보호

⑥ 정상가족을 강조하여 여성의 권한을 제한하고 종래의 성별 역할을 지속시켜 나갈 수 있는 방안을 강력하게 주장함

◆ **가족진보론**

1) 가족진보론의 입장과 특성

① 전통적 가족의 위계를 거부하고 민주적인 가족관계를 형성시켜야 함

· 이를 위해 가족구조는 변화하고 다양화되어야 함

② 가족의 구조가 변화한 것은 종래의 가부장제적 가족구조와 경제구조의 불안정성 때문

· 성과 연령에 의한 불평등한 역할 및 기능 수행을 의무로 했던 가부장제적 가족으로부터 부부간 평등과 아동 및 개별 구성원의 개인적 권리가 존중되는 가족으로의 변화를 꾀함

· 한부모가족, 동거부부, 동성애 부부 등 비전형적 가족은 비정상가족이 아니라 현대사회의 대안가족이 될 수 있음을 강조

③ 경제구조의 다원화와 불안정성이 가족의 변화를 이끌어다고 주장

· 남성 가장의 수입만으로 가족을 부양할 수 없는 경제구조와 고용형태의 변화를 강조

④ 가족해체로 인한 아동빈곤 문제는 가족의 문제가 아니라, 여성과 남성의 임금 불평등에 기인한다고 봄

· 편부 가족은 편모 가족에 비해 빈곤 문제가 적음

⑤ 가족해체로 인한 자녀의 정서적, 심리적 어려움은 이혼 이후에도 지속적인 만남을 통해 극복할 수 있고, 사회적 차원의 개입을 통해 해결할 수 있음

⑥ 이혼은 불행이 아니라, 불행한 결혼을 청산하고 새로운 삶의 기회를 모색하는 것

⑦ 남녀평등의 관계가 이상적인 부부관계

⇨ 즉, 사회문화의 변화에 따라 가족의 변화를 보는 시각이 달라지고, 그에 따라 가족문제의 원인에 대한 시각과 해결방법도 영향을 받음

◆ **가족위기론과 가족진보론의 쟁점별 비교**

대립적 관점 / 쟁점	가족위기론	가족진보론
가족 변화의 원인	극단적인 개인주의, 이기주의, 쾌락주의	가부장제의 모순과 자본주의 경제구조의 불안정성
이상적 가족형태	남성=생계부양, 여성=가족보호라는 성별 분업에 기초한 핵가족	존재하지 않음
중심적 가족가치	가족공동체, 특별한 정서적 유대, 상호의존	개인적 만족, 자기발전, 자율성과 독립성
이상적 부부관계	남성=생계부양, 여성=가족보호라는 성별 분업에 기초한 남성중심적 동반자 관계	가족보호와 노동에 대한 남녀평등 중심의 동업자 관계
새로운 가족 유형에 대한 입장	가족제도의 위기 증후	대안적 가족형태
대안	전통적 가족가치의 회복, 분명한 성역할 정립	적극적 사회복지정책을 통한 가족기능의 사회화

2. 가족문제의 원인

◆ **가족문제의 원인**

- 가족이 건강함을 유지하지 못했을 경우 발생하는 문제는 다양함

1) 가족구조상의 특성

- 결손가족이나 가족 구성원상의 문제가 발생하는 경우 구조적으로 문제가 발생할 수 있음
  예) 이혼 및 재혼 가족, 미혼모 가족, 노인 및 독거 가족, 소년소녀가족 등

2) 가족기능상의 문제

- 부부체계, 부모자녀관계, 형제관계 등으로 인하여 가족의 문제가 발생할 수 있음
  예) 약물중독 가족, 알코올 가족, 비행청소년 가족, 저소득 가족, 병리적인 의사소통의 체계를 가지거나 경제적 측면의 기능상의 결손 혹은 장애로 인한 심리적이거나 의료학적인 문제를 가지고 있는 가족 등 다양함

3) 사회 환경적인 문제

- 신빈곤 문제로 워킹푸어 혹은 신빈곤의 문제가 발생할 수 있고, 사회적 분위기에 따라 교육적 가치관의 문제로 인한 가족 내 갈등이 발생할 수 있음
  · 이상성격이나 중독 및 경제적 문제는 가족의 해체와 연결될 수 있으므로 이에 대한 세심한 가족치료학적인 개입이 필요함

4) 상호작용의 문제

- 가족의 가치관적 접근이나 의사소통의 역기능적 순환으로 인한 갈등과 부정적 거부감 등의 고착

5) 가족생활주기에 따른 문제

- 가족생활주기의 전환기에 문제가 발생할 수 있음
  예) 가족생활주기는 신혼부부기, 자녀출산기, 자녀 양육기, 미취학 및 아동기, 청소년기, 자녀 독립기, 중년기, 노년기 등이 있고, 이전 주기에서 다음 주기로 전환될 때 역할이나 기능의 변화로 인해 문제가 발생할 수 있음

- 급격한 산업화로 인해 여권이 신장하였으나, 가정 내 가부장적 문화가 남아있어 부부역할 등에 갈등이 발생함
- 여성의 경제활동 참여의 증가와 도시화 이후 개인주의적 관점은 전통적 가족역할과 상충하는 부분이 있어 각종 가족문제에 대한 이해가 필요함
- 특히 현대사회에서 이혼 등으로 인한 결손가정의 증가에 따른 가족 구성원의 심리 및 정서적 소외 문제 등 발생할 수 있음

3주차 1교시	한국 가족의 특성	
	수업목표	현재 한국 가족의 현황을 다양한 통계자료를 통해 확인하고 한국 가족문화에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 한국 가족구조의 현황 2. 한국 가족의 특징

1. 한국 가족구조의 현황

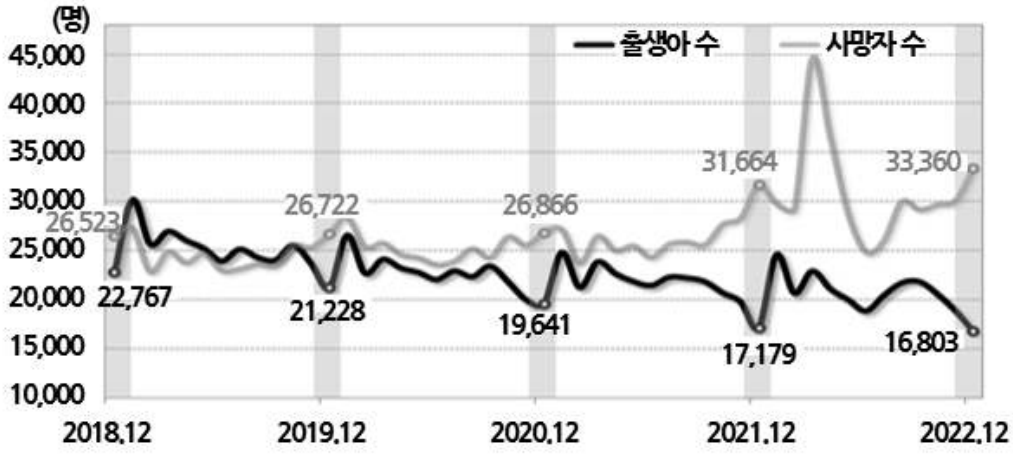
◆ 가족 구조의 변화

- 산업화 과정에서 나타난 가족분화와 핵가족화 현상
- 가족으로부터의 독립 증가(1인 가구 증가)
- 가족결손이나 가족해체로 인한 단독가구의 증가

1) 가족규모의 축소

- 2022년 12월 기준 사망자수가 출생아수보다 더 많음
- 우리나라의 인구는 2020년부터 감소하고 있음

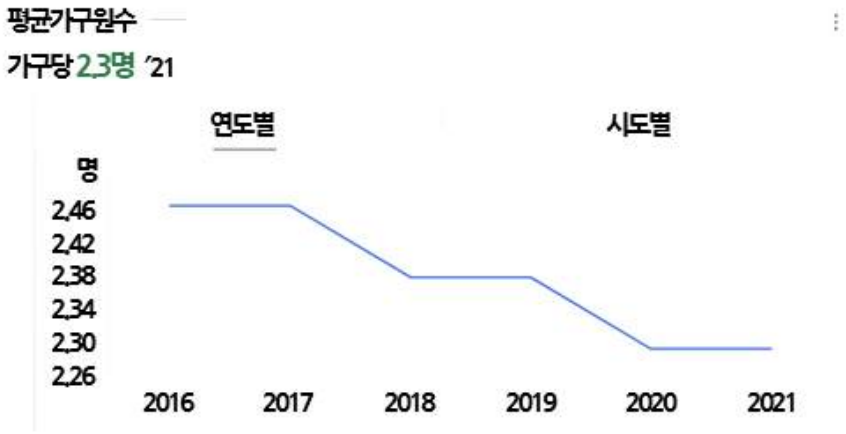
• 출생·사망



• 평균가구원 수

· '21년 가구당 평균 가구원 수는 2.3명으로 1인 가구 및 2인 가구의 비중은 커지고, 3인 이상 가구의 비중은 줄어듦

· 즉, 한국 가족의 규모는 축소하고 있고, 가족을 구성하는 구성원도 달라지고 있음



※ 평균가구원수란? 한 주택에 살면서 취사, 취침 등 생계를 같이하는 가구 내 평균 구성원의 수(일반가구 기준)

❖ 출처 : KOSIS(통계청, 인구총조사)

- 1인 가구 비율



❖ 출처 : KOSIS(통계청, 인구총조사)

· 1인 가구 증가원인
  - 고령화에 따른 독거노인의 증가
  - 비혼과 만혼의 증가
  - 베이비부머 세대가 65세로 진입하면서 고령 가구가 늘어나고, 황혼 이혼의 증가로 30년 후에는 65세 이상 고령자 1인 가구가 증가할 전망
  - 1인 가구 비중은 꾸준히 증가할 전망

2) 여성 가구주의 증가

- 1인 가구 증가(여성 1인 가구 증가)
- 이혼 증가로 인한 모자 가족의 증가
- 여성 노년 1인 가구 증가

3) 다양한 구조의 가족 증가
- 한부모 가족, 조손 가족, 부부 가족, 다문화가족 증가

2. 한국 가족의 특징

◆ 가족관의 변화
- 전통적인 가족의 기능이 약화되며, 가족관도 변화함
- 가족의 보호기능, 양육 기능 등이 약화되고, 이러한 기능이 사회화되고 있음
· 결혼 및 혈연에 의한 가족제도에 대한 다양한 인식 : 동거가족 및 동성애가족 증가, 반려동물을 가족구성원으로 인식
· 가족부양의 책임, 가족 보호의 책임 등을 아버지가 가장으로 혼자 감당해야 한다는 의식의 변화 : 맞벌이 가구 증가, 자녀양육과 가사노동에 참여하는 남성 증가
· 가족의 보호기능과 정서적지지 기능의 약화로 인해 부모 : 자녀관계의 약화와 아동 및 청소년의 정신건강에 문제 증가

◆ 부모 자녀 간 장기간의 밀착관계
- 맹목적으로 자녀를 보호하고 간섭하고 자녀를 위해 희생하며 훌륭한 교육을 받게 하는 데 열성적임
• 밀착관계 가족의 특성
  · 부모 : 부모 위주로 자녀의 장래를 계획하고 자녀의 결혼과 결혼생활에 관여하며 부모에게 순종하고 효도하기를 바람
  · 자녀 : 정서적으로 독립하지 못함 성인이 되어서도 부모의 희생과 간섭을 당연시하며 지원을 기대하는 경향이 있음
  · 결과 : 부모와 자녀관계에서 호혜적 교환이 이루어지지 않으면 갈등 발생
- 노부모는 자녀의 공경과 부양에 불만과 소외감을 느낌. 자녀는 부모의 과도한 의존과 통제, 간섭으로 부담을 느낌
  ⇨ 따라서 부부 모두가 원가족에서 심리적, 경제적으로 독립하여 서로에게 적응하고 새로운 가족문화를 만들어가야 할 것임

◆ 가족원 간 의사소통방법의 특성
- 전통 가족 : 의사결정방법은 엄격한 위계 구조에 의하여 권위자가 일방적으로 결정하고 아랫사람은 순종하는 형태
- 유교의 영향으로 부부간, 부모 자녀 간 감정표현이나 애정표현은 억제되었기 때문에 감정표현은 간접적으로 함
• 성별에 따른 대화의 특성
  · 남성 : 타인의 말을 경청하지 않음 자기 할 말만 함
  · 여성 : 말하지 않아도 다 알아주기를 바람

◆ **가족문제에 대한 인식과 대처방법에서 가족주의 문화가 반영**

- 가족주의라는 집단주의가 지배하였기 때문에, 개인의 행동은 소속된 가족이나 집안의 품격과 분위기를 반영하는 것으로 인식되었음
- 체면에 가치기준을 두었고, 가족원간의 갈등이나 근심, 걱정 등은 집밖에 노출되지 않게 하였음

  ⇨ 개인의 행복과 발전, 자아실현에 비중을 두기보다는 가문의가족문제가 만성화되고 심각해짐 예) 화병, 노년기 이혼, 은폐된 가정폭력 등

  또한 이에 대한 사회적 대처도 소극적임 예) 가정폭력에 대한 경찰의 미온적인 대처, 자녀 학대에 대해 부모의 의견을 존중하고 적극적으로 대처하지 못함

1) 성별에 따른 문제 인식과 대처방법의 차이

- 남성
  - 집안문제의 발생은 가장이 무능하여 잘 다스리지 못한 결과이므로, 외부에 도움을 요청하는 것을 수치스럽게 여김
  - 슬픔, 긴장, 두려움, 불안, 분노 등의 감정들을 음주나 흡연으로 해소하거나 회피하고 참는 방법을 많이 사용하고, 때로 폭발적(폭력)으로 표현하기도 함
- 여성
  - 갈등이나 문제를 직접 해결하기보다는 참거나 억누르고, 가까운 사람에게 푸념하는 등의 방법으로 해소
  - 외부 도움을 요청하는 데 더 적극적임

2) 남성의 문화 지체 현상

- 남성은 남성우월사상과 가부장적 가치관에서 쉽게 벗어나지 못하고 있음
- 여성의 사회참여가 많아지면서 여성은 가사분담과 역할 공유를 기대하지만 남성은 역할분리를 고수하고 아내에게 수퍼우먼을 기대하여 부부간 불화와 무자녀 가족, 저출산 문제가 발생할 수 있음
  - 맞벌이 부부 가사노동 시간 남편 17분 vs. 아내 129분(통계청, 2019)

◆ **다양한 가족유형의 변화에 따른 다양한 지원 요구**

- 가족구조가 다양해지면서 가족들이 원하는 지원도 다양해짐

3주차 2교시	가족문제의 유형과 한국 가족관련 문제	
	수업목표	가족문제를 유형화 하여 분류할 수 있고 한국 가족관련 문제를 나열할 수 있다.
	세부내용	1. 가족문제의 유형 2. 한국 가족 관련 문제

1. 가족문제의 유형

◆ 가족문제의 유형

- 가족문제는 발생 원인과 그 파급효과에 의해 크게 두 가지 차원으로 구분할 수 있음

◆ 미시적 차원의 가족문제

- 결혼생활과 부부 및 부모-자녀관계에서 비롯되는 가족 내적 문제들에 의한 미시적 차원의 가족 문제

• 발생 가능한 문제

- 가족 내적 갈등이나 가족 관계, 가족주기와 연관되어 가족구성원의 역할을 둘러싼 긴장 및 갈등
- 이러한 갈등은 주로 개인이나 가족내적 범주로 제한되어 나타남

1) 미시적 차원의 가족문제의 유형

① 구조적 문제 : 부모결손, 편부 또는 편모, 재혼문제, 무자녀, 외도, 정신질환자, 신체적 병자, 별거, 부모부양문제, 이혼 등

② 의사소통 : 대화 부족, 표현 부족, 불일치 및 이중적 태도, 무시, 불신 태도

③ 역할 : 경제문제, 실업문제, 경제적 무능력, 주거문제, 자녀 교육, 양육 및 훈육문제, 가사문제, 건강문제, 성역할, 효도 부족, 모범 보이지 못함, 역할회피, 능력 부족, 자기관리 부족 등

④ 위계 : 부모의 방임적 태도, 권위적 태도, 가부장적 태도, 신체 및 언어 폭력, 동맹과 소외, 말다툼, 비난, 싸움, 경쟁, 갈등(부부갈등, 고부갈등, 관계갈등), 버릇없음 등

⑤ 경계 : 가족공동행사 부족, 여가활동 부족, 정서유대 및 지지부족, 책임회피, 과잉보호, 간섭, 통제, 억압, 강요, 개인적 미성숙 등

⑥ 규칙 : 원칙 부족, 양보 부족, 강요, 종교문제(부모 종교 강요, 형식적 생활) 등

⑦ 생활주기 : 문제 해결 및 개선 부족, 학업 및 진로, 결혼문제, 이성문제, 노후 문제 등

◆ 거시적 차원의 가족 문제

- 가족문제는 가족의 공동체적 생활과 직간접적인 관련이 있는 여타의 사회제도나 환경의 변화 혹은 그러한 환경과의 마찰에 의해 발생됨

  예) 경제적 불평등, 고용기회 제한, 보건의료 기회의 제한, 주택문제, 교육기회 제한, 기타 사회자원의 제한 등과 같은 가족 외적 요인에 의해 가족 문제가 발생되는 것

- 가족이 사회환경과의 상호작용에서 수반되는 빈곤, 제도와의 괴리, 변화에의 지체 등 가족이 사회환경과 유기적으로 상호작용을 이루는데 있어서 결손이나 부적응의 일어나는 것

⇨ 가족체계 내 부부와 아동 등 가족구성원들이 기능적이지 못함으로써 발생하는 문제는 가족 내적 문제

⇨ 가족을 둘러싼 환경의 부적응이나 결손은 가족 외적 또는 가족의 구조적 문제

2. 한국 가족 관련 문제

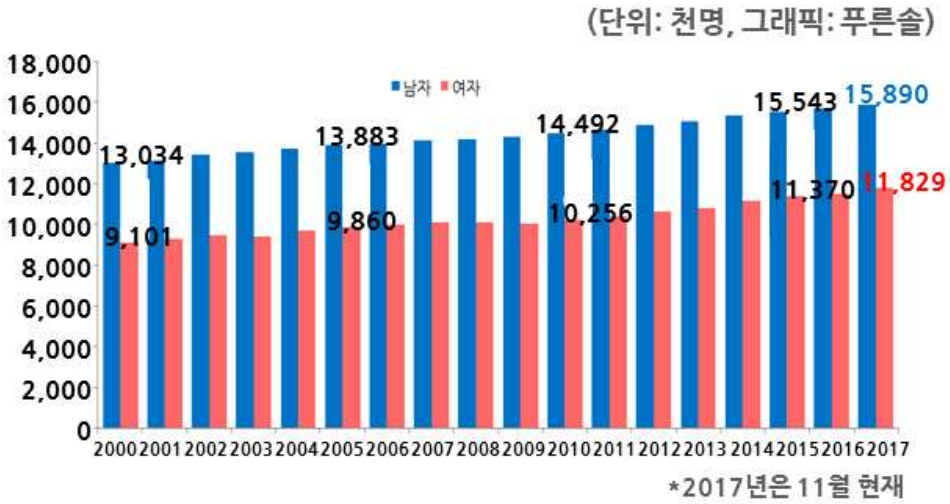
◆ 가족을 둘러싼 사회변화

- 여성의 노동시장 진출 증가, 저출산, 고령화, 세계화, 혼인율 감소 등

1) 여성의 노동시장 참여 증가

- 산업화의 증가, 여성의 학력 상승 등으로 여성의 경제활동 참가율은 꾸준히 증가
- 여성 1인 가구 증가, 이혼 및 사별로 인한 여성 가장은 경제활동에 비자발적 참여하게 됨

• 성별 경제활동인구



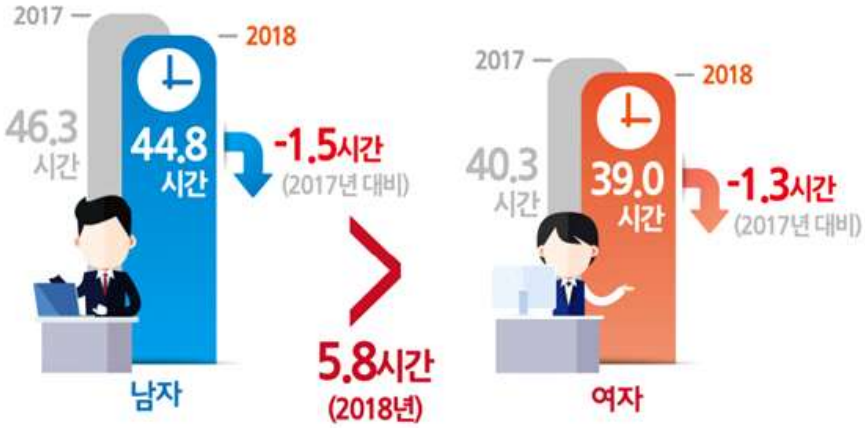
❖ 출처 : 통계청, 2017 경제활동인구, 그래픽 https://blog.naver.com/fishes1272/221177403306

• 맞벌이 유무별 비중



❖ 출처 : 통계청, 2017 경제활동인구, 그래픽 https://blog.naver.com/fishes1272/221177403306

• 맞벌이 부부의 주당 평균 취업시간



❖ 출처 : 통계청, 2017 경제활동인구, 그래픽 https://blog.naver.com/fishes1272/221177403306

- 그러나 한국의 경우 맞벌이 보다 비맞벌이가 많은데, 출산으로 인한 경력단절 여성이 많고, 출산과 함께 경제활동을 하지 않게 되는 경우도 많음(자발적, 비자발적 요인)
- 자녀 돌봄에 공백 발생
- 부부간 가사 노동의 불평등
- OECD 국가 중 여성 취업률이 꼴찌!!

2) 고령화

- 노인인구의 증가와 함께 노인과 가족관계 문제가 증가함 (초고령화 사회 진입)
- 주 부양자였던 여성의 노동시장 진출이 증가하면서, 노인 돌봄에 있어서 사회화가 이루어지고 있음
- 평균수명 연장으로 인한 노인빈곤층의 증가로 노령인구의 경제활동에 대한 욕구 상승 등

3) 세계화

- 다문화가족의 증가
- 단일민족으로 구성된 한국사회에 외모가 다른 외국인, 또는 혼혈인에 대한 전통적인 부정적 시각이 여전히 남아있음 → 다름에 대한 수용 부족
- 자녀들과 결혼이민자 부모와의 갈등, 자녀들의 학교생활적응과 또래관계 문제 증가

4) 혼인 감소

- 만혼, 1인 가구 증가, 정서적 교감 부족, 부모와의 갈등, 1인 가구의 문제로 이어짐

• 혼인건수



◆ 한국 가족 문제의 성향

1) 여러 가치관의 혼재

- 한국인의 가족가치관에는 유교적, 도구주의적, 서정주의적, 개인주의적 가족가치관이 혼재해 있음
- 이에 더하여 최근에는 이들 가치관이 상호작용하여 독특한 혼합 · 변종적 가족가치관이 형성

⇨ 따라서 국가의 가족정책을 수립하는데 어려움이 있음

2) 경제적 부양의 문제

- 가족소득 문제, 빈곤무제, 생계형 맞벌이 증가, 가족 간 빈부 차이(상대적 빈곤감)

3) 가족의 돌봄 기능 약화

- 빠른 핵가족화, 1인 가구 증가, 주말 부부 증가, 자녀 수 감소, 주거생활의 변화, 맞벌이 가구 증가 등
- 어린 자녀의 돌봄과 노인 인구에 대한 돌봄의 사회화

4) 가족의 통제능력과 통제기능 약화, 가족공동체로서의 사회화, 정서적지지 기능 수행의 약화

- 도시에서의 잦은 이사로 인한 가족생활의 불안정, 세대차이 문제, 부부 불화, 부모역할 모델의 부족, 대화의 부족 등이 원활한 가족기능 수행에 문제를 일으킴

5) 결손가정의 증가에 따른 문제 발생

- 자녀유기, 별거, 이혼, 배우자 부정, 향락산업의 발달 등으로 결손가정이 발생하고, 그러한 가정 내에서 학대, 무관심 등으로 자녀의 정신건강 문제, 비행 등의 문제 발생

3주차 3교시	가족상담의 진행 절차	
	수업목표	가족상담이 진행되는 과정과 각 과정에서 수행해야 할 일에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족치료 개입 절차

1. 가족치료 개입 절차

◆ 가족치료 개입 절차

❖ 내담자 가족에 합류 ⇒ 증상의 정의 ⇒ 목표 설정 및 계획 ⇒ 변화전략의 개발과 적용 ⇒ 종결 및 추수상담

◆ 내담자 가족에 합류

• 합류 : 치료자가 가족 안에 들어가 그 가족의 상호작용 패턴에 적응하는 것으로, 가족의 재구조화에 영향력을 행사하기 위해서 실행함

- 치료자와 가족과의 합류와 적응은 재구조화의 전제 조건
- 치료자가 문제해결을 직접 하는 것이 아니라 가족구성원들이 자신들의 문제를 해결할 수 있도록 가족 구조를 수정하도록 도와줌
- 새로운 상호교류 패턴이 규칙적으로 반복되면서 그 패턴은 새롭고 더 효과적인 구조로 자기 잡게 됨

• 합류를 위한 가족치료사의 역할

· 내담자 가족으로부터 수용되어야 함
· 내담자 가족의 행동방식을 존중해야 함
· 문제에 대한 새롭고 건설적인 관점을 제공해야 함
· 개입 초기에 내담자에 대한 정확한 사정을 위하여 정보를 수집함
· 이 과정에서 언어적 의사소통뿐 아니라 비언어적 의사소통도 포함됨
· 상담을 시작하는 단계로 이 단계에서 내담자와 라포형성을 하는 것은 매우 중요한 과제
  * 라포형성 : 의사소통에서 상대방과 형성되는 친밀감 또는 신뢰관계
· 내담자와 충분한 라포형성이 이루어져야 이후 상담과정에서 감정이입, 수용, 지지, 공감 및 자기노출 등이 원활하게 이루어지고 협력관계 형성도 원활해짐

◆ 증상의 정의

- 증상은 여러 가지로 분류될 수 있음
- 자신이나 타인과의 관련 문제, 직장 및 사회환경의 문제, 가치, 규범 및 법의 문제 등
- 어떠한 문제든 명확하고 구체적으로 파악하고 정의해야 함
- 증상의 정의는 문제에 대한 개입방법에 영향을 미침
- 증상을 객관적으로 판단하기 위해 다양한 심리검사나 가족 면담, 가족 관찰 등을 통해 사정

을 하기도 함
- 검사결과를 함께 보며 가족들이 자신들의 문제를 객관적으로 볼 수 있는 기회를 가지게 되고, 문제를 인식하고 인정하는 계기가 되기도 함

◆ 목표 설정 및 계획
- 목표를 설정할 때에는 내담자가 동의가 필수
- 상담 전반에 대한 계획을 세우고 계약을 함 : 회기, 상담기간, 방문시간, 참여 가족구성원 등
  · 가족상담에 모든 가족이 항상 상담 회기에 참여하는 것은 아님. 가족 중 상담에 대한 거부감이 심할 경우 참여하지 않기도 하고, 상담에 가장 적극적이고 협조적인 가족구성원 한 명이 상담에 참여하기도 함
  · 가족은 순환구조라 한 명의 변화로 가족체계에 변화가 발생함
- 목표를 구체적이어야 함
- 가족상담의 목표는 가족의 가치, 욕구를 바탕으로 가족의 역기능적인 문제(의사소통, 신화, 정서분화)를 파악해 가족원들이 인식하도록 돕고, 가족의 생태변화와 구체적인 행동변화를 통해서 가족원의 관계와 가족체계의 기능을 향상시켜 문제증상이 완화되거나 해소되도록 하는데에 도움이 되는 것이어야 함
  ⇨ 즉, 전체적인 가족 기능의 향상 또는 개인을 둘러싼 가족의 역기능적인 문제를 중심으로 해결하도록 함

※ 가족상담 목표 설정 시 고려할 점
  · 가족이 상담을 통해서 달성하고 싶은 상태에 대해서 명확히 표현하도록 함
  · 단기목표와 장기목표를 구분함
  · 쉽게 달성할 수 있는 것을 설정하여 동기부여가 되도록 함
  · 가족원 간의 목표에 대한 합의가 필요함
  · 목표는 구체적이고 명확해야 함

※ 치료목표의 예
  · 가족의 신화를 버리고 융통성 있는 가족 규칙 만들기
    * 가족 신화 : 가족에 대한 자동적인 사고로 무비판적으로 수용하는 일종의 규칙
    예) '우리가족은 무조건 함께 주말을 보내야만 해', '우리가족은 집에서 절대 목소리를 높이면 안 되고, 비밀이 절대 있으면 안돼'
  · 세대 간 명확한 경계 설정 : 부부체계와 자녀체계의 명확한 경계 세우기
  · 기능적인 의사소통과 상호교류 활성화
  · 가족구성원들의 적절한 역할과 책임감 조성
  · 가족구성원 중 소외에서 벗어나 가족의 결속력 구축
  · 부부의 연합과 일관성 있는 양육방식 갖기

◆ 변화전략의 개발과 적용
- 변화에 대한 전략을 적용하여 목표달성을 위한 해결책의 효과성을 분석한 뒤에 이를 생활

속에서 안정화할 수 있도록 하는 이차적 변화전략의 단계가 도입되어야 함
- 이 단계에서 다양한 치료 기법들을 활용함
- 내담자가족은 자신의 문제를 해결하고 상담 목표를 달성하기 위해 어떤 개입하였는지에 대해 상담사와 상호 의논하고 확인함
  · 이 단계에서 다양한 이론적 접근과 그에 따른 치료기법을 적용하여 상담목표 달성을 위해 가족과 협력함(다세대 가족치료, 경험적 가족치료, 구조적 가족치료, 전략적 가족치료, 해결중심 가족치료, 이야기치료)

◆ 종결 및 추수상담
- 상호 합의한 상담 목표가 달성되고 문제 증상이 해결되었을 때 상담을 종결함
- 종결하기 전 가족의 상호작용이 적절한지, 문제 해결을 위한 기능이 향상되었는지 등을 살펴보아야 함
- 추수상담(추후상담)에 대한 논의

4주차 1교시	다세대 가족치료의 발달 배경과 주요 개념	
	수업목표	다세대 가족치료의 발달 배경과 주요 개념을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 보웬의 다세대 가족치료의 발달배경 2. 다세대 가족치료의 주요 개념 I

1. 보웬의 다세대 가족치료의 발달배경

◆ 보웬의 다세대 가족치료의 발달배경

❖ 보웬의 다세대 가족치료는 가족구성원의 변화가 가족 전체를 변화시킬 수 있다고 보는 체계론적 시각을 전제로 한 모델

- 이 모델은 가족과 자아 간의 미분화로 인해 불안이 가중되고 가족은 역기능적으로 기능하게 된다고 봄
- 따라서 가족 내 자아분화수준을 높이고, 탈삼각관계화 하는 것이 가족치료의 목표
- 정신의학 전공으로 조현병(정신분열증) 환자 모자를 관찰하면서 문제가 세대를 통하여 전달됨을 인식하게 됨
- 조현병 환자의 모자관계에서 불안애착과 불안격리의 정서적 긴장이 주기적으로 반복되는 병리적 애착을 발견함

• 모자공생
  · 어머니와 성인 조현병 자녀가 서로에 대한 정서적 개입이 지나치게 심한 나머지 별개의 두 사람이 아닌, 하나의 존재 또는 하나의 자아로 간주될 정도의 강한 정서애착을 갖고 있는 상태
  · 따라서 한 사람의 조현병 상태는 병리적인 가족체계의 증상

• 문제의 원인
  - 보웬은 가족문제의 원인을 가족의 정서과정이 세대를 관통하여 지속되며 이전 세대에서 정리되지 않은 문제가 다음 세대로 전해지면서 문제가 발생한다고 봄

• 상담의 목표
  - 여러 세대를 전수하는 가족의 정서적 과정을 이해하고 특정 가족원의 분화를 통해 가족체계의 변화를 성취하는 것

2. 다세대 가족치료의 주요개념 I

◆ 다세대 가족치료의 주요개념

보웬의 가족치료 모델은 8개의 상호연관된 개념으로 구성	
핵가족과 확대가족에서 일어나는 정서적 과정	① 자아분화, ② 삼각관계, ③ 핵가족 정서체계, ④ 가족투사과정, ⑤ 정서적 단절, ⑥ 다세대 전수과정
가족과 사회에서	⑦ 출생순위, ⑧ 사회적 정서과정

세대를 통해 일어나는 정서적 과정	

◆ **자아분화**

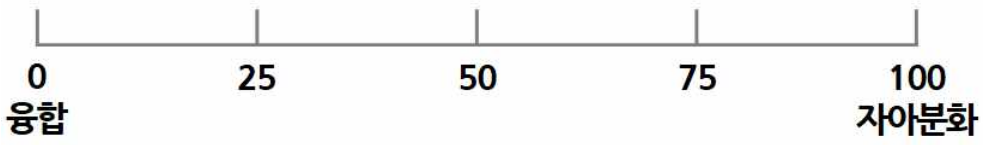
1) 자아분화의 개념

- 개인이 원가족의 정서적 융합에서 벗어나서 자기만의 방식으로 자율적으로 기능하게 되는 과정
- 사고로부터 감정을 분리할 수 있고, 타인과 구별되는 확신과 신념, 자주성을 지닌 정도를 의미함

• 정신 내적 측면
  - 사고기능이 감정기능에서 분리되는 정도를 의미
• 대인 관계적 측면
  - 다른 사람과 구별되는 신념과 자주적이고 독립적인 행동을 의미
• 분화된 사람의 특징
  - 사고와 감정이 균형을 이루어 감정적 자제력과 객관적 사고기능을 가짐
  - 타인과 차별되는 자신만의 독자적인 신념과 독립성을 유지하면서 타인과 친밀한 접촉을 유지함
• 분화되지 않은 사람의 특징
  - 감정으로부터 사고를 구별하기 어렵고 감정에 대한 자제력이 부족하며, 자신과 다른 사람을 분리하지 못함

2) 자아분화의 수준

- 자아분화 연속선 : 가족 자아군에서 얼마나 분화되어 있는가 살펴보는 방법



• 0~25
  · 가족 및 다른 사람에게 정서적으로 융합되어 자기 자신의 사고에 매몰되어 있음
  · 자신의 감정 상태에 따라 즉흥적인 행동, 감정반사적인 행동을 함
  · 자신의 생각, 느낌을 남에게 표현하는 데 어려움을 느낌
  · 융통성, 적응력 부족과 정서적으로 매우 의존적임
  · 스트레스 상황에서 쉽게 상처받음
• 25~50
  · 다른 사람의 정서적 체계와 반응에 민감하고 영향을 많이 받음
  · 융합의 정도가 심하지 않으나 관계 지향적
  · 인정받기 위하여 노력하고 의존적임
  · 타인의 사랑과 인정을 받는 경우 안정적이고 일관된 모습을 보여 주지만, 좌절을 경험할 때 불안하고 일관성 없는 모습을 보임
• 50~75

· 분명한 신념과 자율성을 갖고 독립적 의사결정 가능함
· 낮은 불안에 대한 대처능력은 있지만 불안 정도가 높으면 일시적으로 융합하려는 경향을 보임
· 낮은 불안 속에서 목표지향적 활동을 함
· 정서가 안정되고 감정에 지배당하지 않을 만큼 사고가 충분히 발달함
· 비교적 스트레스 대처능력이 뛰어나나 심한 스트레스 상황에서 일시적으로 융합하려는 경향

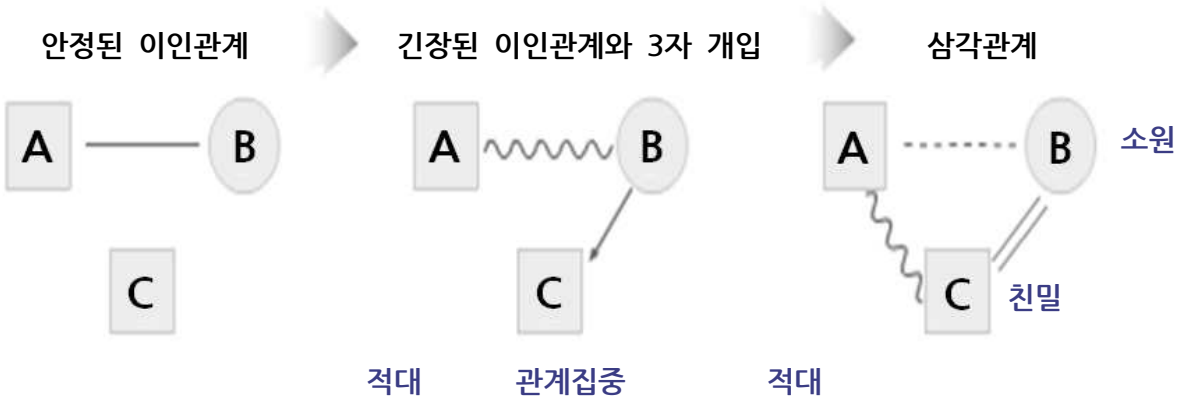
- 75~100
  · 높은 불안에 대한 대처능력 뛰어남
  · 자신의 삶에 대한 확고한 신념과 분명한 가치를 지님
  · 안정적, 자율적, 독립적, 융통성 있음
  · 감정과 사고 사이에 충분한 분화, 객관적 사고, 타인에 대한 존중과 수용
  · 심각한 갈등과 스트레스 상황에 대한 대처능력 있음

◆ 삼각관계

1) 삼각관계의 개념

- 두 사람 사이의 불안과 긴장을 해소하기 위하여 누군가를 끌어들이는 정서적 역동
- 보통 두 사람 관계는 아주 가깝거나 소원해질 위험이 있으므로 이런 불안을 피하려고 상대적으로 안정적인 삼각관계를 형성하고자 함

- 가장 흔한 형태의 삼각관계
  - 사랑받고 싶은 아내가 독립적인 남편과 긴장이 발생하였을 때 삼각관계를 형성함
  - 아내는 특정 자녀와 강한 애착 관계를 맺어 남편과의 관계에서의 긴장을 감소시킴



- 삼각관계가 한쪽 부모와 자녀 사이의 과도한 애착으로 나타나게 되고 부모의 긴장을 해소하기 위해 부적절한 시도를 하는 자녀는 문제증상을 나타내는 사람(IP)이 되기 쉬움
- 삼각관계에 의존하는 것은 일시적으로 불안해소와 긴장완화에 도움이 되지만, 결국에는 문제를 악화시키고 삼각관계에 끼어드는 가족원의 자아분화 수준을 낮추게 됨

⇨ 따라서 가족구성원들이 잘 분화되어서 자율성을 유지할 수 있다면 심각한 스트레스 상황에서도 정서적 분리를 유지하므로 가족체계는 삼각관계에 의존하지 않고도 불안과 긴장, 문제들을 합리적으로 해소하게 됨

◆ 핵가족 정서체계

1) 핵가족 정서체계의 개념

- 가족들이 감정적으로 연결된 정도를 의미하며 원가족에서부터 형성되어 배우자 선택과 결혼생활을 통해 다세대에 걸쳐 반복됨
- 핵가족의 정서체계는 원가족에서 형성된 부부 각각의 자아분화 수준에 의하여 결정되고, 이는 다시 가족구성원에 영향을 미침
- 결혼 전에 원가족에서 정서적으로 융합되어 자아분화 수준이 낮을수록 자신과 비슷한 자아분화 수준의 상대와 결혼하고 부부간 융합도는 증가함
- 자아분화가 낮은 사람들의 결합일수록 두 사람의 자아는 융합되고 공동 자아를 형성함

2) 핵가족 융합의 결과

① 정서적으로 유리된 상태로, 부부 사이가 감정적으로 멀어지고 감정반사행동을 많이 함
② 부부 중 한 사람이 신체적 또는 감정적 역기능이나 부적응 상태에 놓임
③ 부부간 잦은 충돌, 심한 갈등
④ 부부의 문제가 자녀에게 투사됨

◆ 가족투사과정

1) 가족투사과정의 개념

- 미성숙한 부모가 자신의 미분화와 불안을 다루고 부부체계를 안정시키기 위해 무의식적으로 가장 취약한 자녀에게 정서적 에너지를 집중하는 방어기제
- 보웬은 아버지, 어머니, 자녀의 삼각관계에서 가족투사과정이 작동한다고 함
  예) 아버지는 수동적이고 아내와 거리를 두는 것으로 불안에 대처하고, 어머니의 불안과 결혼불만에 자녀가 동정하고, 어머니는 자녀에게 과잉간섭과 집착으로 자신의 불안을 자녀에게 투사함. 그 결과 자녀는 위축되고 어머니는 자녀를 과잉통제하여 자녀의 심리적 손상과 질병이 유발되고 자아분화 수준은 더욱 낮아지는 악순환이 계속됨
- 분화수준이 낮은 가정일수록 투사 정도가 심하며 투사대상이 되는 자녀 역시 자아분화에 문제가 생기는 등 다음 세대를 희생시키면서 부모의 미분화에서 오는 불안을 경감시키려는 가족패턴이 고정됨

◆ 정서적 단절

1) 정서적 단절의 개념

- 부모와 융합된 자녀가 원가족과 접촉함으로써 생기는 불안과 긴장을 줄이기 위해서 물리적·정서적 접촉을 회피하여 관계가 단절된 상태
- 정서적 의존성과 불안이 높은 가족에서 발생
- 가족원과 정서적 접촉을 회피하는 것으로 문제를 해결하려고 함(문제 발생 시 도망가거나 고립됨)
- 원가족과의 정서적 단절을 위해 충동적으로 결혼을 한 경우, 결혼을 통해 원가족에서 벗어난다 하더라도 진정한 독립을 얻게 되는 것은 아님
- 왜냐하면 융합이 심한 사람은 결혼을 해도 새로운 가족과 다시 융합되어 원가족에서의 문

제를 재연하기 때문

◆ 다세대 전수과정

1) 다세대 전수과정의 개념

- 여러 세대를 통하여 가족의 정서적 과정이 전수되는 것
- 모든 세대에서 삼각관계와 가족 투사 과정에 포함된 자녀는 여러 세대를 거치면서 부모보다 더욱 자아분화 수준이 낮아지게 되고, 그 결과 3대 또는 그 이상의 세대에까지 미분화 상태가 전이되면 조현병, 조울증, 우울증, 강박증 등의 정서장애 등의 문제가 발생하게 됨
  ⇨ 따라서 조현병이나 역기능 문제는 개인의 질병이 아니라 가족의 정서적 체계에서 누적되고 세대에 걸쳐 전수된 자아 미분화, 즉 융합의 결과로 간주됨

4주차 2교시	다세대 가족치료의 치료목표와 치료과정	
	수업목표	다세대 가족치료의 개념을 이해하고, 치료목표와 치료과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 다세대 가족치료의 주요 개념 II 2. 다세대 가족치료의 치료목표와 치료과정

1. 다세대 가족치료의 주요개념 II

◆ 다세대 가족치료의 주요개념

보웬의 가족치료 모델은 8개의 상호연관된 개념으로 구성	
핵가족과 확대가족에서 일어나는 정서적 과정	① 자아분화, ② 삼각관계, ③ 핵가족 정서체계, ④ 가족투사과정, ⑤ 정서적 단절, ⑥ 다세대 전수과정
가족과 사회에서 세대를 통해 일어나는 정서적 과정	⑦ 출생순위, ⑧ 사회적 정서과정

◆ 출생순위

- 자녀의 출생순위나 형제자매 위치에 따라 가족의 정서체계 내에서 역할과 기능이 달라지고, 결혼생활에서 배우자와의 상호작용 패턴에도 영향을 줌
- 보웬은 출생순위와 불안을 관련지어 관찰한 결과, 불안도가 심해지는 경우 장남과 장녀는 더 권위적이고 규칙에 집착하고, 막내는 당혹해하거나 혼란스러워 함
- 부모의 기대수준이 높은 장남이나 장녀는 부모와 강한 감정적 융합으로 삼각관계에 포함되기 쉬움
- 장남이나 장녀는 배우자가 막내이면 결혼생활에서 좀 더 책임감과 주도적 의사결정을 하는 경향이 있음 그러나 부부가 모두 첫째일 경우 둘 다 주도적이어서 갈등을 겪을 수 있음
- 자녀가 2명인데, 첫째와 둘째가 8살 터울이라면 첫째 자녀는 외동이의 특성이 강할 수 있음. 또한 첫째 자녀가 사망하였거나 질병으로 장남 노릇을 못하게 되면 차남이 장남 특성을 가지기도 함

  ⇨ 즉, 생물학적 출생순위만이 아니고 몇 째로 기능하였는가 하는 **기능적 출생순위** 개념도 중요함

  예) 장남이나 장녀가 사고나 병으로 사망하거나 부모의 기대를 실망하게 하면 그 다음 순위의 자녀가 첫째 자녀처럼 부부 사이의 삼각관계에 말려들 가능성이 높음

  예) 자녀가 둘인데, 두 아이 모두 막내처럼 기능한다면 둘의 나이 차가 7, 8년 이상이어서 외동이의 특성이 강하고 삼각관계에 속한 자녀인 경우가 많음

◆ 사회적 정서과정

- 개인과 가족의 정서적 과정을 사회로 확대한 것
- 특정 사회집단이나 가족의 분화수준이 높을수록 소속원들은 더 협동적이고 타인의 복지를

고려하게 됨
- 스트레스가 있을 때나 없을 때나 타인과의 접촉을 유지함
- 그러나 집단의 분화수준이 낮을수록 스트레스 상황에서 구성원의 이기심과 공격성, 회피성이 높아지고 폭력과 불신, 비행과 범죄율이 높아지고 사회의 위기가 발생함
- 가족체계와 마찬가지로 사회도 불안이 증가하면 하위집단끼리 융합되기 시작하여 분화수준이 낮아짐. 분화수준이 낮아지면 역기능적 삼각관계가 지속적으로 서로 맞물려 사회 전체로 확장
- 현재 한국인의 경우 윗 세대로부터 수직적인 스트레스를 전수받고 당대에 직면한 취업환경의 불안과 환경오염 등의 수평적 스트레스를 경험하는 경우가 많은데 이는, 학생들의 경우 학교폭력이나 왕따등의 현상, 중년 세대의 경우 자녀에 대한 비정상적인 교육열, 심각한 음주문화 등에 영향을 미쳤을 것으로 보임
  예) 성차별주의, 집단이기주의, 획일주의 등과 장애, 계층, 인종에 대한 편견들은 불안수준이 높고 분화수준이 낮은 사회의 정서적 과정을 반영함

2. 다세대 가족치료의 치료목표와 치료과정

◆ 치료목표
- 세대로 걸쳐 누적된 불안을 감소시키고 자아분화 수준을 높여서 삼각관계에서 벗어나도록 하는 것
  ⇨ 이를 통해 개인의 자율성과 성장을 위한 환경 마련, 미분화의 세대 전수 예방

◆ 치료과정

1) 1단계 : 가족평가
- 가족의 문제와 전체 가족체계에 대한 평가, 치료계획 세우기
- 가계도 그리기
- 핵가족의 경우
  - 부부의 결혼경위, 결혼생활 적응수준, 출생순위, 원가족과의 분화 정도, 자녀출산 및 자녀와의 관계, 가족의 정서 과정, 위기와 스트레스 사건 발생 여부 등 조사
- 확대가족의 경우
  - 부계와 모계를 포함한 각 친척의 교육배경, 건강력, 직업력, 사망일, 사망원인, 결혼력, 출산력, 가족 내 삼각관계, 정서적 단절, 현재 핵가족의 위치, 위기와 스트레스 사건 발생 여부 등 조사
- 가족평가면접의 내용
  · 누가 치료를 받으려고 하는가?
  · 핵심증상은 무엇이며, 가족관계에 어떤 영향을 주는가?
  · IP와 가장 가까운 관계체계는 누구인가?
  · 핵가족의 정서기능과 정서과정은 어떠한가?
  · 무엇이 문제의 심각성에 영향을 미치는가?

· 현재의 스트레스원은 무엇인가?
· 가족원은 분화수준은 어떠한가?
· 가족은 불안을 어떻게 다루는가?
· 어느 가족원 간 삼각관계가 존재하는가?
· 과거에 경험한 스트레스의 양과 현재 기능을 비교하면 어떠한가?

2) 2단계 : 가족 내 불안 감소

- 가족 내 불안감정에 초점을 맞추어 감정을 통제하고 불안을 감소시키는 방법 연습하기
- 불안이 정서적 융합을 가져오므로 치료 시 불안을 감소시켜 정서적 역기능을 줄이도록 함
- 자신이 불안해하는 이유를 인식하고, 불안에 대처하는 방법을 배워야 함
- 상담사의 역할 : 코치 역할

3) 3단계 : 핵심적인 삼각관계범위 정의

- 삼각관계와 다세대 전수과정에 대한 정확한 인식과 객관적으로 이해하기
- 삼각관계를 파악하고 그 중 문제증상과 관련된 핵심적 삼각관계 범위를 정의함

4) 4단계 : 탈삼각관계화

- 새로운 행동을 실천하여 탈삼각관계로의 변화 체험하기
- 상담사 역할 : 확대가족원과의 삼각관계에 벗어나 적당한 거리를 유지하면서 친밀한 관계를 갖도록 코치. 가족 내 삼각관계와 그 역기능을 가르치고 원가족과의 삼각관계에서 벗어나 객관적이 되도록 도움. 이를 통해 가족체계를 변화시키는 지렛대 작용을 하도록 함

• 부부를 대상으로 할 때
  - 부부의 가정이 진정되고 불안수준이 완화되도록 도움
  - 부부가 상대방을 탓하기 전에 문제발생에 자신이 이바지한 부분을 보게 하고 부부 사이에 직접 대화를 나누기보다는 부부가 치료자에게 각자의 말을 하게 함
  - 치료과정에서 치료자와 삼각관계 형성(치료적 삼각관계)
  - 이때 치료자는 부부와 정서적 중립 위치를 유지하면서 차분한 목소리로 감정보다는 사실을 말하도록 함 중립적인 위치에서 양쪽과 접촉한다면 부부 각자의 자아분화 수준이 높아지고 관계가 안정될 때 치료자는 아웃사이더로 나오게 됨(탈삼각관계)
• 개인을 대상으로 할 때
  - 한 명의 가족원이 성공적으로 분화한다면 전체 가족체계로 확산되어 가족체계의 분화수준을 높일 수 있다고 가정함
  - 치료의 목표는 분화수준을 높이는 것
  - 분화된 개인은 가족원 모두와 개인 대 개인으로서 성숙한 관계를 맺을 수 있음
• 확대가족 안에서 자아분화를 위한 선행조건
  ① 가족체계가 어떻게 기능하는지 아는 것
  ② 변화를 위한 강한 동기가 있는지 파악하는 것
  → 변화를 위해서 본인 가족의 역사를 깨달아야 한다는 것

- 성공적인 분화를 위해서는 본인의 의지가 가장 중요하지만 전문적인 코치의 도움이 필요함
- 치료자는 중립적이고 객관적인 조언을 통해 개인이 가족의 정서적 반응성에 심리적 거리를 두고 대응할 수 있도록 계획을 세움

- 가족 내에 문제가 발생했을 때 그 문제행동은 가족과정의 한 부분이며 자신도 그 과정에 책임이 있으므로, 가족의 문제가 발생하면 자신의 행동부터 살펴보아야 할 것임

4주차 3교시	다세대 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법	
	수업목표	다세대 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법을 이해하고, 사례 적용을 통해 치료과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 다세대 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법 2. 다세대 가족치료 사례

1. 다세대 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법

◆ 치료자 역할

- 자아분화 수준이 내담자의 수준보다 높아야 함
- 중립적인 자세(특정 가족원의 편 들지 않기)로 가족의 감정적 동요를 진정시키고 자아분화를 높이는 촉진자
- 가족이 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 조용히 돕는 코치 또는 컨설턴트의 역할
- 가족원의 자아분화와 불안 감소를 위해 가족의 정서 과정에 융합되거나 삼각관계에 연루되지 않아야 함
  · 치료자가 부부와 더불어 삼각관계를 만들더라도 치료자가 과잉기능하거나 정서적으로 반응하여 삼각관계의 정서과정에 사로잡히지 않는다면, 삼각관계에서 불안하지 않은 존재로 남아 있음으로써 다른 두 사람의 관계에 변화를 가져올 수 있음
- 가족과의 관계에서 차분하고 객관적인 태도로 자율적 위치를 취하여야 함

◆ 치료기법

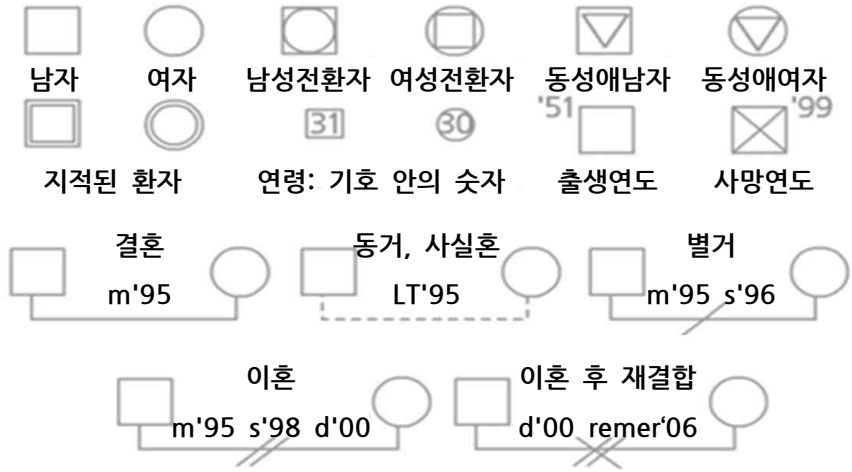
1) 가계도

- 정서적 과정이 세대에 걸쳐 반복되고, 해결되지 않은 같은 정서문제가 가족에서 지속적으로 나타날 수 있다는 것을 전제로 가계도를 작성함

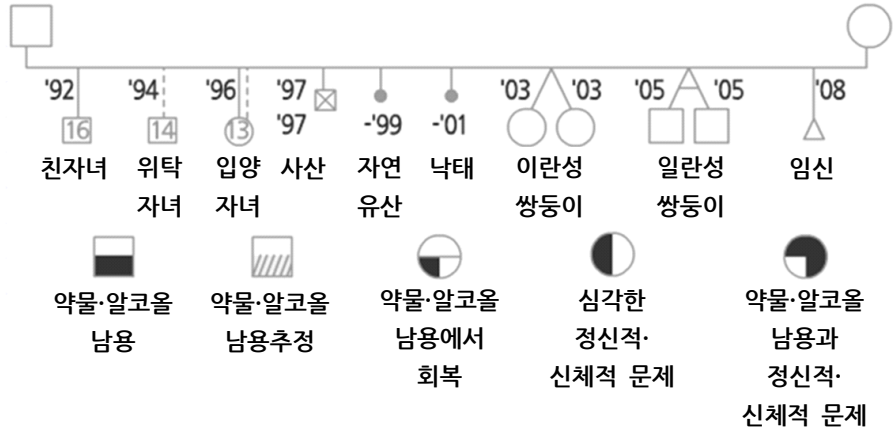
• 가계도
  · 3세대 이상에 걸친 가족성원에 관한 정보와 그들 간의 정서 과정을 표시한 그림

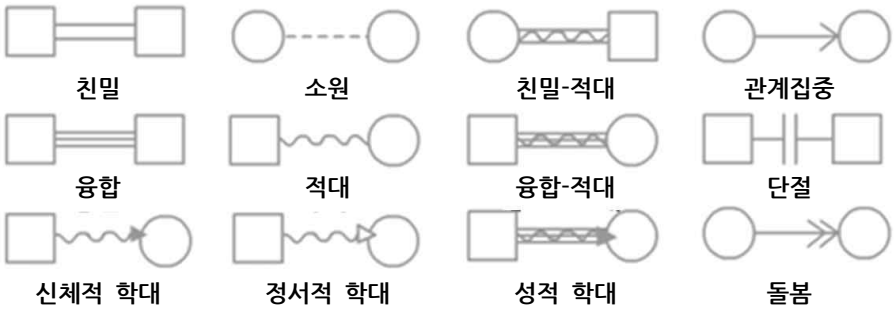
• 가계도의 기능
  - 세대에 걸쳐 반복되는 사건이나 중요한 생활사 정보를 파악하여 현재 가족문제와 가족의 정서적 체계의 연관성에 대한 이해를 돕고 내담자의 변화 동기를 높여줌

• 가계도에 포함되어야 하는 내용
  - 현 핵가족, 남편과 아내의 3대에 걸친 정보와 주요한 생활사건 표기
  - 가족원의 이름, 연령, 형제자매 위치, 결혼, 별거, 이혼, 종교, 직업, 학력, 거주지역, 이사, 사망, 구금, 질병, 가족의 관계유형, 가족원의 기능, 역할 패턴, 정신적·신체적 문제 및 중독이나 폭력 등의 문제, 가족의 강점, 사회적 네트워크, 종교활동 등

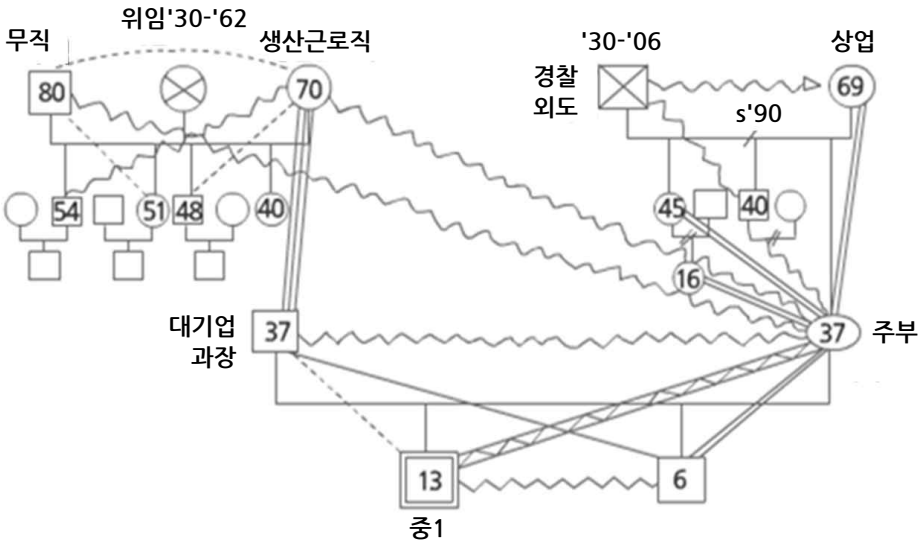


자녀 : 왼쪽부터 출생순으로





- 상담이 진행되면서 가계도는 더욱 구체적으로 작성되고 관련 정보가 추가됨
- 치료자가 가계도를 해석하는 과정에서 가족의 고통스러운 사건이나 불행에 대해서는 가족이 감정적으로 준비된 상태일 때 이야기하고 좋은 의도나 극복과정을 탐색하여 긍정적 해석을 하는 것이 바람직함



2) 치료적 삼각관계

- 부모나 부부처럼 두 사람의 성인과 치료자의 삼각관계 형태
- 갈등이 있는 두 사람이 긴장을 감소시키기 위해 치료자를 자동적으로 삼각화 과정에 끌어들이려고 할 때 치료자가 정서적으로 말려들지 않는다면, 치료적 삼각관계 안에서 가족체계는 다시 평정을 찾아 문제를 해결할 방법을 찾게 됨

3) 코칭

- 치료자가 내담자와 가족이 직접 가족문제에 대처하는 데 자신의 능력과 기능을 최대한 발휘하도록 조언하여 가족이 스스로 그들이 가족문제를 해결해 나가도록 지원하는 것

• 코칭의 목표

  - 자기 이해 증진, 자신에게 초점을 맞추며 가족원 간에 더 기능적인 애착 관계를 발전시키는 것

4) 나-입장(I-position) 취하기

- 자아분화 수준이 낮은 사람은 자기표현이 서툴고, 자신의 생각이나 감정을 적절하게 표현하는 것을 어려워함
- 자신의 삶에 대해 자신감을 갖고 주체적인 삶을 영위하도록 '나-입장 취하기' 연습이 필요함
- 다른 사람이 무엇을 하는가를 비난하거나 지적하는 대신 자신이 무엇을 생각하고 느끼는가를 말하게 하여 자신의 생각과 감정을 표현하게 하는 방법

  예) "당신은 왜 그렇게 어지르고 다녀?" → "당신이 벗어 놓은 옷이나 본 책을 그때그때 정리했으면 좋겠어."

  ⇨ 상대방에게 책임을 추궁하는 것이 아니고 자신의 현재 의견과 감정상태를 표현함으로써 악순환적인 대응적 대화에서 벗어나 해결방법을 찾을 수 있는 생각을 시작하게 하는 것

5) 교육

- 분화수준을 높이기 위해서 가족들은 지적인 사고능력의 활용방법을 배워야 함
- 교육을 통해 가족구성원들이 서로에게 정서적으로 얽혀있고 불안을 해소하기 위한 삼각관계를 형성하고 있다는 점을 인식하도록 함

  예) 자아분화 수준이 낮은 사람은 불안에 대해 적절하게 대처하지 못하므로, 불안이라는

감정을 다루는 방법을 배워야 하며, 자기 불안의 이유 인식, 불안처리 방법을 습득하여 불안을 낮추도록 함

⇨ 불안을 감소시키면 정서적 역기능도 감소하게 됨

6) 질문하기

- 질문을 통해 가족을 이해하도록 함
- 질문은 사고와 감정을 구별하고, 가족 내 자신의 역할을 수정하기 위한 방법을 유도하고 객관적인 입장에서 가족을 바라볼 수 있도록 함
- 가족관계 이해를 위한 순환질문 사용

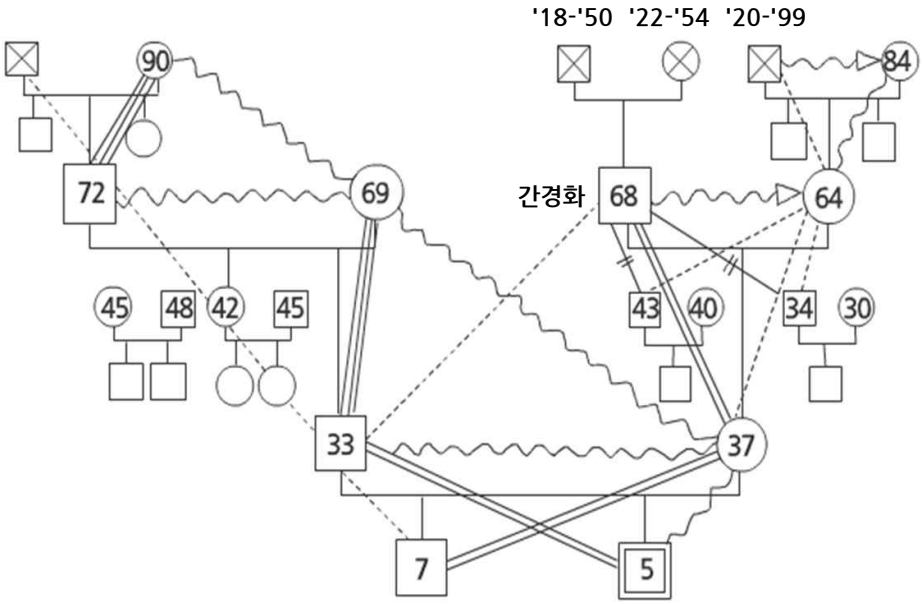
예) "남편이 술을 마시면 부인께서는 어떤 생각을 하세요?",
"남편이 술을 마시는 데 부인이 한 역할은 무엇일까요?",
"남편이 당신에게 속마음을 털어놓을 수 있었나요?"

2. 다세대 가족치료 사례

◆ 사례

· 결혼 7년 차 부부, 자녀(7살, 5살)
· 의뢰 사유 : 둘째 아들의 충동적 분노 표출, 사회성에 문제가 있어서 상담을 받다가 가족치료를 권유받고 상담 의뢰
· 아내의 남편에 대한 불만 : 가사와 자녀양육에 전혀 협조하지 않으며 사위 노릇에 소홀한 것
· 아내의 반응 : 남편을 닮은 둘째 아이에게 화풀이하고 남편에게도 소리 지름. 착한 큰아이에게 삶의 희망을 두고 살고 있음
· 남편의 태도 : 아내가 잔소리하고 요구할 때마다 귀찮아하고 바깥으로 돌며 아내의 눈치를 보고 참다가 싸울 때는 아내를 어머니와 비교하는 말을 함. 작은아들과 더 친밀
· 남편의 원가족 : 무관심하고 충동적인 아버지, 헌신적이고 허용적인 어머니, 부모 사이는 갈등의 연속으로 불화, 어머니는 공부 잘하고 착한 외아들에게 정서적으로 의존, 아버지는 할머니와 밀착, 심한 고부갈등
· 아내의 원가족 : 조실부모하고 자수성가한 아버지, 어릴 때 외조모의 구박을 받은 어머니, 아버지는 가정에 무관심하고 음주를 즐기며 어머니에게 폭력 행사, 자녀에 대한 애정표현이나 보살핌 부족, 오빠와 남동생은 가정불화로 부모와 왕래하지 않음
· 아내의 바람 : 남편이 사위 노릇을 잘하는 것
· 남편의 바람 : 아내가 자신의 헌신적인 어머니처럼 자신에게 잘해 주기를 기대하고, 며느리 노릇을 잘 해주기를 바람

- 치료
  - 아이 문제에서 벗어나 아이 문제를 둘러싼 가족의 정서 과정에 초점을 두며, 배우자의 말을 경청하고 배우자를 이해하도록 함
  - 각각 원가족에 매여 있는 상황에 대해서 생각하도록 하여 각자가 상황에 대처하는 방법이 서로에게 상처를 주고 결혼생활과 자녀와의 관계를 악화시킨다는 것을 인식하게 함
  - 가계도 작업, 남편과 시부모가 삼각관계, 작은아들의 문제는 여러 세대에 걸친 삼각관계와 연관됨



초등 1

- 기법 적용 : 삼각관계에서 벗어나 자아분화가 되도록 “코칭”과 “나-입장 취하기” 활용

• 결과

- 아내는 남편을 비난하고 요구하던 것에서 자신의 이야기를 분명하게 알게 됨. 남편은 위축되거나 눈치를 보고 어머니와 비교하던 것에서 벗어나 아내와 자녀에게 관심을 갖고 아버지 역할, 사위 역할에 참여하게 됨

5주차 1교시	경험적 가족치료의 발달배경과 주요개념	
	수업목표	경험적 가족치료의 발달배경과 주요개념을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 경험적 가족치료의 발달배경 2. 경험적 가족치료 주요개념

1. 경험적 가족치료의 발달배경

◆ 경험적 가족치료의 발달배경

❖ 사티어의 경험적 가족치료는 실용성이 높은 것으로 주로 의사소통에서의 일치성에 초점을 두고 있다. 인간의 잠재력, 역량에 대해 긍정적이며, 인간을 최선의 상태를 향해 노력하는 존재로 보고 있다. 역기능적 가족의 특징은 불일치적 의사소통과 낮은 자아존중감으로 보고 있다. 따라서 역기능적 의사소통과 가족규칙을 기능적으로 변화시키고 자아존중감을 증진시키는 것을 치료목표로 한다.

◆ 개요

- 경험적 가족치료는 지금-여기(here and now)에서의 경험을 중시하는 현상학 이론과 인본주의 철학에 근거함
- 지금-여기에서 치료자와 가족 사이에 일어나는 상황과 경험을 중요시하였고, 이러한 주관적 상황과 경험을 통해 변화가 나타나고 성장하게 된다고 보았음

□ 대표적 인물 : 휘태커(Carl Whitaker), 사티어(Virginia Satir)

- 휘태커와 사티어의 공통점
  - 치료과정에서 내담자의 체험을 중시하고 치료자의 가족에 대한 사적인 관여가 치료적 변화를 촉진한다는 주장
- 휘태커와 사티어의 차이점
  - 휘태커는 개인적 만남을 강조하며, 치료자는 자신을 활용하여 가족과 인간 대 인간의 관계를 맺을 수 있도록 도와야 한다고 함
  - 사티어는 치료란 성장과정의 체험 연습, 치료자는 가족이 성숙한 인간으로 성장할 수 있도록 도와야 한다는 주장

◆ 발달배경

- 인간의 성장 잠재력과 문제 해결력 존중, 자아 가치와 성숙 및 성장 중시
- 자발성과 자유, 창의성, 지금-여기에서의 개인의 주관적인 감정과 욕구, 행동 중시
- 치료자와 가족 사이에 그때그때 경험하는 상황과 느낌 중시
- 현재 충만을 경험하는 것, 이를 가족이 공유하여 치료적 변화가 촉진되고 가족이 성장하는 것을 강조함

- 전제

- 가족들이 치료과정에서 경험하는 것들이 성장에 중요한 자극과 계기가 됨

◆ 사티어의 치료적 신념과 가정

1) 변화에 대한 신념과 가정
- 변화는 가능함. 비록 외부환경의 변화가 제한되어도 내적 변화는 가능함
- 과거를 변화시킬 수 없음. 단지 그것들이 우리에게 미치는 영향만을 변화시킬 수 있음

2) 성장에 관한 신념과 가정
- 누구든지 다른 상황과 문화, 환경, 문제에 성공적으로 대처하고 성장할 수 있는 자원과 적응력을 가지고 있음

3) 선택에 관한 신념과 가정
- 사람들은 대부분 스트레스를 받으면 좋고 바람직한 것보다는 자신에게 익숙한 방법을 선택함

4) 인간의 유사성과 차이점에 대한 신념과 가정
- 차이점을 발견하기보다는 차이점을 수용하는 것을 배워야 함
- 유사성을 근거로 함께 어울릴 수 있고 차이점을 근거로 이해하고 극복하는 과정을 통해 성장할 수 있음

5) 과거 및 부모 수용에 대한 신념과 가정
- 과거에 대한 수용과 감사, 용납은 현재를 관리하고 발전시킬 수 있는 능력을 향상하게 함
- 부모에 대한 수용과 감사, 인간적 이해는 현재 문제해결의 열쇠이고 성장의 출발점이 됨
- 자신이 처한 상황에 가장 적합한 방법으로 전력을 다하였음을 인정해야 함

6) 희망과 자원에 관한 신념과 가정
- 희망은 치료 동기가 됨
- 성장에 필요한 내면의 자원과 에너지: 신념, 확신, 지식, 사랑, 관심, 기쁨, 인정, 나눔 등

  ⇨ 사티어는 인간에 대해 긍정적이고 인간의 잠재능력을 믿었으며, 현재와 미래지향적인 태도를 가짐. 인간의 모든 행동은 합리적 동기가 있으며, 모든 사람은 치유될 수 있고 치료자의 조력을 통해 내담자는 해결 방법을 스스로 잡아 나갈 수 있다고 가정하였음

2. 경험적 가족치료의 주요개념

◆ 자아존중감

- 개념
  · 자신에 대해 가지는 일종의 평가개념으로, 자신의 사고, 가치관 그리고 행동에 많은 영향을 미침
- 사티어는 자아존중감을 인간의 기본적 욕구로 보고, 인간은 생존을 위해 자아존중감을 유지, 발전시킨다고 보았음
- 자아존중감은 어릴 때 부모 자녀 관계와 가족구조에서의 경험을 통해 학습되고 형성됨. 점차 친구와 주변 사람으로 확대된 관계에서의 경험에 영향을 받음
- 낮은 자존감을 높여 자신의 가치를 인정하고 자신이 가진 자원과 강점을 발견하여 활용함

으로써 문제에 적절히 대처하고 성장할 수 있게 하는 것이 사티어 가족치료의 치료목표 중 하나

- 자존감을 자신, 타인, 상황의 3요소로 설명하고, 이는 의사소통 유형 및 대처방식과 연관된다고 함

자존감이 낮은 사람	자존감이 높은 사람
사랑 받기 원함	스스로를 사랑하고 다른 사람의 사랑을 받음
의사소통 유형 : 역기능	의사소통 유형 : 성숙
현실부정(산만)/경직됨, 완고함	상황 수용/정당함
방어적/감정 억압	신뢰, 정직/감정, 전체성, 인간성 수용
안전하고 익숙한 것을 선택함 (변화에 대한 저항)	새로운 것을 시도함
과거지향적 : 현 상태 유지 원함	현재지향적 : 변화를 시도함
상대방이 죄책감을 갖게 함(비난)	서로의 차이점을 존중함

◆ 의사소통 및 대처방식

- 사티어는 의사소통이란 인간과 인간 사이에 오가는 모든 것이고, 서로 영향력을 행사하는 것이라고 함
- 모든 의사소통은 학습되는 것이기 때문에 의사소통 유형은 변화할 수 있음

❖ 네 가지 역기능적 의사소통 유형과 기능적 의사소통 유형인 일치형

① 회유형

- 타인과 상황은 존중하나 자신은 무시함
- 자신의 느낌이나 생각은 무시하고 타인의 기분을 맞추려고 애쓰고 사과하고 반대하지 못하는 유형
- 문제가 생기면 자기에게 책임이 있다고 생각하여 잘못을 빌고 비난도 감수함
- “모두가 제 잘못이에요”, “죄송합니다. 용서해주세요”



• 증상
  - 감정 억제, 걱정, 우울, 자살 사고, 소화장애 등
• 자원
  - 남에 대한 배려와 돌봄과 양육, 민감성

② 비난형

- 자신·상황 : 존중 / 타인 : 무시
- 자신을 보호하기 위하여 타인을 무시하고 결점을 지적하고 통제하고 명령하려고 함
- 내면적으로 외로운 실패자이며, 자신의 나약한 모습을 인정하지 못함
- “네가 제대로 하는 것이 있냐?”, “너 때문이야”, “가만두지 않을 테다”



• 증상
  - 분노, 적대감, 반항, 편집증, 반사회성, 고혈압 등
• 자원
  - 자기주장, 지도력, 에너지

③ 초이성형
- 상황 존중, 자신과 타인은 무시
- 원칙 중시, 정보와 논리를 절대적으로 생각함
- 감정을 억제하고 지나치게 이성적이며, 실수를 피하기 위해 대단히 노력함
- 자기통제의 상실에 대한 두려움
- “원칙, 당연한 것”



• 증상
  - 우울증, 강박증, 집착, 사회적 철회, 자폐증
• 자원
  - 지성과 지식 추구, 끈기 있는 문제해결

④ 산만형
- 자신과 상황, 타인 모두 무시
- 생각과 말, 행동이 자주 바뀌고 동시에 여러 가지 행동을 하려고 함
- 주제나 상황에 맞지 않는 말을 하며 산만하게 행동하고, 난처할 때에는 농담을 하거나 딴전을 피우며 고독과 무의미함을 느낌
- “날 내버려 두라, 무슨 상관이야. 왜 그렇게 심각해?”



• 증상
  - 부적절함, 충동적, 공감력 결핍, 우울, 학습곤란 등
• 자원
  - 유머, 즐거움, 자발성, 창의성

⑤ 일치형
- 자신과 상황, 타인 모두 존중
- 신체 자세와 목소리 음조, 표정이 자연스럽고 말, 정서, 행동이 일치함
- 말이 진실하고 상황에 적절하며 태도와 행동은 기능적이고 유능함
- 자기가치감이 높고 자신과 타인 신뢰



❖ 역기능적 의사소통 유형과 특징

	회유형	비난형	초이성형	산만형
단어	“모두 내 잘못이야”	“모든 것은 네 잘못이야”	“규칙, 원칙”	“관계없는 단어 사용”
정서	구걸하는 마음, 힘이 없어 보임	비난적, 강해보임, 융통성 없음	냉담, 경직, 완고	혼란스러움
행동	의존적, 너무 착함, 사죄와 애걸, 모두 양보	공격적, 명령적	권위적, 조직적, 행동의 합리화	산만함, 부적절함
내면의 경험	“나는 아무 가치가 없다”	“나는 외로운 실패자이다”	“나는 상처받기 쉽고 고립된 느낌이다”	“아무것도 상관하지 않는다”

심리적 영향	감정 억제, 우울, 자살 사고	반항, 분노, 반사회성	강박증, 집착, 우울	충동적, 우울, 부적절함
신체적 영향	위 장애, 편두통,변비	근육 긴장, 혈액순환장애, 고혈압	건조성 질병, 심장마비	편두통
자원	돌봄과 양육, 민감성	강한 주장	지식	즐거움, 자발적, 창의적

◆ 가족규칙

- 개념
  · 가족원의 행동을 규정하고 제한하는 것으로 역할과 관련된 기대, 생각과 감정, 반응, 태도 등이 포함됨

- 반복적인 생활경험을 통해 만들어지며, 모든 가족원의 행동에 영향을 주는 보이지 않는 힘
- 사티어는 다음의 가족규칙에 관심
  · 보고 들은 것과 감정을 표현하는 방법과 대상
  · 거절, 반대, 부정 등에 관한 표현
  · 질문방법과 대상
- 가족규칙이 비합리적이고 경직된 가족은 의사소통이 역기능적이고 가족원의 자존감이 낮음
  ⇨ 따라서 가족변화를 위해 역기능적 가족규칙을 변화시키는 것이 필수적임

5주차 2교시	경험적 가족치료의 치료목표와 치료과정 및 치료자 역할	
	수업목표	경험적 가족치료의 치료목표, 치료과정과 치료자 역할을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 경험적 가족치료의 치료목표 2. 경험적 가족치료의 치료과정 3. 경험적 가족치료의 치료자 역할

1. 경험적 가족치료의 치료목표

◆ 경험적 가족치료의 치료목표

- 경험적 가족치료의 목표는 내담자의 자아존중감을 높이고, 자기 인생에 대한 선택권을 갖도록 하며, 가족규칙을 합리적, 현실적으로 만들고, 내담자가 일치형의 의사소통 유형을 갖도록 하는 것
- 안정보다 성장, 감수성, 느낌의 표현, 자발성과 창의력 증진, 선택의 자유, 경험확대, 내면적 경험과 외면적 행동의 일치에 의한 개인의 통합력 증진 등
- 내담자가 안전하고 가치 있다고 느끼게 함으로써 변화가 시작될 수 있음 → 따라서 가족원의 개방적인 자기표현을 촉진하여 개인이 성장하게 되면 연쇄적으로 가족이 변화하고 성장한다고 믿음

• 경험적 가족치료의 건강한 가족이란?

· 문제가 없는 것이 아니라 문제가 발생해도 문제와 함께 계속해서 성장하는 가족

❖ 가족치료의 목표 달성을 위한 시도(사티어)

① 각 가족원이 다른 사람 앞에서 자신과 다른 사람에 관하여 보고 듣고 느끼고 생각하는 것을 분명하게 말하도록 함

② 각 개인은 다른 사람과 다른 점에 대해 말할 수 있고, 그것은 존중되어야 하며, 무언가를 결정할 때 강요에 의해서가 아닌 탐색과 협상을 통해 결정하도록 함

③ 서로의 차이점을 인식하고 존중함

2. 경험적 가족치료의 치료과정

◆ 경험적 가족치료의 치료과정

- 치료자는 개방적이고 솔직하고 자발적인 인간으로서 가족원의 모델이 되어야 함
- 치료자들은 인간은 본질적으로 건강하며, 만일 문제가 있을 때에도 문제를 해결할 자발성과 자유를 주면 생산적인 계획과 결과를 산출할 수 있다는 믿음을 가짐

• 치료의 주된 작업

- 방어를 깨고 경험을 개방하여 가족원들이 자발적으로 감정을 표현하게 하는 것

◆ 휘태커의 치료과정

- 가족은 교육이 아닌 경험을 통해 변화하며, 비언어적이고 상징적인 경험을 중요시함

◆ 사티어의 치료를 위한 전제

① 모든 행동은 합리적이고 적절한 동기가 있으며, 그 상황에서 할 수 있는 최선의 행동을 하는 것임

② 모든 사람은 치료될 수 있으며, 치료는 치료 과정 중에 일어남. 내용보다 과정이 치료에 중요함

③ 신체적 활력과 정서적 긴장수준은 연관되어 있음

④ 자존감과 효과적인 의사소통은 상호 관련되어 있음

◆ 6단계 치료과정

1) 적절한 도움 요청 단계
- 변화의 필요성 인식
- 불균형 상태를 지각하고 이를 변화시키려고 도움과 정보를 구함

2) 통찰 및 저항 단계
- 긍정적 목표가 설정되면서 현 상태의 균형이 깨짐
- 치료자는 가족 속에 들어가 가족의 저항을 수용

3) 감정 직면 및 혼란 단계
- 새로운 지각이 생기면서 과거의 역기능 상태에서 새로운 기능상태로 바뀌는 과정에 혼돈이 발생하게 됨

4) 새로운 시각·방법의 통합단계
- 변화에 대한 의식은 있지만 익숙하지 않기 때문에 과거의 것에서 벗어나 의지를 갖고 새로운 방식을 선택해야 하는 단계

5) 새로운 현상 및 방법의 생활화 연습단계
- 변화가 자신과 조화를 이루고 자리를 잡아 새로운 자신의 일부가 되는 단계

6) 새로운 현상의 정착단계
- 변화가 정착되어 편안함과 안전감, 새로운 경험을 함
- 상호작용과 기능적인 대처방식이 정착되어 높은 자존감과 일치형 의사소통 유형이 정착됨

3. 경험적 가족치료의 치료자 역할

◆ 경험적 가족치료의 치료자 역할

❖ 기법보다는 치료자의 자질을 강조함. 즉, 치료자의 사람됨과 일치성이 중요함

• 반맨이 제시한 경험적 가족치료자가 갖춰야 할 3대 요소 : 유능, 자신감, 일치

- 치료자는 직접적인 개입을 통해 의사소통양식을 변화시켜 가족체계를 지배하는 규칙을 변화시키고, 감정과 행동에 관한 메시지가 일치하지 않는 역기능적 의사소통에 내재되어 있는 메시지를 충분히 외면으로 드러나게 함
- 가족원 간 의사소통이 직접적이고 명백하되 서로 비판적이지 않으며, 감정이 자연스럽게 표

출될 수 있도록 상담을 이끌어야 함
- 치료자는 가족들을 이해하고 수용하는 자세를 가지고 가족들의 반응에 주의를 기울이며, 감정과 반응을 함께 나누어야 함
- 치료자는 가족원이 명확한 의사소통규칙을 따를 것과 메시지를 분명하게 하는 일치형 의사소통을 연습하고 훈련하여 정착되도록 도움

◆ 초기 면접 시 치료자의 역할

① 치료자는 자신을 내적·외적으로 준비한다
② 내담자와 라포 형성
③ 내담자가 상담을 통해 얻고자 하는 것에 귀 기울이면서 내담자가 희망과 소망을 갖게 함. 치료자가 어떻게 도움이 될 수 있는지 내담자에게 물어봄
④ 내담자의 현재 문제를 들음. 빙산(빙산탐색 기법)을 사용하여 문제의 성격을 탐색함
⑤ 문제를 긍정적이며 해결중심적인 관점으로 변형시킴. 구체적으로 달라질 것이 무엇인지 결정함
⑥ 상담의 전 과정을 통해 사정을 함. 대처유형 확인-빙산탐색
⑦ 치료의 초점을 어디에 둘지를 내담자와 함께 정하며, 내담자가 변화를 위해 노력하겠다는 다짐을 받음
⑧ 내담자의 장점과 좋아하는 것을 한 개 이상 찾음. 내담자에게 도움이 되는 자원과 방해물을 알아봄
⑨ 상담한 것을 정리하고 희망을 주면서 상담을 종결함
⑩ 계속 상담할 경우 과제를 주며 다음 약속을 정함

5주차 3교시	경험적 가족치료의 치료기법과 치료사례	
	수업목표	경험적 가족치료의 치료기법을 이해하고, 사례 적용을 통해 이를 숙지할 수 있다.
	세부내용	1. 경험적 가족치료의 치료기법 2. 경험적 가족치료의 치료사례

1. 경험적 가족치료의 치료기법

◆ 가족조각

- 개념
  · 가족원이 다른 가족원에게 느끼는 정서를 동작과 자세 등 신체적으로 표현하는 것
- 특정한 사람에 대한 감정과 생각을 시각적으로 표면화함
- 참여한 사람들이 가족의 의사소통 유형, 감정, 가족규칙, 대처방식, 관계 등을 파악하여 경험할 수 있음
- 사용 목적
  - 가족구성원이 각각 자신의 내면적 감정에 접함으로써 진정한 자아에 대해 알고 느끼며 새로운 대처방법을 생각하게 하기 위함
- 방법
  - “각 가족원들을 조각용 진흙 덩어리라고 생각하고 당신이 느끼는 대로 그들의 자세나 위치를 만드세요.”
  - 조각하는 동안 이야기하거나 웃지 않는다는 원칙
  - 조각한 후 자세를 1분 정도 유지하면서 내면의 감정과 접하게 함
  - 치료자는 가족에게 조각하는 동안 느낌을 물어봄
  - 가족이 이상적으로 바라는 관계를 나타내는 조각을 만드는 것으로 변용 가능
- 효과
  - 비언어적으로 감정이 표현되므로, 표현하는 사람의 내적 감정을 충분히 표현할 수 있고, 언어능력이 제한되는 가족, 어린 아동이 있는 가족, 말이 너무 많거나 말이 없는 가족에게 효율적임

◆ 은유

- 개념
  · 치료자가 직접적으로 지시하거나 평가하기보다는 간접적이고 비유적인 표현을 사용하는 것
  예) 성폭행을 당한 여성이 자상한 남성과 결혼을 약속하게 되면서부터 악몽을 자주 꾸게 되었다. 치료자는 만약 남자 친구와 산책하다가 날개 다친 새를 발견한다면, 어떻게 할 것인지 질문하였다. 내담자는 새를 돌봐 줄 것이라고 대답하였다. 남자 친구가 어떻게 할 것 같으냐고 질문하자, 그 사람도 새를 돌봐줄 것이라고 하였다. 치료자가 보기에 내

담자는 날개를 다친 새로 보인다고 하였다. 내담자는 은유를 통해 자신의 상황을 긍정적으로 보게 되었고, 남자 친구가 그 상황을 알게 될 경우 자신에게 연민을 가질 것이라는 확신을 하게 되었다.

- 사용목적
  - 내담자가 위협을 느끼지 않도록 하고 사진의 문제에 접근하여, 내담자의 사고를 새로운 수준으로 끌어올리고, 친숙하지 않은 것을 친숙한 것으로 만들거나 대안을 확장시키기 위해 사용함
- 효과
  - 내담자의 자아존중감이나 체면을 손상시키지 않기 때문에 덜 위협적으로 문제에 대한 대안을 찾을 수 있게 됨

◆ 원가족 도표를 활용한 원가족 삼인군 치료

- 사티어는 원가족 도표를 통하여 가족의 역동성과 가족관계를 쉽게 이해하고 평가하며 이를 원가족 삼인군 치료에 활용함
- 역기능적인 가족규칙과 대처방식에서 벗어나 의식적인 선택과 감정관리를 하게 하고, 일치형 의사소통을 하게 하여 자아존중감을 높이고 개인이 성장하게 함
- 치료 대상을 스타(star)로 지칭
- 원가족 도표는 스타의 원가족, 스타의 아버지 원가족, 스타의 어머니 원가족의 세 가지 그림

❖ 원가족 도표를 그리는 방법

1) 1단계 : 스타의 원가족 도표 작성

- 남자 □, 여자 ○. 그 안에 이름과 현재 나이 기입, 그 옆에 직업, 학력, 종교 기입
- 사망한 경우 사망 시 나이와 사망이유를 적고 사선 그음. 스타의 형제를 출생 순으로 도형을 그리고개인적 인구정보 기입

2) 2단계 : 가족의 성격 특성, 대처유형, 관계양상 작성

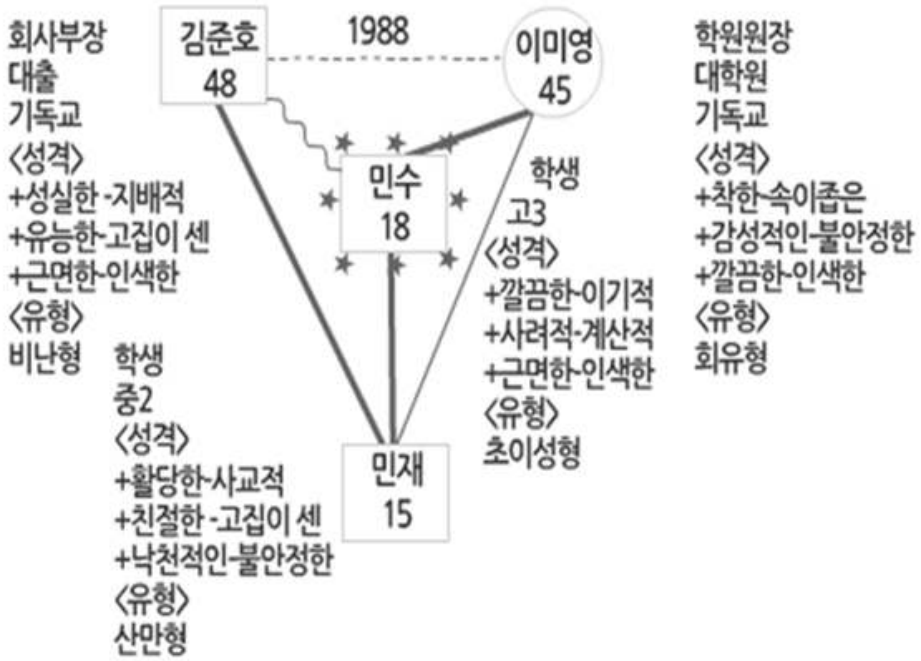
- 아버지와 어머니, 형제들의 성격 특성을 긍정적 특성 3가지, 부정적 특성 3가지 기입
- 스트레스 상황에서 대처방식(의사소통 유형) 기입, 가족관계 양상을 선으로 표시. 스타에게 ☆표시하기

굵은 실선		**밀착된 관계**
물결선		**적대적이고 갈등적인 관계**
가는 실선		**갈등이 적고 정상적인 관계**
점선		**소원, 냉담, 무심한 관계**

3) 3단계 : 스타의 아버지, 어머니의 원가족 도표 작성

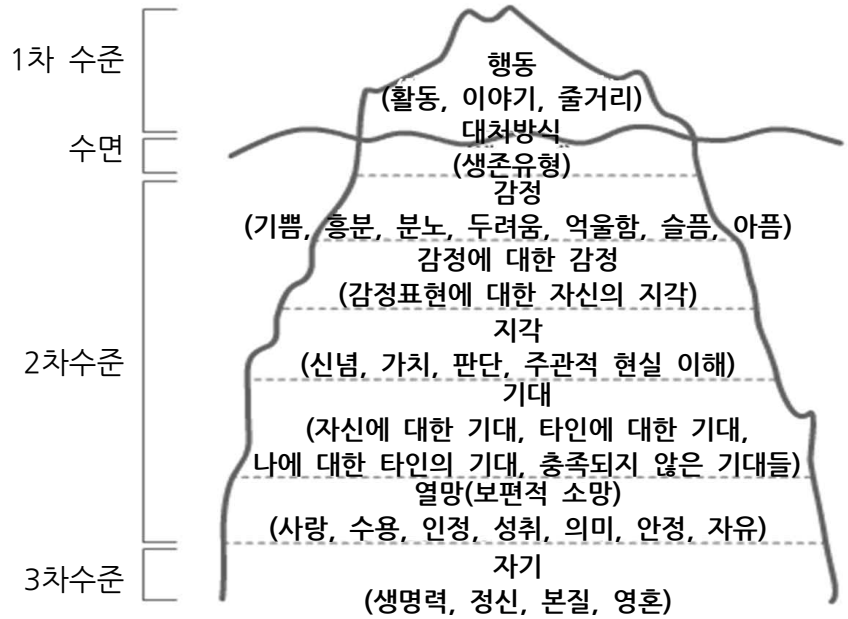
- 같은 방법으로 스타의 아버지의 원가족 도표에 조부모, 아버지의 형제자매에 관한 정보와 관계양상 표시
- 스타의 어머니의 원가족 도표에는 외조부모, 어머니의 형제자매 등에 대한 정보와 관계양상 표시

- 가족의 특징을 적음



◆ 빙산탐색

- 개념
  - · 개인의 내적 경험을 이끌어내는 비유적 방법
  - · 사티어 모델에서는 개인의 빙산 '수면' 아래를 탐색하여 부적응적인 내담자의 경험을 표면화하고 변형하도록 하여 2차 수준과 3차 수준의 변화를 목표로 함
- 빙산의 구조
  - 1차 수준 : 수면 위에 나타난 부분인 행동과 대처방식
  - 2차 수준 : 수면 아래의 부분인 감정, 감정에 대한 감정, 지각, 기대, 열망
  - 3차 수준 : 그 아래의 자기(self)



❖ 빙산탐색과정

1) 행동

- 빙산 위에 나타난 특정 사건에 대한 활동과 이야기에 대하여 내담자가 보고 들은 객관적 사실은 무엇인가? 보고 들은 것에 대하여 어떤 의미를 부여하는가?
  예) 남편에게 화가 나는 상황에서 어떻게 행동합니까?

2) 대처방식

- 수면에 나타난 사건에 대하여 내담자는 어떻게 대처하였는가? 어떤 대처방식과 방어기제들을 활용하였는가? 등에 대하여 탐색
  예) 반복되는 대처유형이 어떻게 나타납니까? 그 의도는 무엇인가요?

3) 감정

- 기쁨과 흥분의 감정이었는가? 분노와 두려움 또는 슬픔과 아픔에 대한 감정이었는가? 등에 대하여 탐색
  예) 그 상황에서 느끼는 감정이 어떤 것인가요?

4) 감정에 대한 감정

- 그 사건에 대한 자신의 감정에 대한 감정은 무엇인가? 등에 대하여 탐색
  예) 화가 나는 자신에 대한 느낌은 어떠한가요?

5) 지각

- 지각은 보통 자신이 갖고 있는 가족규칙이나 습관, 신념, 가정, 고정된 시각에 의하여 자신이 갖는 주관적 해석
- 그 사건의 대처방식에 대한 자신의 감정과, 감정과 감정에 대한 내담자의 해석규칙들은 무엇인가? 등에 대해 살펴보기

6) 기대

- 자신에 대한 기대와 타인에 대한 기대 그리고 자신에 대한 타인의 기대를 무엇인지 탐색
  예) 그때 남편에 대한 기대는 무엇인가요? 과거에 충족되지 못한 기대는 무엇인가요?

7) 열망

- 내담자 자신이 이루고자 하는 소망으로, 열망에 대한 탐색으로 자아존중감을 높일 수 있는 새로운 방안 모색
  예) 당신의 기대 밑에 있는 간절한 소망은 무엇인가요?

8) 자기(자아)

- 내담자 자신을 지탱하게 하는 생명력은 무엇인가? 자신의 정신력 또는 영혼 깊숙한 곳에서 솟아나는 자신의 에너지의 근원은 무엇인가 탐색
  예) 자신의 생명력과 삶을 지탱하게 하는 본질은 무엇인가요?
- 인간의 경험 대부분이 수면 아래에서 경험되므로 치료자는 표면적 경험인 1차 수준뿐 아니라 잠재의식으로서 2차, 3차 수준의 경험을 탐색하여 경험을 표면화시키는 것이 중요하다고 믿음

• 치료자의 역할
  - 내담자가 성장 과정에서 누적된 내면의 감정과 잠재적인 경험들을 치료장면에서 실제로 느끼고 실현하는 방안을 찾도록 도움

- 역기능적 의사소통을 일치형 의사소통으로 변화시키고 자아존중감이 향상되도록 도움

2. 경험적 가족치료의 치료사례

◆ 치료사례

· 결혼 1년 차 부부. 8개월 된 아들이 있음
· 의뢰사유 : 남편이 시어머니의 간섭을 것을 당연하게 생각하고, 시어머니와 상의하고 보고하는 등의 행동을 함. 아내는 모자의 밀착관계와 시모의 간섭에 불만이 커지고, 남편과 시집식구들에게 소리를 지르고 물건을 던짐. 이혼 전 상담을 받기로 함
· 남편 : 아버지가 장기간 정신병원에 입원하였다가 사망. 3남1녀 장남. 어려운 상황에 고생하며 뒷바라지한 어머니에게 착한 아들, 동생들에게 아버지 역할.
· 아내 : 2남 1녀 중 막내. 지배적이고 폭발적으로 화 내는 아버지, 입, 퇴원을 반복하고 집안일을 못하는 어머니. 나이 차이가 크게 나고 모범생인 오빠들에 비해 말썽을 피워 가정에서 인정받지 못하고 성장함
· 신혼기부터 강한 성격의 지배적인 시어머니의 간섭과 참견, 남편의 시어머니에 대한 맹종과 의존 때문에 갈등이 심하였음
· 부부의 의사소통 유형
  - 남편 : 회유형. 아버지가 계시지 않은 가정의 기둥으로서 장남 역할을 중시
  - 아내 : 비난형. 시모와 남편을 비난함

❖ 빙산탐색 결과

항목	남편	아내
대처 행동	아내가 시댁에 적응하는 것을 추구	남편이 시댁과 거리를 두고 부부로서 함께하는 것 추구
감정	우울, 두려움	분노
감정에 대한 감정	지침, 절망감	외로움, 비참함
지각	잘못하면 아내가 떠난다	나를 인정해주어야 한다
기대	아내와 함께 있고 싶다	날 온전히 받아들였으면
열망	아내 옆에서 사랑 받고 싶다	날 온전히 받아들였으면
자기	곁에서 사랑 받는 행복한 나	받아들여지는 행복한 나

- 남편은 아내의 행동에 상처를 받아 대응적 행동을 하며 참기만 했던 것을 그치고 아내를 이해하고 인정해 주며 아내에게 도와달라는 말을 조금씩 하게 됨
- 아내는 남편의 생각과 기대를 잘못되었다고 생각하고 자신의 감정을 쌓아두었다가 폭발적으로 표현하던 것을 중단하고 남편의 생각과 기대를 이해하게 됨

6주차 1교시	구조적 가족치료의 발달배경 및 주요개념	
	수업목표	구조적 가족치료의 발달배경 및 주요개념을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 구조적 가족치료의 발달배경 2. 구조적 가족치료의 주요개념

1. 구조적 가족치료의 발달배경

◆ **구조적 가족치료의 개요**

❖ 구조적 가족치료는 “가족구조가 변하면 그 구성원의 행동과 내면의 심리과정이 변화한다.” 는 것을 전제로 함

- 가족의 상호작용 패턴을 가족구조의 개념으로 설명하고, 가족 간 상호작용에서 반복되어 나타나는 패턴화된 규칙성이나 구조를 파악하여 구조를 변화시키는 것을 목적으로 함
  ⇨ 이 과정에서 치료자는 가족의 일원으로 합류하고 가족을 있는 그대로 존중하면서 가족을 재구조화기 위한 치료적 개입을 시도함
- 가족구조의 개념을 중심으로 하위체계, 경계선, 위계구조 등 개념을 제시하여 기능적인 가족과 역기능적인 가족에 관한 지도(map) 제공
- 체계론적인 시각에 근거하여 체계의 역동성 강조
- 가족 내 하위체계의 구조, 경계 등이 어떻게 교류하고, 행동을 규정하는가를 확인해 가는 치료방법으로 개인의 문제행동은 인간관계 규칙, 즉 가족 구조상의 문제를 반영하고 있다고 봄
- 과거, 현재 모두 중시하지만, 현재에 초점을 둠
- 타 이론에 비해 간단하고 실제적, 유용한 기법 제공

□ 대표적 학자 : 미누친, 헤일리

◆ **발달배경**

□ 미누친

- 치료자가 적극적으로 개입하여 구체적이고 행동 중심적인 접근을 하는 것이 가족의 변화를 이끌어낼 수 있음을 알게 되면서 구조적 가족치료이론을 개발함

• 구조적 가족치료의 원리

① 사회적 상황은 개인의 정신생활에 영향을 미침
② 가족구조의 변화는 체계 구성원의 정신 내적 과정과 행동 변화를 야기함
③ 치료자가 내담자나 내담자 가족과 일할 때 그의 행동은 사회적 상황의 일부가 됨

2. 구조적 가족치료의 주요 개념

◆ **하위체계**

- 가족은 다양한 하위체계로 구성된 하나의 체계이면서 동시에 가족을 둘러싼 친척, 직장, 친구, 학교, 경제, 교육, 지역사회 등 외부체계의 하위체계로 작용함
- 각각의 하위체계는 고유한 규칙과 기능을 가지며, 하위체계 간에는 위계질서가 존재함
  ⇨ 부부체계 〉 부모체계 〉 자녀체계
- 상위체계는 전체 가족에 대한 의사결정권을 가지며, 가족구성원의 행동을 통제하는 규칙을 만들고 시행함
- 위계질서가 무너질 때 가족구조에 문제가 발생함

1) 부부 하위체계

- 두 사람의 결혼과 더불어 형성
- 각자 원가족에서 부부란 무엇인지, 결혼생활은 어떠해야 하는지에 대한 기대와 규칙을 가지고 있음
- 따라서 부부체계가 건강하게 기능하기 위해서 각자 원가족의 영향에서 독립하고 분화되어야 부부체계가 건강해짐

• 주요 과업
  - 협상과 조정
• 기능
  - 성, 사랑, 친밀감 등과 연관되고, 이 기능을 다하기 위해서는 가족 내 다른 체계에서 적절히 보호받아야 함

- 전통 한국사회에서는 부부 하위체계의 확립과 기능이 사실상 크게 중요하게 여겨지지 않았음
- 부부유별이 강조되었고 평균수명이 짧아 결혼생활은 자녀를 출산하고 양육하는 생활의 연속에 불과하였음
- 그러나 오늘날 자녀 수 감소와 평균수명 증가로 자녀독립 후 부부만 남는 '빈둥지 시기'의 급격한 증가로 인해, 부부 하위체계의 기능을 회복하는 것이 중요시 여겨지고 있음

2) 부모 하위체계

• 기능
  - 자녀의 발달과 성장을 위한 양육, 지도, 통제 등(자녀의 연령이나 발달단계, 특성에 따라 달라짐)

- 자녀의 연령과 발달단계에 적합한 양육과 지도규칙을 정하고 애정과 통제의 균형을 이루는 권위 있는 부모 역할을 하는 것이 중요함
- 부부 하위체계가 역기능적이면 부모 하위체계가 약화되고 부정적 영향을 받음
- 부모 하위체계와 부부 하위체계가 독립적으로 기능하는 것이 건강한 가족 유지에 중요함

3) 부모-자녀 하위체계

- 부모와 자녀 두 세대로 구성된 체계
- 세대가 다른 사람으로 구성된다는 특징

• 기능
  - 위계구조와 부모의 권위가 확립되어야 구성원 모두가 행복하고 발전하는 것

- 부모의 역할과 책임이 한 자녀에게 이전되는 경우, 그 자녀는 부모화된 자녀가 되어 역기능

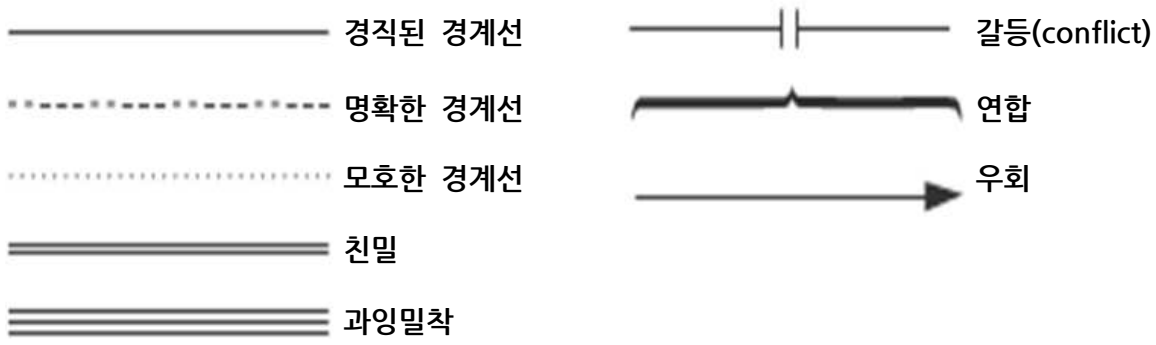
적 부모 자녀 하위 체계가 될 수 있음(어린 자녀는 보호받을 수 있고, 부모역할을 하는 자녀는 자신의 나이 이상으로 책임감, 능력, 자율성을 발전시키게 되어, 자신의 발달과제를 달성하지 못할 수 있음)

4) 형제자매 하위체계

- 동일한 세대에 속한 형제자매로 구성
- 협동 및 협상, 서로간의 차이와 갈등을 해결, 상대방에 복종, 자신을 보호하고 체면을 지키는 법 등을 배울 수 있음
- 형제자매 체계에서 경험적으로 학습한 대인기술은 이후의 대인관계에서 자연스럽게 나타남
- 형제자매 하위체계가 기능적이기 위해서 부모의 자녀 편애, 편 가르기, 비교하는 일이 없어야 하며, 형제싸움에 끼어들지 않는 것이 중요함
- 부모는 형제자매가 갈등이나 문제를 자율적으로 해결하는 기회를 주며, 공평하게 대해야 함

◆ 경계선

- "누가 어떻게 참여하는지를 규정하는 규칙"
- 경계선을 통하여 개인 혹은 하위체계 간 친밀함의 정도, 정보의 상호교환 정도, 문제해결을 위해 서로 상호교류하는 정도를 파악할 수 있음



- 경계선은 가족원 간 지속적인 상호작용의 결과로 정해짐
  · 신혼 초 대부분의 부부는 모호한 경계선을 형성하지만, 이후 상호작용을 통해 경계선의 성격이 결정됨

1) 경직된 경계선

- 구성원들 간 교류가 없는 상태
- 서로 개입하지 않는 유리된 가족
- 지나치게 자율적이고 독립적
- 의사소통이나 보호가 부족함
- 온정과 애정, 접촉 등이 제한 받기 때문에 소외감과 거리감을 느낌

2) 모호한 경계선

- 구성원들이 지나치게 감정적으로 개입되고 지나치게 얽혀서 필요 이상으로 관여함
- 개인 시간이나 개인 영역은 허용되지 않는 밀착된 가족
- 개별성과 독립성 인정하지 않음

3) 명확한 경계선

- 자율적이고 독립적이면서도 필요할 때 협동하고 지지함
- 정체감과 소속감을 느낌

경직된 경계선의 특징	모호한 경계선의 특징
독립 / 자율 / 실험	관여 / 협동 /지지
소외감, 거리감	소속감, 충성심
'나는 나, 너는 너'	'너도 나, 나도 너'
최소한의 접촉과 의사소통	최대한의 접촉과 의사소통

◆ **위계구조**

- 가족의 위계구조를 집이라는 물리적 구조의 '층'에 비유한다면, 여러 층으로 이루어진 건물의 아래 위치한 층은 위층을 지탱할 수 있도록 설계되고 지어져야 함

• 바람직한 위계구조

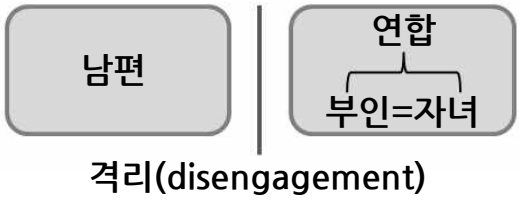
- 부모와 자녀가 분화된 권위를 가져야 하며, 자녀의 성장과 발달에 책임을 지는 부모 하위체계가 자녀하위체계보다 위계구조의 위에 위치해야 함
- 가족의 보편적인 위계구조가 위반되어 가족 상호작용이 일어나는 경우 역기능이 발생할 수 있고, 이는 제휴와 연관이 있음

❖ 동맹

- 이해를 같이하는 두 사람이 제3자와 다른 공동의 이익이나 목적 때문에 공동전선을 펴는 것

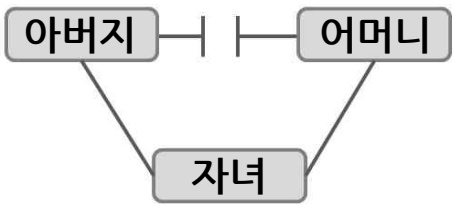
❖ 연합

- 두 사람이 제3자에게 대항하기 위하여 협력하고 연결되는 제휴를 하는 것
- 안정적 연합이 세대를 넘어 형성될 때 가족의 위계구조는 무너지고 역기능적으로 됨
  예) 어머니와 아버지가 갈등을 겪는 경우 어머니가 자녀와 연합하여 아버지를 격리시키고 대항하려고 함→ 부모체계의 권위와 기능이 약화되는 결과 초래



❖ 삼각관계

- 서로 갈등하고 있는 두 사람이 똑같은 제3자(보통 자녀)를 통해 상대방을 제압하려고 하는 연합관계
- 자녀를 자기편으로 끌어들임으로써 상대방에 대해 자신의 우위를 주장하려고 함



6주차 2교시	구조적 가족치료의 치료목표와 치료과정	
	수업목표	구조적 가족치료의 치료목표와 치료과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 구조적 가족치료의 치료목표 2. 구조적 가족치료의 치료과정

1. 구조적 가족치료의 치료목표

◆ 구조적 가족치료의 치료목표

- 구조적 가족치료에서는 문제나 증상의 원인이 역기능적 가족구조로 인식함

• 역기능적 가족의 특성
  - 경계선이 분명하지 않음
  - 경직되거나 지나치게 밀착된 가족
  - 각 하위체계가 제 기능을 다하지 않는 가족
  - 가족의 위계구조가 적절히 확립되지 못한 가족

❖ 구조적 가족치료의 목표
  - 문제나 증상의 제거가 아닌 역기능적인 가족구조의 재구조화(restructuring)에 있으며, 재구조화 과정에서 증상이나 문제가 제거된다고 봄

◆ 가족의 재구조화를 위한 목표

① 부모와 자녀 간의 위계질서 확립
② 세대 간 명확한 경계설정 : 부부 하위체계와 자녀 하위체계의 명확한 경계 확립
③ 기능적 의사소통과 상호교류
④ 부모의 협력관계
⑤ 구성원의 적절한 역할수행

◆ 치료목표 달성을 위해 체크해야 할 사항

1) 가족 위계구조를 적절히 확립
- 적절한 위계구조는 부모가 권위와 책임을 맡고 부모의 권위를 바탕으로 부모-자녀가 세대 간 차이를 인정하는 구조

2) 부모가 연합함
- 부모는 서로 지원하고 서로에게 적응하여 자녀에게 일관된 모습을 보여야 함
- 부모 간 연합이 이루어지지 않을 경우, 자녀가 힘을 갖게 되거나 부모 중 한쪽과 연합을 하여 부모가 제 기능을 할 수 없게 됨

3) 부부의 연합 → 자녀들은 형제자매 체계로 기능할 수 있음
- 부모는 자녀끼리 협상하고 지원하고 갈등이나 차이를 해결하도록 지원함

4) 부부 하위체계는 부모 하위체계와 분리되어 존재

- 부모 하위체계와 별도로 부부만의 독립적인 영역과 시간을 가지고 부부간의 친밀감과 사랑을 증진시켜야 함

5) 분명한 경계선을 갖도록 도움(경직 또는 밀착된 가족일 경우)

- 가족원이 각자 독립적이고 자율적으로 존재하면서도 서로에 대한 보살핌과 지원을 제공할 수 있음

6) 개인 또는 하위체계가 서로 분화하도록 도움

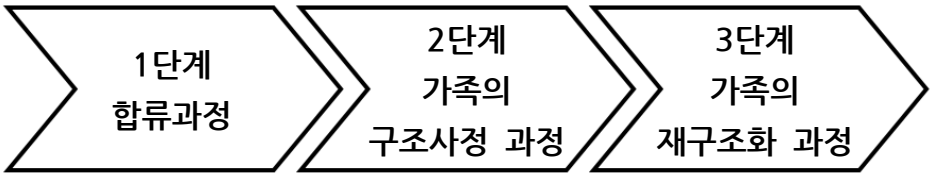
- 자녀의 발달단계에 따른 차이를 존중하고 자녀의 연령에 맞는 활동을 독자적으로 시도할 수 있도록 도움

2. 구조적 가족치료의 치료과정

◆ **치료단계**

❖ 가족개입 단계

- 1단계 : 합류과정
- 2단계 : 가족의 구조 사정 과정
- 3단계 : 가족의 재구조화 과정



1) 1단계 : 합류과정

- 치료자가 가족의 조직과 상호교류 유형을 있는 그대로 수용하고, 가족의 강점을 직접 경험하여 가족체계와 관계를 맺는 단계
- 가족에 합류한다는 것은 외부인의 관점이 아닌 가족의 일원으로서 자연스럽게 가족의 상호작용과 정서체계에 적응하여 가족의 핵심주제를 파악하고 가족원 각자의 느낌을 함께 느끼는 것
- 라포와 비슷한 개념 : 라포는 치료적 관계상태, 합류는 치료적 관계 형성을 위한 치료자의 행동

• 성공적인 합류를 위한 치료자의 행동

- 따뜻하고 수용적인 방식으로 말하기
- 가족원에게 말할 기회를 동등하게 부여하기
- 부정적인 지각을 긍정적인 인식으로 재정의하기
- 취약점이 아니라 강점을 부각하기
- 긍정적 행동을 강화하기
- 내담자의 염려를 확인하기
- 모든 사람이 다루고 싶어 하는 사안을 각각 다루기
- 긍정적 상호작용 분위기를 이끌어내기

- 내담자에게 익숙하거나 의미 있는 언어나 개념 사용하기

❖ 합류는 치료적 관계 형성을 위한 치료자의 자발적 행동으로, 합류를 통해 가족을 있는 그대로 받아들이고 가족의 역기능적인 면 뿐 아니라 기능적인 측면도 부각시켜주어, 가족이 편안함과 안정감을 느끼며 변화과정에 참여하고자 하는 의지를 갖게 될 수 있음

2) 2단계 : 가족의 구조 사정 과정

- 가족구조를 파악하는 작업은 가족의 일반적 특성을 파악하는 작업에서 시작
- 가족구성원의 성별, 연령, 종교, 직업, 가족주기와 발달단계, 사회경제적 지위, 스트레스 상황과 발달적 변화, 현재 제시된 문제 등에 대하여 질문함으로써 기초 정보를 확인함
- 상담실에서의 가족의 행동과 언어 형태, 그들 간의 상호교류 작용, 그리고 자리에 앉는 위치와 가족원 간의 물리적 거리를 관찰하는 것이 중요한 단서가 됨
  예) 어머니와 딸, 아들이 옆에 앉아있는 데 비해 아버지는 뒤로 물러서 있는 경우 부부는 경직된 경계선을 지니고, 어머니와 자녀는 모호한 경계선을 형성함

3) 3단계 : 가족의 재구조화 과정

□ 미누친은 가족이 내적·외적 스트레스에 적응하기 위해서 재구조화될 필요가 있음을 강조하였음

- 가족의 재구조화가 요구되는 상황
  - 한 가족원이 가족 외부세력과의 접촉에서 스트레스를 받는 경우
    예) 실직, 자녀의 또래 괴롭힘 사건 등
  - 가족 전체가 가족 외부 세력과의 접촉에서 스트레스를 받는 경우
    예) 이사, 전염병으로 인한 출입제한 등
  - 가족이 가족생활주기상의 과도기에서 스트레스를 경험할 때
    예) 임신, 출산, 자녀의 사춘기, 은퇴 등
  - 가족의 특수한 문제에서 발생하는 스트레스 상황
    예) 만성질환자 가족, 가족원에 장애 발생 등

- 가족의 경계선을 조정하고, 하위체계가 제 기능을 하도록 도우며, 위계구조를 적절히 확립하도록 도움
- 그 과정에서 가족 상호작용은 불균형에 직면하고 가족이 오랫동안 간직해 온 가족의 신념체계는 도전을 받게 됨

6주차 3교시	구조적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법	
	수업목표	구조적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법을 이해하고, 치료사례를 통해 이를 확인할 수 있다.
	세부내용	1. 구조적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법 2. 구조적 가족치료 사례

1. 구조적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법

◆ 치료자 역할

- 가족구조의 개념에 대한 지식과 신념이 있어야 함
- 가족구조를 나타내는 가족의 상호교류와 그 유형을 관찰해야 함
- 치료자는 지도자적 위치로 적극적으로 가족체계에 개입하며 가족 상호교류방식을 변화시키는데 주도적인 역할을 수행함
- 치료에 앞서 가족지도를 그리고, 관찰과 질문을 통해 수집한 자료를 토대로 가족 상호작용 유형과 경계선을 파악하여 역기능적 구조의 재구조화를 위한 가설 설정, 이를 토대로 치료 목표 세움
- 치료자는 가족을 존중하면서 확고한 방법으로 개입함으로써 변화되기를 원하는 바가 치료 시 일어날 수 있도록 도움

◆ 치료 기법

① 합류를 위한 기법 : 적응, 추적, 모방
② 가족구조 사정을 위한 기법 : 실연, 구조적 지도
③ 가족 재구조화를 위한 기법 : 긴장 고조, 재정의 기법, 경계선 설정, 과제주기 기법

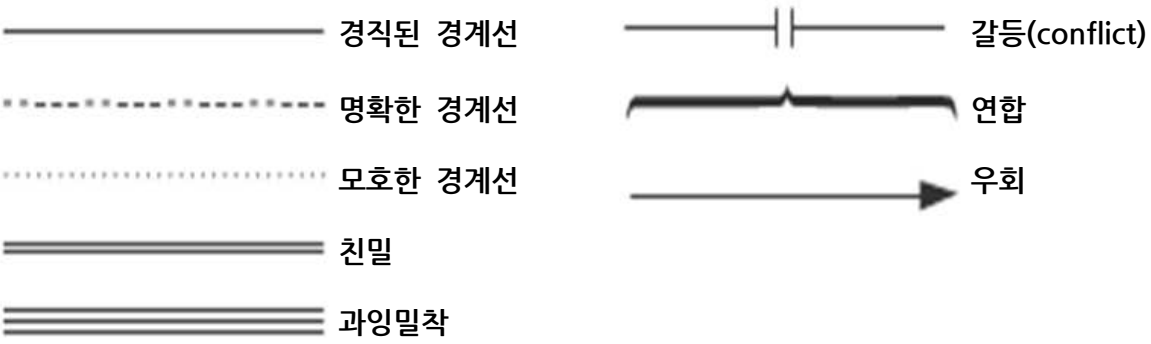
1) 합류를 위한 기법 : 적응, 추적, 모방

- 적응
  - 기존의 가족구조를 지지하면서 참여하는 것
  - 치료자가 가족원 개개인에 대해 부드러운 말씨로 깊은 관심과 배려를 보이며 가족의 현재 있는 위계구나 경계선을 인정하는 것. 그리고 그들의 위치, 개인적 특성과 장점, 가능성을 지지하는 것
  - 가족구성원 개인의 특성을 있는 그대로 받아들이는 것
- 추적
  - 가족의 상호작용과 행동양식을 관찰하고 그들의 대화내용을 따라가면서 가족원들이 계속 이야기를 하도록 격려하여 가족구조와 하위 체계의 기능을 탐색하는 것
  - 치료자는 지지자, 촉진자의 역할 수행하여 가족들이 마음을 열고 상호작용할 수 있도록 도움
  - 새로운 행동으로 이끄는 과정의 필수요소

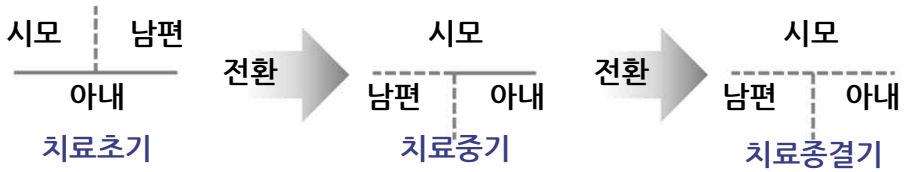
- 모방
  - 치료자가 가족의 어조, 행동유형, 말의 속도와 억양, 몸짓 등을 흉내 내고 따라 하거나 자신과의 유사점을 강조하는 것
  - 이 기법은 치료자에 대한 가족원의 거부감이 적고 친근하게 받아들이기 쉬워서 합류가 용이해짐

2) 가족구조 사정을 위한 기법 : 실연, 구조적 지도

- 실연
  - 가족구성원 간의 역기능적 교류를 상담장면에서 실제로 재현하도록 하고, 역기능적 상호작용을 대체할 수 있는 대안을 가족들이 행동을 통해 연기하게 하는 방법
  - 가족은 자신의 역기능적 상호작용을 분명하게 확인하며, 가족체계 변화의 필요성을 인식하게 됨
  - 치료자는 실연을 통해 가족의 구조를 관찰하고 정보를 얻는 동시에 개입방향을 구상함
- 구조적 지도
  - 가족의 상호작용 구조를 그림으로 나타내는 것
  - 구조적 지도를 통해 상담초기 가족 상호작용 구조 사정과 변화과정 평가, 치료목표 설정에 사용
  - 기호를 사용하여 가족간 관계를 나타냄



예) 치료 전 단계 시모와 남편이 밀착되어 아내 지배,치료 중 시모와 남편 분리, 남편과 아내가 친해짐, 시모와 아내는 소원함, 치료 종결단계 시모와 남편 분리, 남편과 아내가 친해짐, 시모와 아내 친해짐



3) 가족 재구조화를 위한 기법 : 긴장 고조 기법, 재정의 기법, 경계선 설정, 과제주기 기법

- 긴장고조 기법
  - 가족 안에서 반복되고 있는 역기능 행동을 깨닫고 연합이나 동맹 등의 역기능적 구조에 익숙한 기존의 평형상태에서 벗어나 재구조화되도록 일시적으로 가족체계에 스트레스를 증가시키고 도전하는 기법

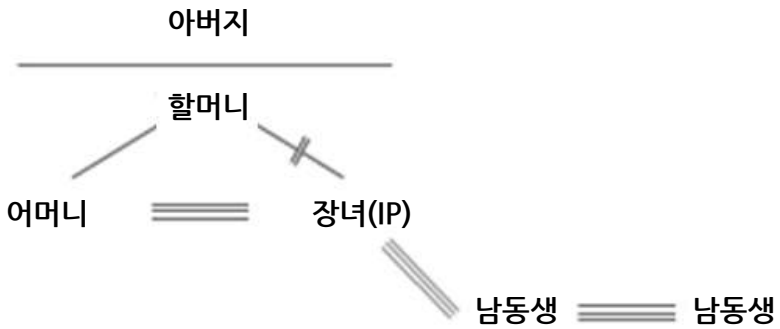
- 재정의 기법
  - 증상을 역기능적 가족구조와 연관해 긍정적 의도를 부각하는 것
  - 가족들이 직면하는 사건이나 상황을 부정적인 시각으로만 볼 때 관계가 악화되지만, 행동 이면의 좋은 동기를 부각시키고, 긍정적인 시각으로 볼 경우 가족의 행동이나 관계를 새롭게 인식하는 계기가 됨
- 경계선 설정
  - 밀착된 가족 : 경계를 분명히 하여 개인의 독립심과 자율성을 키워줌
  - 유리된 가족 : 가까이 접근하고 접촉을 증가하도록 도와줌
  - 부모 하위체계와 자녀 하위체계가 분리되도록 함
- 과제주기 기법
  - 치료자가 가족의 재구조화 진행과정에서 미흡한 부분을 가족원들이 활성화하도록 사용함
  - 재구조화에 도움이 되는 특정의 행동영역을 찾아 과제를 내주는데 언제, 어디서, 누구와 어떻게 상호작용해야 하는가를 구체적으로 분명히 제시함
  - 과제는 가족의 재구조화에 가장 필요한 것이고 파급효과가 가족 전체에 미칠 수 있음. 가족이 할 수 있는 것을 찾아 제시함

❖ 치료기법 적용 시 주의사항
  - 치료자가 가족과 함께 적응하게 되었을 때 활용함
  - 치료자가 내담자 가족의 삶의 방식에 대해 존중의 마음을 갖고 접근할 때 가능함

2. 구조적 가족치료 사례

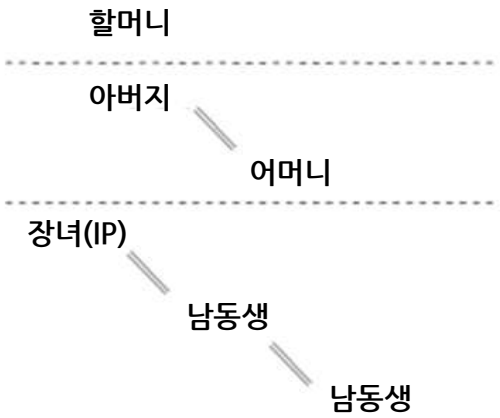
◆ 사례

· IP : 장녀(중2). 1학년 때 출석과 결석 반복함. 2학년 때 45일 정도 결석한 문제로 상담 의뢰됨
· 가족 구성원 : 할머니, 부모, IP, 남동생 2명
· 아버지 : 3형제 중 장남. 직장(회사원)에 전념하여 자녀양육을 어머니에게 위임함. 전근이 많은 직장이라 IP는 초등시절 다섯 번 전학.
· 어머니 : 4남매 중 막내. 나이에 비해 어린 느낌. 어머니 역할에 대한 자신감 부족. 역할을 충분히 하지 못하는 것 같음
· 할머니 : 어머니 대신 가정 일에 관여함
· 남동생들 : 친밀. 함께 누나에게 대들기도 하지만 IP는 동생들을 챙겨주고 배려하며 동생들과 잘 지냄



① 아버지는 위계 상 우위. 가족과 단절 상태
② 할머니가 어머니 자리를 차지하고, 어머니는 자녀와 같은 위계구조에 들어가 IP와 연합을 형성하여 할머니에 대항, IP는 문제행동 유지
③ 할머니와 어머니, 어머니와 IP 및 자녀의 관계가 세대경계를 벗어남

- 초기
  - 치료자는 아버지와 합류, 아버지의 권위 존중, 어머니와 협력하여 할머니가 어머니 역할 대행에서 벗어나 노인대학을 다니도록 함
- 중기
  - 어머니의 위치와 기능 강화를 위해 아버지의 자녀와의 관계 강화 과제 제시. 아버지가 자녀와 함께 학교생활 대화하기, 숙제 봐주기, 아들들과 목욕 함께하기 등 과제 제시 → 부모 하위체계가 명확해짐. 아버지와 자녀의 교류 증가
- 종결
  - 아버지의 협력을 받아 어머니의 역할기능 향상
  - 부모 하위 체계 강화
  - 어머니는 자녀에게 확실한 의견을 말하고 아버지는 어머니를 도움
  - IP 등교거부 사라짐



7주차 1교시	전략적 가족치료의 발달배경과 주요개념	
	수업목표	전략적 가족치료의 발달배경과 주요개념을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 전략적 가족치료의 발달배경 2. 전략적 가족치료의 주요개념 I

1. 전략적 가족치료의 발달배경

◆ 전략적 가족치료의 발달배경

- 초기 의사소통 연구에 기초하여 일반체계이론, 사이버네틱스, 정보이론 등과 밀접한 관련을 가지면서 독자적인 이론의 틀을 구축하였음
- MRI 모델, 헤일리 전략적 구조주의 모델, 밀란의 체계적 모델로 나뉨
- 가족문제는 특정 가족원의 개별적 문제가 아니라 가족 전체의 역기능적 상호작용과정과 위계로 발생한다고 보는 관점이 있음
- 전략적 모델의 일차적 치료목표는 제시된 문제의 해결이지만, 증상은 사회적 맥락에서 일어나기 때문에 내담자 가족을 둘러싸고 있는 사회관계망까지 치료과정에 포함시키고자 함

◆ 개요

- 전략적 가족치료는 캘리포니아 팔로알토(Palo Alto)에 위치한 정신건강연구소(Mental Research Institute: MRI)에서 이루어진 가족의사소통 연구 프로젝트에서 시작
- 서부 MRI에서 시작된 전략적 접근은 이후 동부 워싱턴과 이탈리아 밀란으로 거점을 확대됨
- 가족의 반복적인 역기능적 행동에 직접적으로 개입하여 변화를 유도하는 접근. 간결한 기법과 단기적이며 효율적인 개입을 함

• 세 가지 치료모델의 공통점
  - 순환적 인식론을 이론적 기반으로 하며 의사소통에 관심을 가짐

❖ 세 가지 전략적 치료모델 특징 비교

	MRI	헤일리	밀란
치료자	잭슨, 바츨라비크	헤일리	셀비니-파라졸리
근거 이론	의사소통이론		일반체계이론
주요 개념	의사소통, 이중구속, 피드백고리, 가족항상성, 가족규칙	권력, 통제, 위계구조,역설	가족게임, 순환질문, 중립성
일차적 관심	의사소통 유형	연쇄과정 및 구조적 위계	역기능적 가족게임
행동의 지속성	단기적, 현재 연쇄적 상호작용	단기연쇄, 장기적인 구조적 문제	과거와 현재의장기적 연속행동

치료 단위	2인 또는 3인	가족 또는 사회관계망	3인
치료 목표	증상제거 및 현재의 행동 변화		파괴적 가족게임의 중지 의미변화로 가족체계 변화

◆ MRI 상호작용 모델

- 의사소통의 '내용'보다는 '과정'이 문제라고 보았음 → 이는 가족치료의 초점을 개인의 심리내적 역동에서 문제를 유지시키는 상호작용으로 전환시킴
- MRI 모델에서는 현재 증상과 문제가 유지되게 하는 피드백 고리를 찾고, 이러한 역기능적 상호작용이 유지되게 하는 가족규칙을 파악한 다음, 가족규칙을 변화시키는 구체적인 전략을 세워서 개입
- 10회 면접의 단기에 종결

◆ 헤일리의 전략적 구조주의 모델

- 의사소통이론과 역할이론에 관심을 갖고 송신자와 수신자가 교환하는 메시지에 내재된 통제와 권력투쟁에 주목함
- 가족원 중 '누가 의사결정에 영향력이 있는가?', '누가 관계를 정의하는가?'와 같은 쟁점에 근거하여 가족의 역동 관찰
  · 역기능적인 가족은 위계구조가 혼란스러워 세대 간 권력의 순서가 거꾸로 놓여 있거나 세대간 연합의 특징을 보임→ 이러한 가족은 가족체계의 항상성에 고집스럽게 집착하며, 상황 변화에 융통성이 없어 변화에 적절하게 대처하기 어려움
  ⇨ 따라서 문제를 해결하려고 시도하지만 결국 자신들의 역기능적인 연쇄 과정에서 벗어나지 못하게 됨
- 헤일리는 이런 가족을 치료적 이중구속에 빠지게 하여 역설적 개입을 사용하여 자발적으로 증상을 포기하도록 함
  · 치료적 이중구속 : 치료자가 언어적으로 증상을 계속하라고 지시하지만 그러한 가족의 반응에 대해 불편함을 신체적으로 보이는 것

◆ 밀란의 체계적 모델

- 증상 발생과 유지에 관련되는 가족의 역기능적 상호작용 규칙인 '게임규칙'에 초점을 두고 역설적 접근을 통하여 게임규칙에서 벗어나게 하는 접근을 함
- 통상, 남녀 치료자가 공동치료 시행하고 상담장면을 관찰하는 남녀 치료자로 구성된 팀이 같이 작업함

• 특징
  - 총 10회 이내로 제한. 회기 간격이 한 달 정도(한 달에 1회기) - 회기 간 간격이 긴 이유는 내담자 가족이 역설적 처방의 효과에 반응할 충분한 시간이 필요하기 때문

- 가족의 고착된 잘못된 신념체계에 개입하여 가족체계에 새로운 정보를 유입시켜 역기능적

가족관계 유형을 변화시키고자 함

2. 전략적 가족치료의 주요개념 I

◆ 의사소통

- MRI 모델에서 관심을 보임

❖ 의사소통의 공리(의사소통의 다중적 측면 강조)

① 인간의 모든 행동은 의사소통 행동이다.
- 침묵도 의미를 담고 있다.

② 모든 의사소통은 내용과 관계의 두 가지 측면을 갖고 있음
예) "엄마, 오빠가 날 때렸어요" 이는 오빠의 폭력에 대한 정보 전달과 함께, 엄마가 오빠를 벌해 주기를 바라는 부탁을 포함함

③ 마침표는 의사소통의 중요한 측면임
- 마침표는 상호작용의 흐름 속에서 무엇이 자극이고 무엇이 반응인가의 개념
- 역기능적 의사소통이 지속되는 것은 대화 참여자가 각자 어디에 마침표를 찍었는지에 대해 대화하지 못하고 자기중심적인 마침표에 집착하기 때문

④ 의사소통하는 관계는 대칭적이거나 보완적 관계
- 관계가 평등하면 '대칭적', 그렇지 않으면 '보완적'

예) 남편이 자기주장을 할 때 아내가 복종적이고 수동적으로 반응하면, 상위에 있는 남편과 하위에 있는 아내의 구도는 불평등 관계 형성

· 그러나 건강한 관계는 하나의 유형에 고착되기보다 상황에 따라 대칭적 또는 보완적 의사소통이 상호 교환적으로 나타날 수 있는 융통적인 관계

⑤ 메타 커뮤니케이션(의사소통에 대한 의사소통)이 중요함
- 메타 커뮤티케이션은 가족관계의 성장을 돕는 긍정적인 의사소통 방식이 될 수 있음

예) "우리가 싸우는 방법은 너무 극단적인 것 같아", "네가 화날 때 침묵하는 습관은 나를 힘들게 해"

· 메타 커뮤티케이션을 통해 자신의 욕구를 정직하게 말하고 관계를 건설적으로 다룰 수 있음

◆ 이중구속

- 개념(MRI 모델에서 발표한 개념)

· 권위나 권력이 있는 사람의 언어적 메시지와 비언어적 메시지가 상반되거나 모순될 때 상대방이 혼란과 갈등을 겪는 상태

- 부모-자녀관계에서의 지속적인 이중구속 상황은 자녀를 갈등과 불안에 빠지게 하며 궁극적으로 사회적 판별능력을 마비시켜 조현병과 같은 역기능을 일으킬 수 있음을 경고

◆ 피드백 고리

- 개념(MRI 연구팀에서 도출된 개념 중 하나)

· 역기능적인 가족은 문제를 해결하기 위해 새로운 시도(정적 피드백)를 하지만 문제가 악화되는 것을 보고 당황하여 기존의 의사소통 방식(부적 피드백)으로 돌아감
· 이는 문제를 악화시키며 결과적으로 부정적 순환을 가져옴

◆ 가족항상성

• 개념(MRI 연구팀에서 도출된 개념 중 하나)
· 가족이 변화에 저항하여 원래의 상태를 유지하려는 성질

- 역기능적인 가족에서는 어려움이 발생하면 가족 항상성(변화보다 안정성 추구) 때문에 종전의 방식으로 반응함
- 이는 변화를 성장의 기회라기보다 가족에 대한 위협으로 지각함
- 역기능적인 가족은 기존체제의 안정을 위해 더 많은 에너지를 쏟음

◆ 가족규칙

• 개념(MRI 연구팀에서 도출된 개념 중 하나)
· 가족의 의사소통과 행동을 제한하는 관계상의 합의. 가족항상성을 유지하는 기능

- 기능적인 가족은 해결책이 효과가 없으면 바꿀 수 있을 정도로 규칙이 융통성 있고, 변화가 필요 없거나 변화시킬 수 없는 일을 변화시키려고 노력하는 비현실적 생각을 하지 않음
- 가족규칙은 많은 일반적 규칙 위에 작용하는 규칙을 총괄하는 규칙이 존재함
- 그러나 역기능적인 가족은 가족규칙 변화에 대한 상위 규칙은 없고, 가족규칙을 언급하거나 변경할 수 없다는 상위 규칙만 존재함

7주차 2교시	전략적 가족치료의 치료목표와 치료과정	
	수업목표	전략적 가족치료의 주요개념을 이해하고, 치료목표와 치료과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 전략적 가족치료의 주요개념 II 2. 전략적 가족치료의 치료목표와 치료과정

1. 전략적 가족치료의 주요개념 II

◆ 권력과 위계

- 헤일리의 주요 관심은 권력과 통제, 위계구조이며 이는 구조적 치료모델 개념과 같음
- 헤일리는 증상이 가족항상성을 유지하기 위해 존재한다고 보았으며, 동시에 P가 증상을 통해 가족원을 통제한다고 보았음
  예) 아내의 불안발작 증상은 무의식적으로 남편이 자신의 곁에 있도록 통제하는 전략. 아내가 증상에 대해 무기력하게 행동함으로써 남편은 직장에서 일찍 퇴근하게 됨. 이는 증상을 통해 아내가 남편과의 관계에서 권력과 통제를 얻고 있음

• 기능적인 가족
  - 가족 내 위계질서가 제대로 서 있음. 부모는 부모로서, 자녀는 자녀로서, 조부모는 조부모로서의 위치가 제대로 지켜져야 하며, 윗세대는 아랫세대보다 위계적으로 상위에 있어야 함

- 자신의 위치에 맞는 권력과 통제를 가질 때 위계질서가 유지되며 힘의 균형이 깨지면 위계질서에 문제가 발생함
  ⇨ 증상을 해결하기 위해서 치료자는 관계 이면의 권력과 통제를 파악해야 하며 권력투쟁에 관한 가족관계를 파악함으로써 명확한 치료목표 설정과 구체적인 개입방식을 계획할 수 있음

◆ 역설적인 개입

- 가족은 치료자가 그들을 변화시키려고 하면 저항하게 되는데, 이는 치료자가 가족의 안정성을 흔들고 통제하려 한다고 인지하기 때문
- 치료자와 가족 간 은밀한 힘겨루기가 일어남
- 역설적 개입은 '통제와 조절'
- 상담장면에서 이중구속 상황을 만들어 내담자 가족이 통제할 수 없는 증상 행동을 포기하게 하여 문제를 해결함
- 다른 치료방법이 효과적이지 않고 가족을 통제하기 어려울 때 사용하는 것이 좋음

◆ 가족게임

- 밀란 모델에서 사용한 개념
- 역기능적 가족 내에서 작동되는 복잡한 가족 상호작용

- 역기능적 가족에서는 모든 가족원아 게임 규칙에 합의하지 않으면서 서로 힘을 얻기 위해 끝없는 게임을 함
- 승자도 패자도 없는 이 더러운 게임(dirty game)은 순환적인 연쇄과정을 이루기 때문에 원인과 결과를 정확히 구분할 수 없음
- 증상은 게임을 의미하며 치료자는 이 게임을 멈추기 위해서 역설적 개입을 하는 것이 효과적이라고 보았음
- 그러나 후기 밀란 모델은 역설적이고 지시적인 접근보다 협동적인 형태로 전환되었음

◆ 순환질문
- 밀란 모델에서 사용한 개념
- 가족원 모두에게 현재 체계가 어떠한지, 왜 그러한지, 가족상호작용 유형이나 관계 등에 대하여 질문하는 것

• 효과
  - 가족원 간 지각의 차이를 확인하고, 구체적인 가설 설정에 유용한 정보를 얻으며, 가족원들이 증상 행동이나 문제를 순환적 관계맥락에서 보게 되어 가족문제를 새롭게 인식하게 됨

• 순환적 인식론
  · 가족원 한 사람의 증상 행동이 다른 사람 행동의 원인이거나 반응이라고 할 수 없고, 가족 중 누군가의 안녕과 보호에 중요하고 가족통합과 항상성 유지에 필요한 것이라고 봄
  예) 가족원 한 사람이 게으르다고 하는 것은 성격적 특질이라기보다 다른 구성원과의 관계맥락에서 상황적이고 순환적 측면을 고려해야 한다는 것

◆ 중립성
- 가족과 관련된 치료자의 태도나 행동패턴에 관한 것
- 치료자는 가족의 구체적인 행동을 규정하지 않으면서 가족의 치유능력과 해결책을 발견하도록 도움

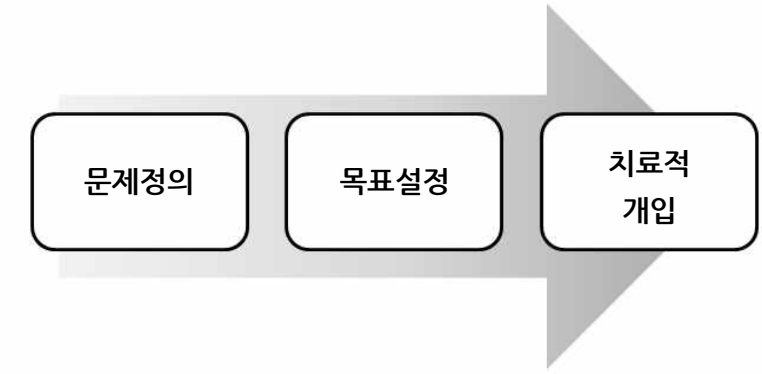
2. 전략적 가족치료의 치료목표와 치료과정

◆ 치료목표
- 전략적 가족치료의 일차적 치료목표는 제시된 문제를 해결하는 것
- 더 나아가 행동을 규제하는 가족체계의 변화
- 치료목표는 구체적으로 설정함
- 핵심목표는 제시된 문제의 해결이지만, 증상이라는 것은 사회적 맥락에서 일어나는 것이기 때문에 내담자 가족을 둘러싸고 있는 사회관계망까지 치료과정에 포함시키고자 함
  예) 비행 청소년의 상담에는 청소년 전문가나 학교 교사, 보호 관찰관이나 변호사를 참여시키기도 함
- 헤일리의 경우 가족생활주기에 관심을 가졌음

- 치료목표에 가족생활주기에 따른 이행기의 과업 달성과 성장을 포함시키기도 함
- 가족의 문제가 가족생활주기의 이행기에 발생하기 쉽다고 보았고, 잘못된 문제해결 방식으로 고착된 경우 문제를 잘 극복하여 성장하도록 도움으로써 다음 발달단계로 나아갈 수 있도록 하는 것을 치료목표의 일부로 설정하기도 함

◆ 치료과정

- MRI 상호작용 모델, 헤일리의 전략적 구조주의 모델, 밀란의 체계적 모델 모두 치료과정은 구조화된 방식으로 진행됨



1) 문제정의

- 문제의 정의는 주로 초기 면접 동안 이루어짐
- 문제는 구체적이고 행동적인 용어로 표현함
- 치료자는 내담자 가족이 이제까지 문제해결을 위해 시도했던 여러 해결책에 대하여 알아보고자 함
- 가족들의 시도된 해결책이 문제를 유지시키는 가족의 연쇄과정을 유발했다고 보기 때문
- 가족의 상호작용을 관찰하고, 특히 부모-자녀 관계 문제의 경우 세대 간 위계관계에 초점을 둠
- 가족의 의사소통 방식, 연합, 삼각관계, 권력, 위계 등 관찰
- 이를 통해 앞으로 진행될 치료 개입을 위한 단서를 포착하기 위한 노력이 필요

2) 목표 설정

- 가족이 해결하기를 바라는 문제에 대한 어떤 변화를 추구할 것인지를 밝힘
- 변화하기 원하는 부분은 가능한 한 구체적이고 행동적인 언어로 표현되어야 함
- 가족사정을 통해 가족위계와 가족 문제와의 관련성 파악
- 목표 설정 단계에서는 문제에 대한 체계적인 관점을 얻기 위해 진단을 하며, 이 결과는 구체적인 치료계획의 근거가 됨

3) 치료적 개입 단계

- 문제 상황에 따른 개별적인 맞춤형 전략 사용 선호
- 정밀한 관찰을 토대로 문제증상과 관련된 가족 상호작용의 연쇄 과정을 파악한 후 이를 바꿀 개입전략을 세움
- 치료과정에서 주어지는 과제는 면밀히 고안되고 가족체계의 변화를 위한 것이어야 함

- 과제는 내담자의 동기와 성취감을 고려하여 가능한 한 작은 것으로 설정
- 직접 지시 또는 역설적 개입(증상을 계속 실행하라고 지시) 등 개입방법을 정할 때 문제에 따라 전략을 계획하여 가족의 행동변화와 가족체계의 변화를 일으키도록 고안함
- 전략적 가족치료는 관찰팀과 함께 작업함. 관찰팀은 일방경 뒤에서 가족 상호작용과 치료 장면을 보면서 인터폰을 통해 치료자에게 직접 지도감독이나 지시를 하기도 함

7주차 3교시	전략적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법	
	수업목표	전략적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법을 이해하고 사례에 적용할 수 있다.
	세부내용	1. 전략적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법 2. 전략적 가족치료 사례

1. 전략적 가족치료의 치료자 역할 및 치료기법

◆ 치료자 역할

1) 전략적 기술

- 치료 중 내담자의 저항을 처리하기 위한 전략을 세우는 전략가
- 치료과정에서 각 가족에게 적합한 구체적인 치료계획을 가지고 지시적으로 접근하며, 내담자 가족에게 치료자의 지시를 잘 따라 줄 것을 요구함

2) 활동성과 강한 책임감

- 내담자의 문제해결과 변화에 대한 직접적인 책임을 짐

3) 통제와 권위의 유지

- 치료과정을 치료자와 내담자 간 권력다툼으로 보고 이 권력투쟁의 결과가 치료결과에 영향을 미친다고 봄
- 치료 상황에 대한 통제를 잃지 않아야 하고, 내담자에 대해 권위를 가져야 함

• 주의할 점

  - 치료자의 권위가 권위주의적인 것과는 차별화되는 편안하고 융통성 있는 권위여야 함

4) 밀란 치료자의 중립성

- 다른 모델의 치료자들의 지시적인 역할과 차별화되는 입장
- 중립적인 위치에서 가족이 스스로 신념체계를 검토하며 해결책을 찾아가도록 조력하는 역할을 함

MRI	헤일리	밀란
지시적, 역설적	통제적, 능동적, 역설적	중립적, 치료동반자

◆ 치료기법

❖ 가족치료 모델 중 가장 기법 위주의 접근, 모델마다 치료자 역할과 기법이 다름

MRI	헤일리	밀란
증상 처방, 역설적 지시, 재정의	증상 처방, 역설적 지시,고된 체험기법, 가장기법	순환질문, 의식 처방, 불변의 처방

1) 증상 처방

- 역설적 개입의 일종
- 내담자에게 증상행동을 자발적으로 계속하도록 격려하는 지시나 과제는 주는 기법

- 그 결과 내담자는 치료자의 지시를 거부하고 증상을 버리든지, 혹은 지시대로 순종해서 증상이 본인의 통제권 하에 있음을 인정하든지 선택하게 하는 것
  예) 우울증으로 고통을 겪는 사람에게 하루에 세 번씩 1시간 동안 우울하게 되도록 노력하라고 이야기함 그 가족은 그가 우울하도록 격려하라고 처방. 그 결과, IP는 우울 증상을 포기하게 되고 가족은 그의 기분을 돌이키려고 비효과적인 노력을 하지 않고 죄책감을 느끼지 않을 것임

2) 역설적 지시
- '변하지 말라'는 메시지와 '변하라'는 메시지가 동시에 전달됨
- '변하지 말라'는 치료자의 메시지에 대해 내담자가 충실히 따르자니 이미 증상을 통제할 수 있게 되었고, 치료자의 메시지를 따르지 않는다면 증상을 포기하고 변해야 하는 치료적 이중구속 상황

❖ 재정의 → 처방 → 제지

• 재정의
  - 증상을 긍정적 의미로 재명명
• 처방
  - '우울하게 행동하라'와 같이 수용하기 어려운 증상 처방
• 제지
  - '천천히 변하라'

3) 재정의 기법
- 문제행동에 새로운 의미부여. 증상의 의미와 의도를 긍정적으로 재명명하여 생각을 바꾸는 것
- 증상이 가족체계의 안정과 가족 응집을 돕기 때문에 긍정적이라고 의미를 부여하여 역기능적인 가족게임을 무력하게 만드는 기법
  예) 잔소리하는 것을 관심이 많은 것으로 재정의. 불평에 대해 친밀감 욕구의 표현으로 재정의
- 가족원 각자의 행동이 IP 증상과 관련되는 역기능적인 가족게임을 인식하게 되고, 증상이 자발적임을 알게 됨
- 가족원 간에 상대방의 행동 동기와 의도가 긍정적임을 알게 되면서 다른 구성원을 긍정적으로 보게 되며, 치료자와 다른 가족원에게 이해 받는다고 느껴서 변화에 대한 저항을 줄이고 변화 동기를 높여줌

4) 고된 체험 기법
- 증상이 나타날 때마다 원래 증상의 고통보다 더 괴로워하는 일을 수행하도록 지시하는 기법
- 내담자가 증상을 유지하는 것이 더 고통스럽다는 것을 알게 되면 증상을 포기할 수 있다는 전제
  예) 고부갈등을 겪는 여성에게 시어머니에 대한 불평과 원망이 들 때마다 시어머니에게 비싼 선물을 드리도록 지시하는 것, 불면증이 있는 내담자에게 밤새워 책을 읽으라고 하는 것 등

- 고된 체험의 과제는 증상을 갖는 것보다 더 고된 체험의 결과가 있다면 차라리 증상을 포기하는 것이 낫게 하여 증상을 버리도록 하는 것

5) 가장 기법

- 하지 않던 행동을 상상과 놀이로 생각하면 좀 더 잘할 것이라는 전제를 갖고, 증상을 가진 '척하고' 상대방을 '돕는 척'하라고 지시함
- 긴장 상황이나 반항심을 유발하는 대신 놀이를 하는 기분으로 저항을 우회시킴

  예) 분노발작 문제를 가진 아이와 이를 통제하지 못해서 상담실에 온 어머니에게 치료자는 아이에게 분노발작을 일으키는 '척하라'고 함. 아이가 '나는 헐크야'라며 험상궂은 표정을 하고 고함치는 행동을 하자 치료자는 '너는 상상력이 풍부하구나!'라며 아이를 칭찬하고 어머니에게도 아이를 잘 키운 것을 칭찬함. 과제로 아이에게 엄마 앞에서 시간을 정해 분노발작을 일으키는 척하는 행동을 하고 그럴 때마다 어머니는 아이가 좋아하는 간식을 주라고 함. 과제를 실행한 어머니와 자녀는 긴장된 상황이 아닌 연극적인 놀이를 하게 되어 통제할 수 없는 증상을 자발적으로 통제할 수 있음으로써 문제가 해결되게 됨

6) 순환 질문기법

- 밀란 모델의 독특한 기법
- 각 가족원에게 돌아가면서 가족 상호작용이나 가족관계에 대해 이야기하게 하는 대화기법
- 순환질문을 통해 내담자 가족은 개별 가족원의 반응을 경청하면서 가족을 새롭게 인식하는 경험을 하게 됨
- 문제를 개인의 증상문제로부터 가족의 관계맥락문제로 보게 됨

7) 의식 처방

- 일정한 가족의식을 구성하여 역기능적인 가족게임을 과장해 연출해봄으로써 가족원들이 가족게임과 역기능에 대해 명확히 인식하게 하는 기법

  예) 거식증 딸, 과보호하는 어머니, 비난하는 아버지. '일주일 중 하루를 정해 온 가족이 모여 딸은 증상을 유지할 수 있도록 도와주는 부모님에게 감사하는 말을 하고, 어머니는 딸을 더 감싸고 보호하는 행동을 하며, 아버지는 더 강하게 어머니를 비난하는 행동을 하는 시간을 가지십시오.' 라는 과제 제시. 그 결과 가족원은 의식에 참여함으로써 자신들이 얼마나 어리석은 행동을 계속하고 있는지 깨닫게 되어 가족게임이 중단되고 문제증상이 사라졌음

❖ 처방 : 다음과 같은 역설적 지시를 함

① 가족이 모두 참여하여 문제를 말하면 치료자는 가족게임을 파악하여 다음 회기에 누구와 상담할지 연락할 것이라고 말함

② 부모와 자녀가 문제와 개선 정도, 원하는 것 이야기함

③ 부모만 온 상태에서 부부관계와 상호작용 패턴, 그리고 다른 가족원의 반응에 대해서 질문함. 상담을 가족에게 비밀로 하라는 과제를 줌

④ 1주일에 1회 한 시간씩 부부가 비밀리에 집에서 사라지고 매일 가족원의 반응을 기록하는 과제를 설명하고, 외출 메시지만 남기고 모든 것은 비밀로 할 것을 처방

⑤ 부부 일지 확인. 부부의 비밀 외출 시간을 주 1회 2시간씩으로 변경. 시간을 점차 늘려나감

⑥ 변화를 확인하고 상담 종결

2. 전략적 가족치료 사례

◆ 적용사례

· 1년 차 신혼부부
· 주 호소 문제: 성격차이로 말미암은 부부갈등과 대화곤란, 부부간 폭력

1) 1회기 : 부부 각각의 호소 문제 파악하기
- 남편 : 아내가 화가 나면 말을 하지 않고, 자신은 미칠 것 같고 물건을 부수거나 아내를 걷어차고 때린 적도 있음. 그 때문에 아내가 자살한다고 손목을 그었을 뿐 아니라 남편도 마찬가지로 손목을 그은 적이 있음
- 아내 : 남편과 갈등이 생기면 말하기 싫고 기분이 나쁘면 말하기 싫어짐. 남편이 말을 시키면 기분이 나빠져 더 말을 안 함

2) 2회기 : 상담목표 구체화
- 가설과 치료목표 설정
  - 남편 : 관계유지에서 대화를 통하여 서로 배려하는 방식을 갖고 있음
  - 아내 : 자신의 일을 먼저 하고 상대방과 관계를 하는 방식을 갖고 있음
  - 남편이 부인의 말과 행동을 따지는 방식은 부인과 친해지려는 시도이고, 이를 통해 부인을 통제하고 부인보다 우위에 있으려 함
- 상담목표
  - 남편(신체적 폭력을 하지 않는 것)
  - 부인(냉정해지거나 남편으로부터 도망치지 않는 것)

3) 3회기 : 대화 형태 변화시키기
- 남편 : 소리 지르지 않고 아내를 때리지 않겠다는 약속을 하도록 지시
- 아내 : 남편에게 친절하게 말하며 기분 나쁜 이유를 설명하도록 지시

4) 4회기 : 변화를 위한 지시
- 남편 : 아내에게 부드럽게 말하는 것
- 아내 : 밝은 얼굴로 웃는 것

5) 5회기
- 부부를 따로 상담하고 상처받는 상황과 감정에 대해 공감하고 이해하게 함

6) 6회기
- 서로에 대해 원하는 것을 표현하도록 함

7) 7회기
- 서로에게 원하는 것을 표현, 글로 써서 가져오기 과제

8) 8회기
- 편지를 통해 갈등상황을 효과적으로 다루고 있고, 남편의 폭력과 아내의 말 없음과 냉정함이 없어짐

9주차 1교시	포스트모더니즘과 2차 사이버네틱스	
	수업목표	포스트모더니즘과 2차 사이버네틱스를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 포스트모더니즘 2. 2차 사이버네틱스

1. 포스트모더니즘

◆ 포스트모더니즘



❖ 출처 : 가족치료의 이해, 정문자 · 정혜정 · 이선혜 · 전영주, 학지사, p. 27.

- 1980년대 미국에서 가족치료는 일반 대중에게 널리 알려져 있었고, 전문 분야로 인정받게 되었음
- 초기 가족치료 이론은 일반체계이론과 사이버네틱스를 기초로 발전
- 가족의 기능/역기능을 사정하기 위한 다양한 개념을 개발하고 가족을 변화시키기 위해 다양한 기법을 발전시키는 데에 초점을 두었음
- 초기 가족치료 모델은 문제나 증상을 정의할 수 있는 개념들을 제시하였고, 치료를 위하여 치료자는 특정 치료적 기법을 습득하는데 노력을 기울였음
  ⇨ 이는 서구사회를 지배한 모더니즘의 영향이 컸음

◆ 모더니즘과 포스트모더니즘의 비교

1) 개념적 비교

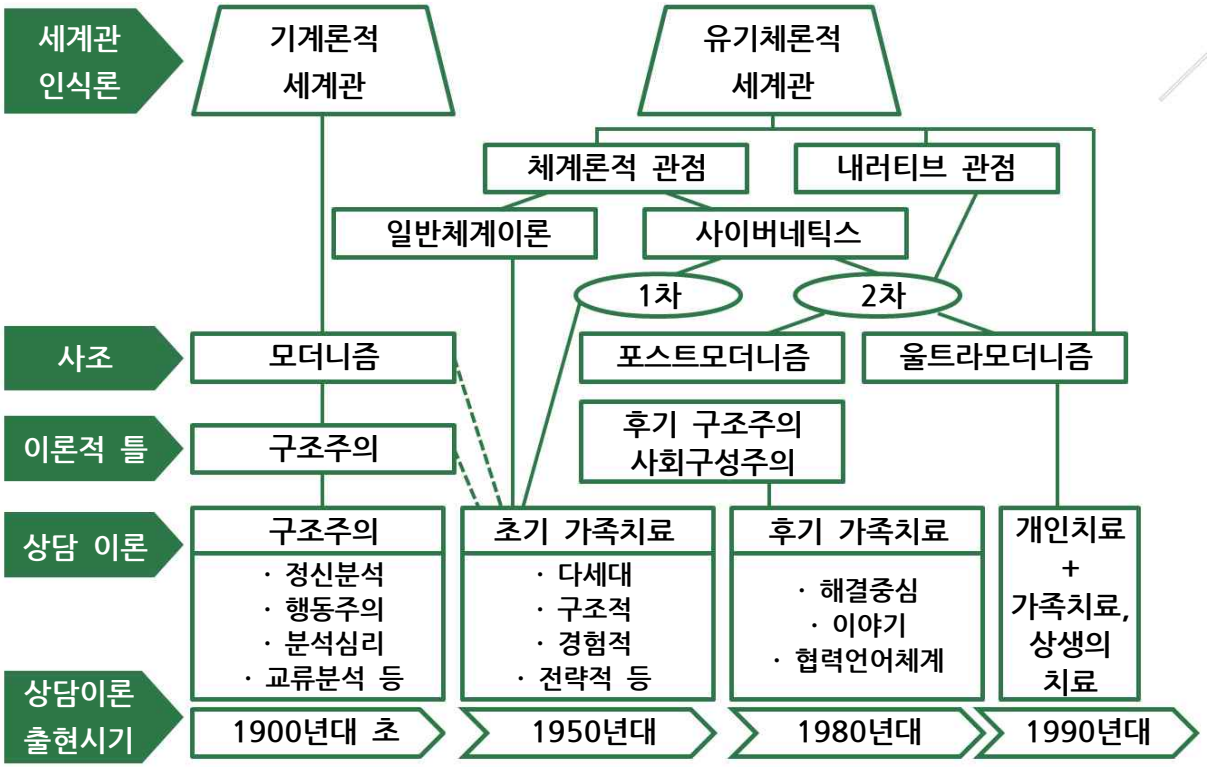
- 모더니즘
  · 본질주의, 보편주의, 이분법적 사고
- 포스트모더니즘

· 다양성, 차이, 비본질주의 강조

2) 치료적 접근 비교

- 모더니즘
  · 특정한 사회적 맥락에서 수용되는 기준과 표준에 따라 행동을 사정하고 변화시키려 함. 인간의 문제를 문제중심적으로 접근하며, 인성적인 특성이나 가족 상호작용이 기능적인지(또는 역기능적인지)에 중점을 두었음
- 포스트모더니즘
  · 무엇이 기능적이고 역기능적인가는 보는 사람의 시각에 따라 달라진다는 점을 강조. 가족의 기능/역기능 여부는 단일한 기준에 의해 평가될 수 없고 개인적인 경험이나 가족이 처한 상황을 고려하여 평가해야 함

◆ **모더니즘, 포트스모더니즘, 울트라모더니즘**



2. 2차 사이버네틱스

◆ **2차 사이버네틱스 개념**

- 2차 사이버네틱스라는 용어는 1968년 영국의 인류학자인 미드(Margaret Mead)에 의해 처음으로 제안되었음
- 모든 수준의 체계는 피드백 과정을 통하여 환경과 상호작용하며, 가장 높은 수준의 피드백 과정에서 볼 때 모든 체계는 자기조직적임을 기술

◆ **2차 사이버네틱스 속성**

• 1차 사이버네틱스 시각에서의 체계의 속성
  - 경계, 의사소통, 규칙, 정서체계 등
• 2차 사이버네틱스 시각에서의 체계의 속성
  - 1차 사이버네틱스에서 제시한 속성 + 자율성, 자기제작/자기조직, 자기준거성, 구조적 연결, 구조적 결정론, 부적 피드백 등

1) 자율성

• 개념
  · 체계의 구조와 그 작용의 질서가 환경에 의하여 일방적으로 주어지는 것이 아니라 체계 그 자체에 의해 만들어지는 것

❖ 체계의 조직 vs. 체계의 구조
- 체계의 조직은 그 조직이 특정 집단에 속하는 것으로 특징짓는 구성요소 사이의 일련의 관계
- 체계의 구조는 구성요소 사이의 실질적인 관계에 의해 구성됨

- 가족이라는 조직도 스스로를 통제하는 기능을 가진 사람들의 집단으로, 자율적 체계이며, 구성요소 사이의 일련의 관계에 의해 핵가족, 한부모가족, 재혼가족 등의 구조를 가짐
- 피드백을 통해 가족을 자율적으로 조직하고 조절하여 가족의 정체성을 유지함. 이것이 깨질 때 가족의 해체가 일어남

2) 자기제작/자기조직

• 개념
  · 체계의 조직 내 구성요소는 연결망을 이루어 각 구성요소는 다른 구성요소의 생산이나 변형에 참여하는 방식을 통해 지속적으로 체계 스스로를 제작함

□ 마투라나와 바렐라에 따르면, 인간은 언어와 의사소통을 자신들의 자기제작을 실현시키는 매개물로 봄. 즉, 언어를 인간의 의식과 문화의 발전에 결정적인 기여를 한 현상으로 꼽았고, 인간사회의 사회단위는 언어의 교환을 기초로 자기제작을 실현한다고 보았음
  예) 가족체계를 순환적 대화의 연결망으로 규정. 가족의 역할과 경계는 모두 대화의 자기제작하는 연결망에 의해 유지되고 재조정됨

- 인간이나 가족체계가 자기제작/자기조직적이며, 그것은 의사소통을 통해 실현된다는 인식은 사회구성주의의 기본 인식론으로 발전하였음

3) 자기준거성

- 사람이 세계를 인식하는 과정은 객관적인 관찰을 통해서가 아니라 관찰자의 마음에 따라 이루어짐→ 따라서 그가 얻은 관찰결과는 그의 마음에 의해 좌우됨. 즉, 자기준거적 성질을 띰

• 가족치료적 맥락
  - 문제진단에 대한 기술이나 치료목표 설정 등이 치료자의 가치와 인식론에 기초하게 되므로, 치료자는 자기준거성에 대해 인식하고 있어야 함

4) 구조적 연결

• 개념

· 자율적이고 자기제작하는 체계는 그 조직 패턴을 보존하면서 동시에 지속적으로 구조적 변화를 수행함

- 유기체는 '구조적 연결'을 통해, 즉 순환적인 상호작용을 통해 환경과 상호작용함. 환경은 단지 구조적 변화를 촉발시킬 뿐 환경이 체계의 구조적 변화를 구체적으로 지정하거나 지시하지 않음

• 가족치료에 적용해보면
  - 가족치료에 적용해보면 치료자의 치료적 행위에 의해 그 가족의 행동이 결정되는 것이 아니라, 내담자의 문제해결이나 변화는 가족의 구조적 패턴에 따라 달라질 수 있음. 치료적 행위는 단지 가족의 구조적 변화를 촉발시키는 역할을 할 뿐임.

5) 구조적 결정론

• 개념
  - 유기체의 행동은 외부의 힘에 의해 결정된다기보다는 그 체계의 자체 구조에 의해 결정되어 있다는 것

• 가족치료에 적용해보면
  - 증상이란 외부에서 투입한 요인의 결과가 아니라 체계 내의 구조적 부조화와 불균형에서 비롯되며, 때로는 체계의 존속을 위해 불가피한 선택이었음을 인정
  - 따라서 치료자가 증상을 완화시키고 가족원을 변화시키는 과정에 참여하기는 하지만, 가족건강성의 회복은 결국 내담자의 몫

6) 부적 피드백

- 체계의 생존과 유지는 부적 피드백에 의함
- 정적 피드백은 체계의 정체성을 깨뜨림

• 가족치료에 적용해보면
  - 가족 안에서 가족의 기능이나 관계 향상을 변화시키기 위하여 여러 가지 활동이 전개될 수 있으나(정적 피드백), 이러한 활동은 가족이라는 체계를 유지시키기 위한 활동(부적 피드백)의 일부분
  - 만일 전체 가족 차원에서 피드백 과정이 변화를 지향하는 것이라고 한다면, 가족 체계는 깨짐

9주차 2교시	후기 구조주의 및 구성주의	
	수업목표	후기 구조주의 및 구성주의와 사회구성주의의 특징을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 후기 구조주의 2. 구성주의와 사회구성주의

1. 후기 구조주의

◆ 구조주의

- 구조주의자들은 행동을 개인의 깊은 내면에 있는 구성요소가 단순히 표현된 것으로 보고, 구성요소는 분류될 수 있고 필요에 따라 수정될 수 있다고 보았음
- 내면의 구성요소를 탐색하고 해석하는 것은 전문가에 의해서만 가능하다고 주장
- 내담자의 심리내적인 역동성을 형성하고 구성하고 있는 세계에 대하여 존재론적 접근자세를 취함
- 구조주의는 20세기 후반까지 사회과학의 많은 부분을 지배하였고, 많은 치료모델에 반영되었음

◆ 후기 구조주의

- 모든 현상에는 심층적인 구조가 있고, 또 구조는 구성요소로 분해할 수 있다는 환원주의 거부
- 서구 철학이 이분법적 구분과 절대적 진리의 추구 등에 지나치게 집착했었음을 비판

□ 프랑스 철학자 푸코는 담론, 특히 특정 집단이나 연구 분야, 특정 국가나 문화가 공유하고 제도화한 서술과 기록 방식에 관한 심층적인 연구를 통하여 특정 집단의 사람들이 만들어 낸 사회적 담론이 사람들의 관계를 감시하고 통제한다고 강조하였음

- 지배적 담론은 자신, 타인, 관계를 표준화된 이분법적 기준으로 판단하려는 경향이 있음
- 그 담론에 부합하지 않을 경우 문제시되며 주변화됨
- 후기 가족치료, 특히 이야기치료는 푸코의 영향을 많이 받음

◆ 구조주의와 후기 구조주의

구조주의	후기 구조주의
일반적인 계층이나 유형에 따라 사람들을 분류함	사람들의 정체성에 대한 상세한 기술 추구
전문가의 지식 존중	개인의 고유의 지식 존중
전문가는 삶의 구조 아래 있는 공식을 해독함으로써 삶의 이야기에 의미를 부여할 권한을 가짐	표현 현상은 사람이 실제로 알 수 있는 모든 것. 각자 자신의 표현 현상을 해석할 권한을 가짐
전문가는 삶의 구조 아래 있는 공식을 해독함으로써 삶의 이야기에 의미를 부여할	사람들은 행하고, 말하고, 기억하는 이야기를 통해 각자 의미 있는 삶을 구성할 권한을 가짐

권한을 가짐	

2. 구성주의와 사회구성주의

◆ 구성주의와 사회구성주의의 비교

구성주의	사회구성주의
실재(reality)는 발견되는 것이 아니라 개인이 구성하는 것	실재는 사회(가족, 친구, 또래, 민족, 국가 등)적으로 구성됨
궁극적 혹은 선호하는 실재는 매우 개인적인 문제	실재는 언어를 통해 구성되고, 이야기를 통해 조직되고 유지됨
사람이나 현상에 관한 진실을 객관적으로 관찰할 수 없고, 객관적 사실로 알 수도 없음. 다만 우리가 그것들을 구성한다는 것만 알 수 있을 뿐	실재/진리는 언어라는 사회적 상호작용을 통해 각자가 구성하는 것
진리는 내가 구성하는 것	자기(self)에 대한 경험은 타인과의 지속적인 상호작용에서 이루어짐

- 구성주의가 실재의 주관적 구성이나 창조와 관련되는 신경체계의 작동에 중점을 둔다면, 사회구성주의는 사회적 해석이나 언어, 가족, 문화의 내적·주관적 측면을 강조
- 사람들 각자가 가지는 자신만의 현실은 다른 모든 현실들과 동등한 가치를 지닌다고 하는 여성주의와도 유사한 측면이 있음

◆ 사회구성주의로의 이동

- 구성주의로부터 사회구성주의로의 이동은 개인이 자신의 경험에서 실재를 어떻게 구성하는가에서 사람들이 나름 사실이라고 받아들이고 의미를 부여하는 사회를 구성하고 수정하고 유지하기 위해 어떻게 상호작용하는가에 초점을 두는 것으로의 이동을 의미함

◆ 사회구성주의의 기본 전제

① 실재는 사회적으로 구성된다.
   - 사회적 신념, 법칙, 관습, 의식주 습관 등은 사람들이 살아가면서 사회적 상호작용을 통해 함께 구성하여 생긴 것

② 실재는 언어를 통해 구성된다.
   - 언어를 통해 구성되고 언어적 상호작용을 통해 언제나 변화할 수 있음

③ 실재는 이야기를 통해 조직되고 유지된다.
   - 일상적으로 말하는 이야기에서 생겨나고 소멸됨

④ 본질적인 진실이란 존재하지 않는다.
   - 우리가 할 수 있는 것은 경험을 해석하는 것뿐, 언제나 다양한 해석이 가능함

◆ 사회구성주의의 치료적 함의

- 모든 진리는 사회적 구성물이라는 시각은 치료자로 하여금 내담자의 신념을 키운 문화적 뿌리를 이해하는데 도움이 됨
- 치료자는 내담자가 자신의 문제를 새롭게 구성할 수 있도록 돕기 위해 언어적 상호작용을 사용함
- 치료자나 내담자 중 어느 한쪽이 진실을 알고 있는 것이 아니므로 치료는 협동적 과정으로 이루어짐
- 개입의 초점은 내담자가 생각하고 있는 문제의 현실. 특히 자신이 접하고 있는 매개물인 환경과 상호작용하는 실재로서 그 문제를 바라보는 자신의 지각, 이해 및 정의에 달려 있다고 가정함
- 문제의 존재여부보다 문제를 구성하는 개인의 내부구조에 의한 상호작용의 산출물이 어떤 언어 및 사고 속에서 존재하는 것이라고 봄
- 따라서 구성주의에서는 문제해결보다는 문제를 재구성하고 벗어버리도록
  ⇨ 이야기치료에서는 문제를 이야기함으로써 집착이 해소되는 현상을 치료에 활용함

9주차 3교시	언어의 역할과 페미니즘	
	수업목표	언어의 역할과 페미니즘과 가족치료의 관련성을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 언어의 역할 2. 페미니즘 3. 울트라모더니즘 시대의 가족치료

1. 언어의 역할

◆ **언어의 역할**

- 언어란 사람이나 세상을 정의하는 하나의 틀, 실재는 언어의 기능으로서 언어의 변화는 경험의 변화와 동일
- 사회는 언어를 통해 실재에 대한 시각을 구성함
- 사람들이 알 수 있는 유일한 세상은 우리가 언어를 통해 공유하고 있는 세상일 뿐
- 언어는 우리가 세상을 어떻게 보고 무엇을 보는지를 명확하게 함

□ 포스트모더니즘 시각에서 언어를 사용한 대표적인 가족치료 학자는 앤더슨과 굴리시안(Anderson & Goolichian) : 이들은 치료자가 내담자의 언어에 참여하여 새로운 의미가 도출되도록 치료하는 협동적 언어체계 모델을 발전시킴

□ 안데르센(Andersen) : '반영팀' 접근을 발전시켜 가족치료에 적극 활용

□ 화이트와 엡스턴 : 이야기치료를 발전시킴

- 치료에 있어서 치료자는 '알지 못하는 자세'를 취함.이 자세는 치료자가 미리 준비된 지식이나 이론을 가지고 치료에 임하는 것이 아니라 내담자와의 치료적 대화를 통하여 그들의 경험의 세계와 의미를 파악할 수 있다는 것 → 치료의 중심은 치료자가 아니라 내담자가 됨

2. 페미니즘

◆ **페미니즘**

- 페미니즘은 '개인적인 것은 정치적인 것이다.'라는 신념을 바탕으로 함
- 여성 개인의 경험은 사적인 것에 불과한 것이 아니라 성역할 고정관념, 제도화된 성차별, 여성 억압을 강요하는 정치와 제도에서 비롯되었다고 봄
- 따라서 여성 병리의 근원은 심리 내적 혹은 개인적인 것이 아니라 사회적이고 정치적인 것, 여성주의 상담의 핵심은 여성 개인의 문제에 대한 사회적 근원을 인식하고 여성의 역량을 강화하는 것

❖ 헤어-머스틴(Rachcel Hare-Mustin)의 가족치료에 대한 비판

① 가족의 역기능을 서술할 때 사회정치적 맥락을 고려하지 못한 것

② 문제와 관련된 사람들이 모두 문제발생에 똑같이 기여하였고, 따라서 문제해결에 대한 동등한 책임을 져야 한다고 가정하는 점

③ 어머니를 가족 병리의 근원으로 간주하는 점
④ 가부장제 사회에 존재하는 권력의 불균형을 다루지 못했다는 점
⑤ 순환적 인과관계의 개념을 사용하여 아내구타, 여성성폭력과 같은 문제를 남성뿐 아니라 여성에게도 동일한 책임이 있다고 가정하는 점

❖ 치료에 대한 제안

- 치료 시 젠더와 관련된 사안을 포함해야 하고, 치료자가 자신의 성 편견이나 성 고정관념을 밝혀야 하고, 여성의 강점을 강조하며, 여성의 역량을 강화할 수 있는 방법을 포함할 것을 강조
- 페미니스트의 주장은 치료 시 사회문화적 맥락과 담론을 더 많이 의식할 것을 강조하는 내러티브 관점이나 2차 가족치료 모델 곳곳에 반영됨

❖ 미래 여성 교육에 대한 제언(구티에레즈. Gutierrez, 1992)

- 어릴 때부터 의사표현과 자존감을 키울 수 있는 자기주장 훈련, 분노 표현, 감정 재정립, 폭력에 관한 정보 제공 등의 예방활동과 사후 피해행동이나 우울 등에 대한 대처 훈련 필요성 제안
- 여성의 임신, 가족계획, 유산, 임신 중 물질남용, 태아보호와 관련한 세미나 및 정책을 포함하여 다양한 부분에 대한 논의 필요성 강조

3. 울트라모더니즘 시대의 가족치료

◆ 울트라모더니즘 시대의 가족치료

- 발전이 반드시 과거의 이론을 버려야만 하는 것이 아니라, 지금까지 발달된 가족치료 이론을 통합하고 절충할 필요가 있다는 주장이 제기되어 왔음
- 리나레스(Linares, 2001)는 포스트모더니즘을 넘어 새로운 통합을 이루는 방법으로 '울트라모더니즘'이라는 용어를 사용
- 지금은 가족치료 이론이나 기법의 발달이 정점에 이르렀으므로, 울트라모던 시대의 가족치료는 그 동안 발전되어 온 가족치료 이론의 선택적 사용과 통합, 개인치료와 가족치료 등 치료 분파 간의 통합이 필요한 시대임을 주장

  ⇨ 통합과 선택, 이것과 저것 모두, 서로가 서로를 살림으로써 더불어 살아간다는 의미의 '상생의 가족치료'라는 용어를 붙이자는 의견 제시
- 가족치료 발달이 정점에 이른 지금 어떤 접근이 더 우수한지를 선별하지 않고, 맥락이나 선호에 따라 각 접근의 고유성을 인정함과 동시에 특정 접근의 선택이나 접근 간의 통합이 치료에 도움이 됨을 인식해야 할 것임

❖ 통합적 접근법

• 통합적 문제중심 치료모델
  - 상호구성주의, 체계이론, 상호 인과관계를 기본으로 함
  - 개인치료와 가족치료를 유기적으로 통합하자는 입장
  - 가족체계에서 문제를 유지하는 역동성을 사이버네틱스, 사회학습이론, 정신역동이론의 세 가지 관점에서 통합적으로 해석

- 구조적 모델과 전략적 모델, 문제중심 모델, 인지행동 모델을 초기 문제 확인 및 문제평가와 진단과정에서 주로 활용함

• 초월구조주의 모델
  - 내담자의 문제 파악을 위해 심리내적 과정, 가족구조, 가족 상호작용의 인과적 연결고리, 가족발달, 성, 문화에 초점을 둠

10주차 1교시	해결중심 단기치료의 발달배경과 주요개념	
	수업목표	해결중심 단기치료의 발달배경과 주요개념을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 해결중심 단기치료의 발달배경 2. 해결중심 단기치료의 주요개념

1. 해결중심 단기치료의 발달배경

◆ **발달배경**

- 해결중심 단기가족치료 모델은 과거보다 현재와 미래를 중시하고, 병리적인 것보다 건강하고 긍정적인 면에 초점을 둠
- 이 모델은 인간의 장점과 유용한 자원을 발견하여 작은 변화라도 가져올 수 있는 간단한 전략을 사용하며, 문제가 무엇인가를 파악하기보다는 가족이 원하는 해결방안에 관심을 두고, 태도 및 의식구조의 재구성과 행위의 변화를 촉진시킨다는 점에서 인간존중적인 혁신 모델로 평가 받기도 함
- 해결중심 단기치료는 이름처럼 상담이 단기로 진행되며 문제의 원인을 파악하기보다 해결책에 초점을 둠
- MRI(정신건강연구소)의 단기가족치료센터를 중심으로 하는 전략적 치료모델에 근원을 둠
- 이곳에서 활동하던 드쉐이저와 인수버그는 전통적으로 진행하는 치료 기간이 상대적으로 긴 정신역동치료과 달리 10회 정도의 짧은 기간 동안 내담자의 문제 해결을 위해 고안한 접근

• 치료의 초점

  - 문제중심에서 해결중심으로 전환. 치료의 목표는 내담자가 인생에서 변화하기 원하는 것이며, 자원이란 목표를 충족시키기 위해 사용될 수 있는 것
  - 해결중심 가족치료는 경제성 면에서도 인정받음. 사회구성주의의 영향을 많이 받음

□ 대표적인 인물 : 드세이저, 인수버그, 립칙, 오한런 등

2. 해결중심 단기치료의 주요개념

◆ **기본 가정과 전제**

① 긍정적인 측면에 초점을 둠
② 예외 상황은 해결의 실마리가 됨
  - 문제가 없었던 예외 상황을 발견하고 이 예외상황이 더 많이 발생하도록 격려
③ 변하지 않고 그대로 머무는 것은 아무것도 없음
④ 작은 변화는 일어나기 쉬우며 생성적임(작은 변화는 큰 변화를 이끎)
⑤ 협동 작업이 있고, 내담자는 항상 협조적임
⑥ 내담자는 자신의 문제를 해결하기 위하여 필요한 자원을 가지고 있음

⑦ 의미와 체험은 상호작용 속에서 일어남
⑧ 행동과 묘사는 순환적임. 문제에 대해 긍정적/부정적으로 볼 것인가에 따라 해결방법도 달라짐
⑨ 의미는 반응 속에 있음
- 메시지가 전하는 의미는 관찰자에 의해 만들어지고 내담자의 자세 자체가 절대적 의미를 갖고 있는 것은 아님
⑩ 내담자가 전문가. 내담자가 자기 문제에 대해 가장 많이 알고 있으며, 많은 해결책을 시도했을 것으로 봄
⑪ 내담자가 어떻게 목표를 설정하고 무엇을 하는가에 따라서 내담자의 작은 변화는 다른 사람과의 상호작용에 영향을 미침
⑫ 치료팀은 치료의 목표 설정과 목표 설정과 목표 달성을 위해 노력할 의사를 가진 사람으로 구성

◆ 치료의 원리
① 병리적인 것 대신 건강한 것에 초점을 둠
② 내담자의 강점과 자원은 물론 증상까지도 발견하여 치료에 활용함
③ 탈이론적이고 비규범적이며, 내담자의 견해를 존중함
- 인간 행동에 대한 이론적 틀에 맞추어 내담자를 진단하거나 사정하지 않음
④ 간단하고 단순한 방법을 먼저 사용함
- 치료목적 달성을 위해 치료방법의 경제성 추구함
⑤ 변화는 불가피함
- 문제가 발생하지 않는 예외적인 상황을 파악하고 예외를 증가시킴으로써 변화를 긍정적인 방향으로 이끎
⑥ 현재에 초점을 맞추며 미래 지향적
⑦ 내담자와의 협력관계를 중요시함

◆ 철학 및 관점
❖ 해결중심 가족치료에 적용되는 세 가지 철학
① 어떤 것이 잘 기능하면 그것을 고치지 않음
② 일단 효과가 있는 것을 알면 그것을 지속함
③ 효과가 없다면 다른 방법을 사용함
❖ 문제와 문제 해결, 저항을 보는 관점
① 문제란 어려움을 해결하기 위한 시도에서 실패한 것이므로 다른 방법을 실천에 옮기는 것이 중요함. 과거의 성공이나 예외상황을 발견하여 확대하는 일이 더 용이함
② 문제해결을 위해 문제내용을 많이 알아야 할 필요는 없음. 문제가 발생한 원인과 문제내용 진행을 자세히 알기보다는 문제해결방안과 새로운 행동유형을 만들어내는 일에 관심을 가짐
③ 해결중심 모델에서는 내담자가 진심으로 변화를 원하는 것으로 가정하므로 가족이 변화과

정에 저항을 보이는 일은 없다고 믿음

- 해결중심 가족치료자는 문제해결을 간단하고 단순한 것에서부터 출발함. 성취 가능한 작은 목표를 세워 가족이 성취감을 경험하도록 함. 무언가 해냈다는 성취감은 해결을 위한 출발점이 되고, 가족들이 낙관적인 감정을 느끼게 하며, 미래의 변화에 더욱 자신감을 갖게 할 수 있기 때문에 중요한 경험이 됨
- 만약 가족이 저항을 보인다면, 치료자의 개입방법이 자신들에게 적합하지 않다고 느끼기 때문
- 해결중심 가족치료는 다른 어떤 치료보다 개입 시기나 방법 등에 대해 보다 철저한 훈련과 경험이 요구됨

10주차 2교시	해결중심 단기치료의 치료목표와 치료과정	
	수업목표	해결중심 단기치료의 치료목표와 치료과정을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 해결중심 단기치료의 치료목표 2. 해결중심 단기치료의 치료과정

1. 해결중심 단기치료의 치료목표

◆ 발달배경

- 도움을 필요로 하는 가족이 만족스러운 생활을 영위하기 위해 기존에 해 오던 생활방식과는 다른 방안을 모색하거나 행동하게 하여, 가족이 가지고 있는 현재의 문제를 해결하고자 하는 것
- 목표설정을 위해 내담자 가족은 자신들이 직면한 문제를 정리하고 구체화함

◆ 바람직한 치료목표 설정을 위해 고려할 점

① 가족에게 중요한 것을 목표로 삼기
  - 치료자는 내담자 가족이 목표를 정확하게 표현하지 못할 때, 언어화할 수 있도록 도움
  - 가족원 간 목표가 다르고 합의가 안 될 때 각자 견해를 자유롭게 표현하여 서로를 알 수 있도록 하고, 가족원 간 동의할 수 있는 영역을 찾아낼 수 있도록 도움

② 목표는 작고 간단한 행동이어야 함
  - 목표가 작아야 성취하기 쉽고, 이 성취감은 가족에게 변화에 대한 희망과 자신감을 갖게 함

③ 구체적이고 명확하고 측정할 수 있는 행동용어로 기술함
  - 진행 정도를 관찰할 수 있고 목표 달성 여부를 확인할 수 있음

④ 목표는 긍정적인 것으로 설정
  - 문제의 제거나 소멸이 아닌 성공의 긍정적 지표로 기술됨. 즉, 문제가 되는 어떤 것을 하지 않거나 없애는 것보다 새로운 긍정적인 행동을 시작하도록 돕는 것이어야 함

⑤ 목표는 처음의 시작이나 신호(최종 결과가 아님)임을 기억

⑥ 목표는 성취 가능한 것이어야 함
  - 구체적으로 실행할 수 있는 목표를 설정하도록 조정해야 함

⑦ 목표 달성은 힘들고 어려운 일이라고 인식함
  - 힘든 일을 시작하는 것으로 지각되어야 가족이 목표성취에 책임감을 갖고 협동하게 됨

◆ 치료자와 내담가족원의 관계유형

- 다른 치료모델에 비해 치료자와 내담가족의 협동적 관계를 강조함
- 해결중심 모델에서는 내담가족원의 상담동기와 원하는 것, 상담사와의 상호작용 특성 등을 기준으로 가족원과 상담사의 관계를 ① 방문형, ② 불평형, ③ 고객형으로 나누고 이 관계

유형에 따라 상담을 진행하는 과정과 과제가 달라야 함
- 첫 회기에 내담자 가족 간 상호작용의 특성을 고려하여 가족과 치료자 관계 유형을 구분하고, 그에 따라 개입 방법이 달라짐

1) 방문형

❖ 고민과 갈등은 있지만, 치료를 받아야 한다는 필요성이나 문제해결의 동기는 약한, 비자발적인 유형

- 일반적으로 부모나 배우자, 교사, 법원 등에 의해서 자신의 의사와 상관없이 상담실에 온 사람
- 자신의 문제를 인정하지 않고 상담의 필요성도 인식하지 않으며 다른 사람에게 문제가 있다고 생각함
- 문제 해결 동기가 약하고 상담목표에 합의하기 어려움
- 타인의 요구와 결정을 따르는 것이 얼마나 힘들었는지를 치료자자 이해해 줄 때, 이해받고 있다고 느낄 수 있음
- 타의에 의해서 왔지만, 치료실에 온 것 자체를 칭찬하고 인정해 주어야 함

2) 불평형

❖ 치료 중 불평을 찾아내고 관찰을 잘하여 구체적인 문제상황을 말함

- 다른 사람 때문에 자신이 희생되었다고 생각하고 자신의 힘든 점에 대해 치료자에게 이해받고자 함
- 문제로 인해 고통을 받고 있지만, 해결책을 찾는 단계에서는 수동적이고 불분명한 반응을 보이며 불평과 문제중심의 대화가 특징적임
- 문제 해결의 방해자로 보기보다 해결을 위해 활용할 자원으로 간주하고 가족의 불평이나 목표에 대해 의논함
- 내담자 자신이 해결의 주인임을 자각하는 신호가 보이기 전에는 치료자가 해결책을 먼저 제시하지 않도록 함

3) 고객형

❖ 문제해결과 변화를 위한 자발적인 동기를 가지며, 자신이 문제해결 구축의 한 역할을 담당하고 노력해야 한다고 생각하고 문제해결을 위한 의지를 보임

- 상담동기가 높기 때문에 쉽게 협력적 관계로 발전함
- 세 가지 유형 중 하나가 분명하게 포함되지 않을 수 있음. 치료자는 내담가족과의 관계유형 판단이 확실하지 않을 경우 신중하게 접근하는 것이 좋고 관찰팀과의 상의가 도움이 됨(전략적 가족치료와 유사함)
- 실제로 고객형 가족의 비율은 그다지 높지 않음

2. 해결중심 단기치료의 치료과정

◆ 해결중심 단기가족치료의 치료과정 개요

- 치료과정은 세 가지로 구성되며, 60분 정도 소요됨

  ⇨ ① 45분 내외 동안 상담이 진행되고 일면경 뒤나 모니터실에 있는 관찰팀은 상담과정을

관찰하면서 필요시 인터폰이나 전화로 개입

② 치료자가 일면경 뒤나 모니터실에 있는 관찰팀에게 가서 10분 정도 함께 상담과정을 검토하고 상담사와 내담가족의 관계유형과 전달할 메시지에 대해 의논함

③ 치료자가 상담실로 돌아와서 5분 정도 내담가족에게 메시지 전달

- 치료자와 관찰팀이 전체 상담과정에 함께 참여하여 문제상황과 상담 목표, 자원 및 해결책 구축에 대한 객관적이고 다양한 관점을 얻을 수 있고 현실적이고 효과적인 접근이 가능해지는 이점이 있음

◆ 첫 회기 상담

- 관찰팀의 존재와 상담진행방법에 대해 알리고, 일면경 사용과 녹화에 대한 동의 받음
- 여러 질문기법을 사용하여 가족상황과 대처자원, 예외적 행동, 해결노력 정도와 성공경험, 상담동기 수준 등을 탐색하고 내담가족과 협력적으로 상담 목표를 수립함

◆ 첫 회기 이후의 상담

- 2회기 상담부터는 긍정적인 변화를 확인하고 이를 유지·확장시키는 데 초점을 둠
- 구체적으로 개선된 것들과 긍정적인 변화를 확인하기 위한 질문과 지지와 격려, 과제주기 등의 전략 사용

① 지난번 치료 이후 변화한 것 질문

- “지난번 상담 이후 아주 작은 것이라도 나아진 것은 무엇인가요?”

② 긍정적인 변화에 대해 자세하고 구체적으로 질문

- “언제, 누가, 어디에서, 무엇을, 어떻게”를 사용하여 충분히 긍정적인 변화가 묘사되도록 질문

③ 긍정적인 변화에 대해 언어적으로, 비언어적으로 인정해 주고 가치 확인과 칭찬

④ 자신감, 동기, 진행과정, 변화, 개선의 정도에 대해 질문하고 계속 실현 가능한지 질문. 종료 무렵에는 변화의 유지 가능성과 종료 가능성 질문

⑤ 가족이 변화하고 개선되다가 후퇴하고 악화되는 경우, 치료자가 고려해야 할 사항

- 나빠진 상황과 대처방법에 관하여 자세히 질문하고 작은 성공경험과 해결책 발견
- 치료간격을 늘려 극복시간을 주거나 면접요일이나 시간 변경
- 가족과의 관계유형과 치료목표 검토, 고객형 관계로 발전시킴
- 개선된 점, 달라진 점, 예외사항, 노력방법, 배운 점 등 확인

⑥ 긍정적 변화와 개선의 유무, 변화가 목표와 관련되는지에 따라 개입방법이 달라짐

- 세 가지 기본 철학(어떤 것이 잘 기능하면 그것을 고치지 않는다, 효과가 있다면 그것을 좀 더 한다, 효과가 없다면 그 방법이 아닌 다른 방법을 사용한다)에 바탕을 둠

10주차 3교시	해결중심 단기치료의 치료자 역할과 기법	
	수업목표	해결중심 단기치료 치료자의 역할과 기법을 이해하고 치료사례를 통해 치료에 대한 이해를 높인다.
	세부내용	1. 해결중심 단기치료의 치료자 역할과 기법 2. 해결중심 단기치료의 치료사례

1. 해결중심 단기치료의 치료자 역할과 기법

◆ 치료자 역할

- 내담가족이 가진 힘과 자원을 개발하여 문제 해결에 활용하도록 돕는 역할
- 내담가족의 지각과 의견을 존중하면서 함께 목표를 세우고, 해결책을 구상하고 실행함
- 내담가족이 자신감과 희망을 갖고 자신의 강점과 성공경험에 주목하여 사고의 전환과 행동 변화가 나타나게 도움

◆ 치료자의 태도

1) 해결중심적 대화

- 내담가족이 문제중심 시각에서 해결중심 시각으로 바뀌어 상황을 긍정적으로 보게 하고, 진심으로 원하는 것들과 문제가 없는 예외상황을 발견하도록 안내함

2) 알지 못함의 자세

- 내담가족의 능력에 대하여 긍정적
- 내담자에 대하여 알지 못하는 자세를 취함 즉, 내담자에 대해 선입견과 자신의 전략을 갖기보다는 내담가족의 행동과 말, 문제의 특성, 문제 해결 능력과 성공/실패 경험, 원하는 것, 잠재력, 해결책 등에 대해서 존중하고 탐색하는 자세를 가져야 함

• ‘알지 못함의 자세’를 위한 의사소통 기술

- 모든 상담과정에서 기본이 되는 경청, 공감, 요약, 개방형 질문의 사용 이외의 기술 소개

① 치료자의 비언어적 행동 : 내담자에 대한 관심을 다양한 비언어적 행동으로 표현
② 내담자가 사용하는 핵심용어의 반복 : 내담자에 대한 존중의 표현
③ 침묵의 활용 : 침묵의 의미를 이해하고 존중해야 함
④ 내담자의 비언어적 행동 주목 : 비언어적인 행동, 표정, 태도 등에도 집중
⑤ 치료자의 자기개방 : 치료자 개인적인 관찰, 경험, 견해, 생각을 내담자와 나눔
⑥ ‘과정’에 대한 주목 : 치료과정에서 나타나는 내담자의 다양한 반응을 적절할 때 내담자에게 이야기함
⑦ 칭찬 : 내담자의 강점과 과거의 성공을 중심으로 내담자를 지지하는 것
⑧ 내담자의 지각에 대한 확인 : 내담자의 문제성격, 문제해결을 위해 시도한 노력 등을 포함한 내담자의 지각을 질문을 통해 확인함
⑨ 내담자의 초점 돌리기 : 내담자의 무기력을 힘으로 전환하기 위해 내담자의 상황이나 다른 사람에 대한 불평을 이 상황에서 달라지기 원하는 것, 해결을 위해 어떻게

할 것인지에 대한 답으로 바꿈

⑩ '해결중심적 대화'의 확대 : 내담자가 자신의 생활에서 달라지기 원하는 것과 그러한 일이 일어나게 할 가능성에 대해 이야기를 나누는 것은 해결을 위해 협력적인 관계 형성을 하는 데에 도움이 됨

◆ 치료기법

❖ 변화와 해결로 이끄는 질문

1) 상담 전 변화에 관한 질문

- 가족에게서 계속해서 변화가 일어난다는 것을 전제하고 "가족이 상담을 예약한 후 현재 이곳에 오기까지 달라진 것이 무엇인가요?"라고 질문
- 상담 전에 도움이 되는 방향으로 긍정적인 변화가 시작되는 경우 치료자는 그들의 자발적인 해결노력과 능력을 인정하고 강화하여 가족이 미처 지각하지 못한 자원과 해결방안을 찾아내는 데 활용하도록 격려함
- 만일 내담가족이 변화가 없다고 응답하는 경우 상담목표를 찾기 위해 "오늘 여기 와서 무엇이 변화하기를 바라십니까?"라고 질문

2) 기적질문

- 이 질문을 통해 내담가족은 문제와 떨어져서 상상하므로 문제중심에서 벗어나 변화 가능성에 대한 희망을 갖게 되는 경험을 하게 되며 상담 목표를 설정하는 데 도움이 됨
  예) "오늘 밤 당신이 잠자는 동안에 기적이 일어나 모든 문제가 해결되었다고 상상해보세요. 내일 아침에 눈을 떴을 때 무엇을 보면 어젯밤에 기적이 일어나 모든 문제가 해결되었다는 점을 알 수 있을까요?" 라고 질문

3) 예외발견 질문

- 어떤 문제에도 예외는 있다는 것을 믿고 예외발견 질문을 통해 문제가 일어나지 않는 상황을 찾아냄
  예) "최근에 문제가 일어나지 않은 때는 언제였나요?" "어떻게 하면 문제가 발생하지 않나요?"

4) 척도질문

- 문제의 심각성, 문제 해결의 우선순위, 문제 해결 정도, 정서적 관계, 관계개선을 위한 노력 정도, 문제 해결 동기, 변화 의지, 자신감과 자존감 등 구체화시킬 필요가 있는 것을 숫자로 표현하여 평가하는 질문
  예) "1점에서 10점까지의 척도에서 1은 가장 문제가 심각한 때이고, 10은 문제가 모두 해결된 점수라면 지금 몇 점입니까?" "4점에서 5점으로 되면 무엇이 달라질까요?"

5) 대처질문

- 예외적인 상황을 발견하기 어렵거나 만성적인 어려움과 절망적 상황 등으로 희망이 없다고 호소하는 내담가족에게 주로 사용하는 기법
- 희망이 없는 상황에서 어려움을 어떻게 관리하고 견디었는가에 초점을 맞춰 내담가족이 자신의 노력과 의지, 자원을 발견하고 또 성공경험과 강점을 발견하게 함
  예) "매우 어려운 상황인데 지금까지 어떻게 견딜 수 있었지요?"

6) 관계성 질문
- 내담가족과 관련된 다른 중요한 사람들의 생각이나 행동에 대하여 묻는 질문
- 이 질문을 통해 자신의 행동이나 관점뿐 아니라 자신에 대한 다른 사람의 관점이나 행동에 대해 주의를 기울이게 됨
  예) “부인께서 보시기에 남편은 자신에게 가장 도움이 되는 것은 무엇이라고 말할 것 같습니까?”, “지금 이 자리에 남편이 있다면, 남편은 결혼생활을 지속하고 싶은 정도를 몇 점이라고 할까요?”

❖ 메시지 주기
- 상담회기마다 종료 전에 내담가족에게 메시지를 주는 것을 필수적인 과정으로 진행
- 메시지 주기는 칭찬, 연결문, 과제로 구성

• 칭찬
  - 상담과정에서 드러난 성공과 강점을 인정하고 작은 것이라도 긍정적인 부분들을 표현하는 것
  - 칭찬을 통해 내담가족의 자존감을 높이고 상담사의 메시지를 협력적으로 수용하게 함
• 연결문
  - 칭찬 다음에 주는 과제와 연결해서 문제를 일반화시키거나 내담가족에게 필요한 것들을 교육하여 과제를 주는 이론적 근거 제공
  - 내담가족은 과제를 명확하게 이해할 수 있고 실천 가능성도 높아짐
• 과제
  - 내담자 관계유형에 따라 다르게 부여
    · 방문형 : 상담에 온 것을 칭찬하고 다음에 도움이 필요할 때 오도록 격려
    · 불평형 : 자신이 변화해야 한다는 생각보다 다른 가족의 변화를 원하는 부분이 많으므로 타인의 긍정적인 부분을 관찰하는 과제나 문제 해결에 대해 생각하는 과제 제시
    · 고객형 : 변화를 위해 행동하는 과제 제시
  - 과제는 자신의 가족을 관찰하는 데 도움이 되는 것을 주어야 함

2. 해결중심 단기치료의 치료사례

◆ 치료사례

· 의뢰 사유 : 도벽, 성적부진, 학교 부적응, 무단결석, 빈약한 또래관계, 표현력 부족, 우울상태와 복통과 두통 등 신체증상이 있는 딸(중1)에 대한 걱정으로 어머니의 권유로 상담실을 방문하게 됨
· 가족 배경 : 오빠(16세), 남동생(12세)은 문제없으며, 부모 사이도 원만함

◆ 치료사례 - 치료과정

1) 1회기
- 상담진행방법, 관찰팀 존재와 역할 소개, 상담사 소개, 상담 목표 설정
- 목표에 대한 질문. 모는 딸의 도벽이 없어지는 것, 친구와 잘 어울리는 것. IP도 동의함
- IP의 잠재력을 발견하고 인정하기 위해 좋아하는 과목 질문(국어, 동화책). 최근 속상했던

일(친구 세 명이 IP에게 자신감이 없는 너와 친구 안 하겠다고 하였고 그 때 IP는 충격으로 학교에 가지 않았다고 함
- 척도 질문으로 IP의 친구관계에 대해 모는 3점, 목표는 5점. IP의 노력은 8점, 성공 가능성은 6점이라고 함
- IP가 잘하는 것 : 학원에 6개월 동안 개근한 것, 글을 잘 쓰는 것, 동생 또래를 잘 돌보는 것

• 메시지 전달하기
  - 칭찬 : IP가 친구관계를 소중히 여기는 점, 모와 IP가 노력하는 점, IP가 사려 깊고 강한 의지, 책임감, 성실함으로 개근상도 타고 애들을 잘 보살피는 점
  - 연결문 : 문제 해결 의지가 강하고 노력해왔기 때문에 새로운 방법으로 노력할 것이므로 희망적이라고 함
  - 과제 : IP는 의지와 책임감이 강하며, 글도 잘 쓰므로 다른 아이들에게 알려주고 보여줄 수 있는 방법을 생각하고 오도록 함.어머니는 IP가 잠재력을 표현하도록 도와주는 방법을 생각하고, 표현할 때 관찰하기

2) 2회기
- 작은 변화 : IP가 돈을 아껴 썼고 어머니 지갑에 손대지 않았으며, 어머니는 마음이 편해짐
- 척도 질문 : IP는 자신이 1회기에 1점, 현재 4점, 목표는 8점. 모는 1회기 본인의 상태 2점, 현재 상태와 목표 5점. IP의 긍정적 행동이 많아져 3점 좋아졌다고 함
- IP가 돈을 아껴서 쓰고 돈이 아깝다는 생각을 한 것을 칭찬하고 모가 칭찬하도록 유도함

• 치료자는 관찰팀과 의논한 후 메시지 전달
  - 칭찬 : IP가 돈을 모에게 맡기고, 자진해서 친구들에게 접근하고 이야기를 듣는 행동을 한 것, 도움이 되는 방향으로 변화하려는 동기와 용기를 가짐. 앞으로 IP가 할 일은 주위 사람이 알아차리도록 노력하고 변하는 방법을 생각하고 앞으로 더 용기를 갖고 노력하면 8점까지 성취할 수 있는 희망이 있음
- 치료자는 2회기에서 변화는 계속된다는 확신을 갖고 구체적으로, 반복적으로 유사한 질문을 하여 작은 변화를 발견하도록 도와, 모가 계속해서 변화를 발견하게 됨
- 척도 질문을 하여 모와 IP의 행동방향을 설정하고 의지와 동기를 강화하며 IP의 돈관리 문제와 친구관계 개선에서 성공경험을 확인할 수 있었고 이를 근거로 IP의 변화가 계속되리라는 희망과 자신감을 보여주었기 때문에 모가 종결을 제안하고 치료자도 동의하여 종결함

11주차 1교시	이야기치료의 발달배경과 주요개념	
	수업목표	이야기치료의 발달배경과 주요개념을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 이야기치료의 발달배경 2. 이야기치료의 주요개념

1. 이야기치료의 발달배경

◆ **발달배경**

- 이야기치료는 가족치료가 지니고 있던 미시적 관점을 벗어나 더 큰 시각으로 개인과 가족 문제를 바라보게 함
- 인간 삶에 대한 우리의 이해는 역사와 사회의 맥락 속에 한정되어 있다는 시각을 취하고 있으며, 개인의 행동은 내적 역동에 의한 것이라기보다는 오히려 역사적·문화적 산물로 이해하는 것이 더 적절하다고 봄
- 이야기치료는 삶을 이야기로 보는 관점을 취하고 있음
- 사람들은 이야기의 창조를 통하여 삶의 의미를 구축하고 새로운 미래를 구성할 수 있다고 보며, 자신에게 일어나는 삶의 사건을 해석하고 그에 대해 의미를 부여하는 데 있어 능동적인 자세를 취함
- 인간 정체성은 주변 사람, 사회제도, 나아가 더 큰 권력과의 관계 속에서 만들어지는 것이므로, 그 정체성이 개인에게 부정적인 영향을 미치는 경우, 치료과정 속에서의 '해체'를 통해 그 억압적 영향을 약화시키는 것이 핵심이라고 보고 있음
- 이야기치료는 삶을 이야기로 봄
- 사람들은 자신의 삶에 대하여 이야기를 창조할 수 있다는 가정에서 출발. 사람들은 이러한 이야기의 창조를 통하여 삶의 의미를 구축하고 새로운 미래를 구성할 수 있다고 보았음

• 이야기치료 = narrative therapy
  - 일반적으로 이야기(story)는 기-승-전-결의 구조를 가지지만, 내러티브(narrative)는 한 가지 이상의 이야기와 주제가 복잡하게 얽혀있는 형태를 가리킴
  - 이야기치료에서는 이러한 '이야기(story)'로서의 의미보다는 한 개인이나 가족의 삶에서 전개되는 다양한 이야기가 얽혀있는 상황을 표현하는 의미에서 '내러티브(narrative)'라는 단어를 선택한 것으로 보임
  - 이야기치료에서 이야기에 대한 견해 : 단순히 생각이나 감정을 표현하고 의사소통하는 수단을 넘어서 개인의 경험의 의미를 결정하여 삶을 만들어 감. 즉, 자신에 대해 말하고 설명하는 것들이 자신의 경험을 구성하고 행동을 결정한다고 믿음
  - 이야기치료 치료자는 내담자의 과거 경험으로부터 만들어진 부정적인 이야기와 제한적 해석을 극복하고 새롭고 긍정적인 이야기를 구성하도록 도와 내담가족이 새로운 삶을 만들어가게 함

◆ **이야기치료의 가족치료에 적용**

- 행동 방식보다 의미를 구성하고 해석하는 방식에 관심
- 치료자가 가족의 행동을 변화시키기 전에 그들의 삶을 구성하는 이야기와 그 영향을 탐색하고, 지배적인 이야기와 문화적 신념에서 벗어나 주체적인 삶을 재구성하도록 도움
- 이야기치료에서는 병리를 찾기보다 내담자의 삶을 지배하는 이야기와 문화적 신념의 악영향에 주목함
- 이로 인해 개인, 가족을 대상으로 상담하는 것 외에 사회적 불평등의 해소와 폭력피해자, 정신장애자의 재활을 가로막는 사회적 편견과 문화적 관습(인습)을 개선하는 일에도 관심을 가짐

2. 이야기치료의 주요개념

◆ **기본 전제**

1) 인간은 자기 경험을 해석한다.
- 인간은 자신의 경험을 해석할 수 있는 존재
- 자신의 경험을 특정한 방식으로 해석하고 그에 대해 의미를 부여하는 과정에 적극 참여함

2) 경험은 사회적으로 구성된다.
- 자신의 경험에 부여하는 의미는 특정한 사회적, 문화적, 역사적 맥락의 영향을 받음
- 따라서 같은 사건을 경험하여도 그들이 처한 사회문화적 맥락에 따라 의미부착이 달라질 수 있음
- 개인에게 일어나는 사건은 동일해 보여도 처한 사회문화적 위치(성, 인종, 계층 등)에 따라 의미가 달리 해석되며, 그런 의미에서 각자의 경험은 독특한 동시에 사회적임

3) 정체성은 사회적으로 구성되고 재구성된다.
- 삶을 이해하고 의미를 부여하여 삶의 이야기를 만들어가는 방식은 그 사람이 속한 역사적, 사회문화적 맥락의 많은 이야기에 의해 영향을 받음

4) 사람과 문제는 별개다.
- 문제를 가진 사람을 문제와 동일시하기도 하지만, 이야기치료에서는 '문제가 문제이다'라는 입장
- 문제는 사회문화적으로 구축되어 개인에게 부착된 것이므로, 외재화 작업을 통해 이를 인간으로부터 분리하고 그 관계를 조명하여 수정하도록 지원함

5) 이야기는 삶이고 삶은 곧 이야기다.
- 개인의 삶의 이야기는 그 사람이 이제까지 살아온 삶을 보여 주는 동시에 앞으로 살아갈 삶의 이정표가 됨
- 빈약한 과거 이야기는 다시 빈약한 미래 이야기로 이어질 가능성이 크기 때문에 이야기치료에서는 개인의 삶의 이야기를 다시 쓰는 작업을 통해 내담자의 미래 선택과 행보에 대안을 제공하고자 함

6) 삶은 복합적인 이야기다.
- 자기 인생이 우울하고 희망 없다고 말할 때, 그것은 그 사람 인생의 전체 이야기 가운데

일부

- 이야기치료에서는 내담자의 삶의 이야기가 복합적이라는 전제하에 간과되었던 이야기를 풀어보고, 문제로 가득 찬 이야기 외에 다양하고 복합적인 이야기가 풍부하게 발달하도록 함

7) 인간은 능동적인 행위자다.

- 인간은 자신의 지향이나 목적의식에 따라 행동하며, 이 과정에서 정체성이 구성됨
- 이야기치료에서 치료자는 내담자의 이야기를 듣고 내담자가 지향하는 것을 확인하고 그 지향이 반영된 정체성을 구성하는 계기를 만듦

❖ 이야기치료의 기본 원리

- 사람이 문제가 아니라 문제가 문제
- 문제가 가족에 미치는 영향과 그 영향을 지지하는 사회·문화적 담론과 맥락에 관심을 둠
- 문제의 발생과 해결 역시 이야기 안에 존재한다고 믿음

① 문제는 사람이 아니고 그 사람이 만들어내는 이야기가 문제이다.

- 문제가 가족의 특징을 진단하고 원인을 찾거나 설명하기보다, 내담자와 문제를 이야기 안에서 다루고, 내담자에게 문제를 바라보는 관찰자로서 대화를 시작함

② 인간의 이야기는 사회적으로 구성된 유연한 실체이고 주관적 특성이 있으며, 이야기를 바꿈으로써 현실이 변화될 수 있다.

- 치료자는 내담가족의 문제 이야기에 잠재된 경험과 소망, 인생관과 가치 등에 적합한 대안적인 이야기로 대체하도록 도와줌

③ 문제와 지배적인 문화적 담론에서 자신을 분리하면 대안적 능력을 갖춘 이야기를 개발할 수 있다.

- 문제 증상을 나타내는 경우 부정적인 정체성과 지배적 이야기에 묻힌 다른 경험을 이야기로 구성하면 기술과 능력, 지식을 활용하여 삶을 회복할 수 있게 됨
- 따라서 구제불능의 문제란 있을 수 없고 사람들의 새로운 희망적인 이야기의 개발은 누구나 가능함

11주차 2교시	이야기치료의 치료목표와 치료과정	
	수업목표	이야기치료의 치료목표와 치료과정에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 이야기치료의 치료목표 2. 이야기치료의 치료과정

1. 이야기치료의 치료목표

◆ **치료목표**

- 단기목표
  - 내담가족이 호소하는 문제증상을 완화하거나 감소시키는 것
- 궁극적 목표
  - 내담가족 스스로 자신들이 선호하는 방향으로 자신들의 이야기를 써 나갈 수 있게 하는 것

- 포스트모더니즘의 영향을 받은 이야기치료는 여러 가족구성원이 모인 가족에서의 치료목표가 단일할 수 없다고 보고 가족구성원 간 목표에 차이가 나는 것을 수용함
- 가족을 이루는 각 구성원마다 가족의 문제에 대한 시각이 다를 수 있고, 문제해결에 대한 관점도 다를 수 있음을 인정함
  ⇨ 따라서 치료자는 목표를 하나로 제한하지 않음
- 그러나 치료적 대화가 진행됨에 따라 공통된 삶의 지향이나 가치를 중심으로 가족구성원이 연결되고 가족원과 문제와의 관계를 수정하는 단계가 되면, 치료자는 여러 개의 목표를 상호 연관된 것으로 재정의하는 대화를 진행할 수 있게 됨

2. 이야기치료의 치료과정

◆ **치료과정**

1) 1단계 : 문제의 경청과 해체

- 내담가족의 문제중심 이야기를 경청하고 공감. 문제를 사람과 분리하고 문제의 내력과 사회문화적 맥락 탐색
  · 문제의 영향 평가 및 영향 탐색, 문제의 외재화
  · 치료의 시작은 전통적 가족치료와 달리 다양한 방식으로 이루어짐
  · 즉, 문제를 사람으로부터 분리하고, 사회문화적 맥락 속에서 문제가 어떻게 형성되었는지를 탐색하는 데서 출발. 이 과정에서 내담자가 문제를 해결하기 위해 사용했던 (예) 강압이나 폭력과 같은) 방법이 오랜 사회문화적 관습의 영향이었음을 보게 하여 가족의 문제해결 방식과 사회문화적 관행 사이의 관계를 깨닫도록 도움

2) 2단계 : 부수적 이야기 구축

- 문제 이야기 속에 있는 내담가족의 예외적인 독특한 결과인 문제해결 기술과 지식, 유능성

탐색

· 독특한 결과의 영향 평가 및 영향 탐색, 독특한 결과의 외재화
· 관행에서 벗어나고자 하는 내담가족의 의지 또는 책임의식의 실마리 확인, 간과되었거나 무시된 내담가족의 문제해결 지식과 기술을 재조명하게 됨
· 새롭게 조명된 지식과 기술, 그것을 사용했던 일화나 사건 등을 모으고 탐색하는 과정을 통해 가족이 지향하는 가치와 신념을 드러내도록 이끎
· 이를 통해 가족이 지향하는 가치나 신념을 드러내도록 함

3) 3단계 : 대안적 이야기 구축

- 독특한 결과를 동원하여 새로운 관계방식과 대안적 이야기 구성
  · 정체성·지향 상태 탐색, 행동탐색(과거/현재/미래)
  · 내담가족들이 스스로 삶에서 새로운 관계 방식을 찾고 대안적 이야기를 구성하도록 함
  · 대안적 이야기를 구축하기 위해서는 내담가족의 정체성과 지향을 탐색하고, 행동(과거/현재/미래)에 대한 탐색도 필요함

4) 4단계 : 대안적 정체성 구축

- 대안적 이야기를 만들어가고 더욱 풍부해지도록 도와서 대안적 정체성 구축
  · 내담자의 기여 탐색, 대상의 기여 탐색, 의미 있는 대상 설정, 정의예식(다시 말하기)
  · 가족이 새로운 관계방식과 대안적 정체성을 구축하도록 함
  · 정의예식을 통해 내담가족이 선호하는 삶의 이야기를 청중 앞에서 사회적으로 인정받는 경험을 갖도록 함
- 이야기치료에서 회기 구성은 매우 유동적임. 경우에 따라 1-2회에 종결되기도 하고 여러 차례의 회기로 이어지기도 함
- 상담 진행은 대개 50-60분 정도 소요되지만, 특별한 경우 그 시간을 초과하기도 함

11주차 3교시	이야기치료의 치료자 역할과 치료기법	
	수업목표	이야기치료의 치료자 역할과 치료기법을 이해하고 실제에 적용할 수 있다.
	세부내용	1. 이야기치료의 치료자 역할과 치료기법 2. 이야기치료의 치료사례

1. 이야기치료의 치료자 역할과 치료기법

◆ 치료자 역할

- 이야기치료 치료자의 자세는 '탈중심적이면서 영향력 있는' 것이어야 함

• 탈중심적
  · 치료자의 전문적 이론이나 지식을 내세우기보다 내담가족의 이야기나 삶의 지식과 기술에 우선순위를 둠

• 영향력 있는
  · 치료자가 치료의 아젠다를 일방적으로 채택하거나 개입을 주도하는 것이 아니라 호기심을 가지고 '알지 못함'의 자세로 내담자 가족에게 접근하는 것

① 내담가족을 자신에 대한 전문가로 간주하고 존중하는 태도를 가짐
② 내담가족의 이야기에 강한 관심과 호기심을 가지며 알지 못한다는 자세로 질문함
③ 내담가족에 대해 문제 해결에 관한 지식과 능력을 이미 갖추고 있는 존재로 여김
④ 치료의 방향에 대한 내담가족의 생각과 소망들을 확인함
⑤ 지배적 이야기로부터 분리하도록 돕는 역할

◆ 치료기법

1) 문제의 경청과 해체 단계

① 문제 이야기 경청하기
  - 내담가족이 문제중심의 이야기를 시작하고 어려움을 호소할 때 적극적인 경청, 공감, 문제와 사람 분리
  - 문제 이야기 속에서 내재한 내담자의 능력과 유능함, 긍정적 측면에 주의를 기울이고, 문제상황에서 가족원, 문화적 배경에 대한 관찰 필요

② 문제의 외재화(외재화 대화)
  - 문제를 의인화하여 표현함으로써 증상을 보이는 사람 외부에 있는 독자적 실체처럼 다루는 태도
  - 사용목적 : 사람이 문제가 아니고 문제가 문제라는 사고방식을 갖도록 하기 위함. 문제의 책임소재를 둘러싼 갈등이 약화하며, 가족들이 힘을 합하여 문제에 대처할 수 있게 됨
    · 문제의 내재화 : "지호는 공격적인 아동이라 학교에서 말썽을 부려요."
    · 문제의 외재화 : "공격수가 자주 튀어나오니 지호의 학교생활이 어려워지는군요."

③ 문제의 영향 탐색하기

- 문제가 내담자의 삶과 대인 관계에 이제까지 어떤 영향을 주었고 현재 어떤 영향을 미치는가를 질문
  · “그 문제 때문에 부부관계에 어떤 결과가 초래되었나요. 두 사람의 관계가 과거에는 어땠고 지금은 어떻게 달라져 있나요? 그 문제가 상대 배우자에 대해 어떤 생각을 하게 만들었나요?”

2) 부수적인 이야기 구축단계

① 독특한 결과의 영향 탐색

- 독특한 결과가 삶에 어떤 영향을 미쳤는지, 자신에 대한 생각이나 대인관계에 어떤 다른 국면이 펼쳐지는지 구체적으로 탐색
  예) 짜증이 당신을 지배하지 않게 될 때가 언제였나요?

② 독특한 결과의 영향에 대한 자기 입장 정리하기

- 독특한 결과로 인해 현재 전개되고 있는 내담가족이 선호하는 상황들 그리고 미래에 일어날 수 있는 가능성에 대한 이야기가 나오면, 그에 대해 내담자가 어떤 입장인지 정리하도록 질문하기
  예) 그것이 어머니와 아들 관계에 어떤 영향을 줬나요?

3) 대안적 이야기 만들기 단계

① 정체성 영역의 질문

- 치료자는 내담가족의 행동 이면에 존재하는 내담자의 지향과 의도, 내담자의 의도상태(자질, 의도, 목적, 희망, 가치, 헌신 등)를 드러내도록 대화 진행
- 독특한 결과와 관련하여 행동과 정체성에 대한 질문을 함
  예) “그때 어떤 생각을 하고 있었나요? 그런 일(독특한 결과)을 좀 더 쉽게 하는 데 도움이 되었던 생각이 있었나요?

② 행동영역의 질문

- 내담가족이 과거에 행했던 일
- 언제, 어디서, 누가, 무엇을 어떻게 했는가에 초점을 두고 매우 구체적으로 질문
  예) 최근에, 또는 예전에 이와 비슷한 일을 한 적이 있었나요?

4) 대안적 정체성 구축 단계

- 내담가족이 과거, 현재, 미래에 관한 풍부한 이야기를 계속 만들어가고 미래 희망에 초점을 맞추어 변화를 확장시키도록 함

• 외부증인집단

- 내담자가 먼저 자신의 삶과 관련된 새로운 이야기를 외부 증인이 된 가족이나 반영하는 치료팀 앞에서 말하고, 외부증인은 그 이야기를 듣고 내담자의 이야기 중에 특정 부분을 중심으로 자기 삶의 이야기에 어떤 의미를 주었는가를 말함으로써 내담자의 이야기를 인정함

• 치료적 문서활용

- 내담가족이 이룬 성취를 축하하고, 새로운 삶으로 전환한 것을 자신과 주위 사람에게 상기시켜서 변화를 계속 유지할 수 있도록 고안된 것임

· 치료적 문서의 형식은 편지, 메모, 진술서, 목록, 계약서, 증서 등 다양하며 형식의 제약은 없음

2. 이야기치료의 치료사례

◆ 치료사례

· 의뢰 사유 : IP(11살)가 갓난아이 때 부모의 이혼과 이후 계속된 아버지의 방임으로 친척집을 10여 차례 오가며 생활함. 거짓말과 훔치기, 식탐 문제 발생. 아버지의 출국으로 고아원에 맡기려고 함
· 성장 배경 : 큰엄마가 조카에 대한 연민으로 조카를 양육하기로 하고 아들(11세)과 딸(6세)과 똑같이 하면 나아질 것이라는 희망을 품고 노력했으나 아동의 문제행동은 계속 됨. 양육을 포기하고 싶지만 자녀들에게 포기하는 모습을 보이기 싫어 갈등을 하다가 상담실 방문

1) 1회기
- 문제중심 이야기를 하여 큰엄마로부터 IP를 양육하게 된 과정과 어려움을 경청하고, 무력감을 공감함

2) 2-3회기
- 문제 명명하기
  - 문제를 아동과 분리, 아동과 큰엄마가 가족이 된다는 공동의 목표를 갖고 문제를 찾는 작업. IP는 문제를 '욕심쟁이'로 명명. 그것은 악마처럼 생겼고 욕심이 많고, 가족과 살아야 한다는 마음과 착한 일 하는 것을 싫어한다고 함
- 문제의 영향 탐색하기
  - 문제에 대처하는 방법을 활용한 경험이 있었음
  - 문제의 영향 평가, 정당화하기 : 이를 통해 가족이 가까워짐
- 대안적 이야기
  - 큰엄마는 IP의 대안적 이야기의 청중으로서 외부증인이 됨. IP는 자신이 문제의 영향을 받고 있지만, 문제에 대항할 때도 있음을 확인하고 문제에 맞서 싸우는 '끈질긴 놈'으로 정체성을 보여줌

3) 4회기
- 부부는 욕심쟁이에 초점을 맞춰 노력하기로 동의함

4) 5-7회기
- IP의 문제행동이 많이 줄고 거의 나타나지 않음

5) 8회기
- IP의 문제행동은 사라졌고 가족으로서의 정체성을 확인하고 가족이 된 것을 축하하며 종결함

12주차 1교시	가족생활주기의 단계와 발달과제	
	수업목표	가족생활주기의 관점을 이해하고, 단계와 발달과제를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족생활주기의 관점 2. 가족생활주기의 단계와 발달과제

1. 가족생활주기의 관점

◆ 가족생활주기

- 가족생활에는 인간의 생애주기처럼 탄생과 죽음이 있다.
- 남녀가 결혼하면서 새로운 가족생활주기가 시작되고, 자녀의 출산과 양육으로 확대되었다가, 자녀의 독립으로 축소되며, 부부가 늙어 사망하게 되면 이 주기가 끝난다.
- 가족이 이러한 가족생활주기의 단계를 순조롭게 거치려면 결혼생활에 부과된 특정 과업을 완수해야 한다.

◆ 가족생활주기의 정의

- 인간은 태어나서 특정한 발달단계를 거치며 단계마다 과업이 있는 것처럼 가족에게도 발달단계와 과업이 있음
- 가족생활주기는 가족을 역동적으로 변화하는 체계로 간주하고 시간이 경과함에 따라 가족 내의 발달적인 경향을 묘사하기 위해 사용하는 용어

◆ 가족생활주기의 관점

- 가족생활주기 관점은 단계에 따라 수행해야 하는 과업을 중시하며 단계별 발달과업의 성취 여부는 증상이나 문제발생과 밀접한 연관이 있다고 봄
- 앤더슨과 사바텔리는 가족이 수행하고 관리해야 하는 과업을 1차 과업과 2차 과업으로 분류함

• 1차 과업
  · 가족의 특성이나 형태와 상관없이 가족이 공통적이고 필수적으로 수행해야 하는 과업
  예) 가족의 정체성 형성, 경계선 조정, 가족의 정서적 분위기조성, 가정관리를 위한 전략의 고안 등

• 2차 과업
  · 가족이 스트레스나 외부로부터의 정보, 그리고 변화에 반응하여 전략과 규칙을 조정할 책임을 수행하는 것으로 가족이 개방성과 적응력을 이루는 것

◆ 가족생활주기와 가족의 위기

- 각 단계의 발달 과업을 성공적으로 수행하지 못하거나 가족생활주기의 한 단계에서 다음 단계로 넘어갈 때(전환기) 적응의 문제가 생기기 쉬움

- 적응과정에서 심각한 문제가 생기면 스트레스를 많이 받게 되므로 가족생활주기상의 위기와 부적응이 가족 문제의 원인이 될 수 있음
  ⇨ 따라서 치료자는 내담자와 내담자 가족의 가족생활주기를 이해해야 함

◆ 가족생활주기를 임상에 적용할 때 한계점

① 가족체계가 계속적이고 상호작용적인 특징이 있음에도 가족생활주기의 단계는 특정 시기에 초점을 두고 기술함
② 오늘날 가족구조와 형태가 다양함에도 전통적인 핵가족 형태에 초점을 두는 경향이 있음
③ 가족생활주기 단계의 시작은 맏자녀의 발달적 전이 시점에 초점을 두는 경향이 있어서 가족 상호작용의 복잡한 특성을 반영하지 못함
④ 각 단계의 특징은 공통적일 수 있지만, 특정 과업의 수행방식이 가족마다 다를 수 있다는 점에 대한 관심이 부족함
⑤ 가족생활주기의 단계와 발달과업에 있어서의 문화적 다양성과 차이를 간과하는 경향이 있음
⑥ 사회의 변화에 따른 가족발달주기의 정기적인 수정 필요

2. 가족생활주기의 단계와 발달과제

◆ 백바르와 백바르의 가족생활주기 단계와 과업

- 선행연구들을 종합하여 가족생활주기의 단계와 단계별 주요 과업을 제시함

❖ 특징

- 자녀출산과 양육기를 4단계로 세분화함

단계	정서적 이슈	주요 과업
결혼 전 성인기	성인자녀의 부모로부터의 분리와 독립	· 원가족으로부터의 분화 · 동료관계의 발달 · 직장생활 시작
신혼기	결혼생활에의 몰입	· 부부체계의 형성 · 직장의 요구에 대한 적응 · 가족·친구와 더불어 배우자의 자리 만들기
자녀 출산기	새로운 가족구성원인 자녀의 수용	· 자녀의 자리에 대한 적응 · 부모역할 수행하기 · 조부모의 자리 만들기
학령 전 아동기	자녀의 새로운 인성의 수용	· 자녀의 요구에 적응하기 · 부부만의 시간 갖기 · 에너지 소모와 사생활 부족에 대처하기
학령기 아동기	자녀가 가족 외부의 관계를 수립하도록 돕기	· 가족/사회 상호작용 확장하기 · 자녀의 교육적 발달 격려하기 · 활동과 시간 요구의 증가를 다루기
10대	가족경계의 융통성을 증가시켜 자녀의	· 부모-자녀관계의 균형을 변화시키기

자녀기	독립성 허용하기	· 중년기의 직업 및 부부관계 이슈에 재초점 맞추기 · 노년기 세대에 대한 관심 높이기
진수기	가족구성원의 진수와 들어옴을 수용하기	· 성인자녀를 직업, 대학, 결혼생활로 진수시키기 · 지지적 가정 기반을 유지하기
중년기	자녀를 떠나 보내고 서로 직면하기	· 결혼생활의 재정립 · 자녀의 배우자 및 손자녀 환영 · 노부모의 노화에 대처하기
은퇴	은퇴와 노화의 수용	· 개인과 부부의 기능 유지 · 중년세대 지지하기 · 부모, 배우자의 죽음에 대처하기 · 가족의 주거변화

12주차 2교시	한국인의 가족생활주기	
	수업목표	한국인의 가족생활주기의 특성을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 한국인의 가족생활주기

1. 한국인의 가족생활주기

◆ 한국인의 가족생활주기

단계	과업	특정적 가족문제
결혼 전기	· 부모-자녀간 인격적 관계 정립 · 가족 외부로 향하는 정서적 애착과 생활양식의 차이 수용 · 부모의 중 · 노년기 준비	· 부모-자녀간 세대차이 · 아버지와 자녀간 불화 · 어머니의 지나친 간섭
결혼 적응기	· 역할과 책임관계의 기준 설정 · 상호 만족스러운 애정표현과 성생활 체계 수립 · 효율적인 대화체계 수립 · 친인척과의 원만한 관계 수립	· 인척과의 갈등 · 불안정한 생활패턴 · 불성실한 가정생활
자녀 아동기	· 영유아 자녀를 효율적으로 양육 · 영유아 자녀의 부모 역할 적응 · 만족스러운 부부관계 유지 노력 · 자녀의 잠재력 개발에 대한 교육적 배려 · 정서안정과 소속감을 갖도록 환경조성	· 가족유대감 약화 · 양육 및 가사노동의 불평등 · 부모-자녀 간 삼각관계 · 자녀의 컴퓨터 게임
자녀 청소년기	· 청소년 자녀의 자아정체감 형성, 진로선택 및 준비, 사회적 역할 획득, 학업성취, 정서적 독립 지원 · 재정계획 및 실천 · 만족스러운 부부관계 유지, 중년기 준비	· 친척, 원가족 갈등 · 성인자녀에 대한 간섭 · 남편의 무관심, 부인의 의존성
자녀 독립기	· 자녀의 결혼과 독립 지원 · 부부관계 재정비 · 건강대책 세우기/중년기 위기감 극복 · 조부모 역할 수행/노년기 준비	· 친척, 원가족 갈등 · 성인자녀에 대한 간섭 · 남편의 무관심, 부인의 의존성
노년기	· 노화 및 은퇴적응/건강유지 · 부부관계 유지, 증진 · 배우자의 사별과 죽음에 대한 수용	· 가족 내에서의 소외감 · 결혼한 자녀와의 밀착 · 남편의 불성실, 음주, 외도

- 공통적 가족 문제
  - 가족 간 갈등, 대화단절, 부부갈등, 불화, 폭력, 이혼, 경제적 문제

❖ 에릭슨의 가족생활주기 단계별 치료적 접근방법

- 에릭슨은 가족생활주기가 변화해 가는 과정에서 잘 적응하지 못할 때 증상이 나타난다고 보아 개인의 증상에만 초점을 두기보다는 가족생활주기가 다시 잘 움직이도록 가족 문제의

해결에 초점을 둠

단계	문제	치료목표	개입방법
구애기	① 신체적 외모에 대한 콤플렉스 ② 원가족과의 분화 문제 ③ 또래관계의 문제	부적응 개인을 도와 직업과 배우자를 얻게 하여 기능적인 사회구성원이 되는 것	① 사고, 행동방식을 수용하면서 변화로 이끄는 생각과 행동을 소개함 ② 치료자와 지역사회의 지원을 최대한 활용 ③ 자신에 대한 인식, 특히 신체상을 재개념화시킴
결혼 초기	① 배우자 및 원가족과의 마찰 ② 성적 부적응, 배우자의 외도 ③ 결혼에 대한 헌신의 부족	여러가지 문제를 극복하고 부부생활을 유지하면서 자녀양육기로 넘어가는 것	① 증상을 이용해 원가족과 독립할 수 있게 함 ② 성적 부적응을 병리적으로 다루지 않음 ③ 배우자의 외도는 상황에 따라 직접적으로 개입함
자녀 양육기	① 한배우자가 자녀와 밀착되어 부부문제를 자녀를 통해 다룸 ② 자녀양육으로 부부 또는 원가족과 갈등 ③ 습관적인 의사소통 문제 ④ 경계선 파괴	부모와 자녀를 분리하여 부부생활과 자녀양육생활을 독립적으로 하는 것	① 개인을 둘러싸고 있는 상황을 모두 고려함 ② 부모의 권위는 인정하고 상황에 따라 아동과 치료적 동맹을 맺음 ③ 과잉 간섭하는 부모를 아동에게서 분리시킴 ④ 아동의 잘못된 행동보다는 올바르게 행동하는 데 초점을 둠
중년기	① 주도권을 갖기 위한 힘겨루기 ② 가족안정성 유지를 위해 역기능적 상호작용 고수함	부부의 습관적이고 주기적인 상호작용에 내재된 갈등 해결	① 부부를 함께 상담 ② 부부의 역기능적 관점을 바꿈 ③ 모순적인 과제부여로 변화야기 ④ 직면을 사용함
자녀 독립기	① 자녀의 독립으로 부부의 공통요소가 사라져 그동안 유지해 온 가족의 안정성이 깨짐 ② 부모의 관심, 과잉보호로 부모-자녀관계가 동료관계로 옮겨가지 못함	자녀는 독립하여 성인의 역할을 수행하게 하고 부모는 자녀를 독립된 개체로 인정하며 이전과 다르게 상호작용하는 것	① 필요에 따라 부모와 자녀를 함께 또는 개별적으로 작업 ② 자녀를 가족과 분리시키면서도 가족과의 유대를 지속하게 함
노년기	① 은퇴에 따른 역할상실감 ② 부부가 갑자기 24시간 함께 있게 됨으로써 문제발생	변화에 대한 희망보다는 피할 수 없는 일을 수용하게 함	① 부부가 애정적이고 서로 도움이 되는 역할을 하도록 함 ② 배우자가 사망할 경우 다른 가족과의 관계를 도움

			③ 질병의 고통을 덜어주기 위해 최면술 사용

12주차 3교시	이혼과 재혼가족의 가족생활주기	
	수업목표	이혼가족과 재혼가족의 가족생활주기를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 이혼가족의 가족생활주기 2. 재혼가족의 가족생활주기

1. 이혼가족의 가족생활주기

◆ 이혼가족의 가족생활주기 특성

- 이혼을 생각하는 시점부터 이혼 성립까지의 기간 중 여러 시점에서 가족은 정서적 스트레스를 경험하게 됨
  - · 별거 또는 이혼을 결정한 시점
  - · 이혼결정을 가족과 친구에게 알린 시점
  - · 재산과 자녀양육/방문권에 대해 논의가 된 시점
  - · 신체적 별거가 이루어진 시점
  - · 법률상 이혼이 성립한 시점
  - · 별거 부부나 전 배우자가 재산이나 자녀 문제로 접촉하는 시점
  - · 자녀가 모두 졸업하고 결혼하여 자녀를 가지거나 병든 시점
  - · 각 배우자가 재혼하고 이사하며 병이 들어간 사망한 시점

❖ 이혼 가족의 가족생활주기

단계	발달과업
이혼 전 의사결정	· 이혼결정에 따른 실패감, 상실감, 두려움 해소 · 현실 수용 · 자기수용
이혼 협상	· 자녀양육권, 재산분할에 관한 합리적 의사결정 · 자녀 및 확대가족과의 관계 재정립 · 배우자에 대한 애착 해소
이혼	· 실패감, 죄책감, 상실감 해소 · 결혼생활에 대한 통합적 정리 · 재결합 환상 포기하기 · 재정, 자녀관계 재정비 · 협력적 공동 부모 역할 재정비
이혼 후	· 전 배우자와의 관계 재설정 · 분노, 상실감, 외로움 해소 · 자녀의 혼란과 상실감, 부적응 문제 대처 · 정신적 · 정서적 독립

❖ 이혼 전후 가족의 정서적 과정과 발달적 쟁점(이혼 전)

양상	전환의 정서적 과정	발달적 쟁점

	필수적 태도	
1. 이혼 결심	결혼관계를 유지하기 위한 문제해결능력이 없음을 인정	결혼실패에 각자가 책임이 있음을 수용
2. 체계 붕괴 계획	체계에 속한 모든 사람을 위해 적절한 배려	① 공동양육, 방문 및 재정 지원과 같은 문제를 협동적으로 작업 ② 확대가족과 이혼에 대해 다룸
3. 별거	① 자녀에 대한 공동 부모역할과 재정 부담의 의사를 밝힘 ② 배우자에 대한 애착을 떼기 위한 작업	① 정상가족 상실에 대한 애도 ② 부부관계, 부모자녀관계 및 재정 문제의 재구조화 및 별거생활의 적응 ③ 확대가족과의 관계 재정비, 배우자의 확대가족과 지속적 관계 유지
4. 이혼	정서적 이혼에 대해 더 열심히 작업. 즉, 상처, 분노, 죄책감 등 극복을 위한 노력	① 정상가족 상실에 대한 애도 : 재결합에 대한 환상 포기 ② 결혼에 대한 희망, 꿈, 기대를 되찾음 ③ 확대가족과 지속적 관계 유지

❖ 이혼 전후 가족의 정서적 과정과 발달적 쟁점(이혼 후)

양상	전환의 정서적 과정 필수적 태도	발달적 쟁점
1. 한부모가족 (보호자가정)	재정적 책임을 지면서, 전 배우자와 공동양육관계를 유지, 전배우자와 그 가족이 자녀와 접촉을 유지하도록 지지	① 전 배우자 및 그의 가족이 방문할 수 있도록 방문시간을 융통성 있게 조절 ② 자신의 재정적 수단 재정립 ③ 자신의 사회적 관계망 재정립
2. 한부모가족 (비보호자)	전 배우자와 부모관계를 위한 접촉을 유지하면서, 그와 자녀와의 관계 지지	① 효율적인 부모관계를 지속하는 방법 찾기 ② 전 배우자와 자녀에 대한 재정적 책임 유지 ③ 자신의 사회적 관계망 재정립

2. 재혼가족의 가족생활주기

◆ 재혼 현황과 특징

- 우리나라의 재혼은 지속적으로 증가하고 있음
- 사별 후 재혼보다 이혼 후 재혼 증가
- 재혼가족은 전통적인 가족생활주기의 분열이면서 새로운 주기의 시작으로, 재혼 전에 가졌던 가족생활주기의 형태가 일부 유지되면서 새로운 가족생활주기가 시작됨
- 재혼가족의 구성원은 부모의 죽음이나 별거와 같은 중요한 상실경험을 가지고 있는데, 서로

다른 경험, 전통, 가치, 기대를 지닌 사람이 어느 시점에 한 가족을 이루게 되므로 어려움이 예상됨

◆ 재혼 가족의 형성: 발달적 개요

❖ 1단계 : 새로운 관계의 형성

• 필수적 태도

- 첫 결혼 상실에서의 회복(적절한 '정서적 이혼')

• 발달적 쟁점

- 복잡성과 모호성을 다룰 준비를 갖추고 새로운 결혼과 가족 형성에 다시 헌신함

❖ 2단계 : 새로운 결혼과 가족에 대한 개념화와 계획 세우기

• 필수적 태도

- 재혼과 계가족 형성에 대한 자신과 새 배우자 및 자녀가 갖는 두려움을 수용
- 다음 사항에 내재된 복잡성과 모호성에 적응하기 위해 시간과 인내심이 요구됨을 인정

1) 다양한 새로운 역할
2) 경계 : 공간, 시간, 소속감 및 권위
3) 정서적 문제 : 죄책감, 충성심, 갈등, 상호성에 대한 욕구, 해결되지 않은 과거의 상처

• 발달적 쟁점

① 거짓상호성을 피하기 위해 새로운 관계에서 개방성을 갖도록 작업
② 전 배우자와 공동 재정 및 공동 부모관계 유지를 위한 계획
③ 자녀가 두 체계 안에서 겪는 두려움, 충성에 대한 갈등 및 소속감을 다룰 수 있도록 돕기
④ 배우자 및 자녀를 포함시키기 위해 확대가족과의 관계를 재정비
⑤ 자녀가 전 배우자의 확대가족과 관계를 유지하도록 계획

❖ 3단계 : 재혼 및 가족의 재구성

• 필수적 태도

- 전 배우자에 대한 애착 끊기와 이상적인 '정상가족'에 대한 집착에서 벗어남
- 투과성 있는 경계를 가진 새로운 가족모델 수용

• 발달적 쟁점

① 새 배우자-계부모를 포함된 가족 경계선 재구조
② 여러 체계가 섞일 수 있도록 관계와 재정적 배려를 하위체계를 통해 재조정
③ 자녀가 보호자의 친부모, 조부모 및 확대가족과 관계를 지속하도록 허용
④ 계가족의 통합을 강화시키는 추억과 역사의 공유

13주차 1교시	가족평가의 의미와 과정	
	수업목표	가족평가의 의미와 어려움이 무엇인지 이해하고, 가족평가의 과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족평가의 개념과 어려움 2. 가족평가의 과정

1. 가족평가의 개념과 어려움

◆ 가족평가(사정)의 개념과 어려움

- 가족의 건강성, 기능, 과업 수준을 파악하는 가족사정(family assessment)은 가족을 하나의 단위로 보고 가족 내부 및 외부 요인 그리고 이들 양자 간 상호작용 등을 파악하기 위해 자료를 수집·분석하고 종합하여 그 가족에 대한 개입을 계획하는 일련의 과정을 말함
- 가족에 대한 진단과 평가를 위해서는 가족구성원의 생리적 적응양식과 가족구성원에 대한 신념과 감정, 가족의 결속력, 지역사회와의 관계, 가족의 윤리·도덕적 가치, 가족의 현재와 미래 지향, 가족구성원의 역할과 책임영역, 의사소통의 적절성, 개인적인 욕구, 가족구성원의 질병이나 실직 등에 대한 가족의 대처능력 등도 파악해야 함
- 가족평가를 할 때에는 가능한 한 객관적인 자료를 확보하기 위한 양적·질적 방법을 활용하는 것이 도움이 됨

◆ 가족평가(사정)의 개념

❖ 가족평가의 개념

- 가족평가란 가족을 진단하고 평가하여 측정하는 일련의 행위
- 가족을 하나의 '단위'로 보고 가족 내부 및 외부체계 그리고 이들 간의 상호작용을 파악하기 위해 자료를 수집하고 분석하고 종합하여 그 가족에 대한 개입을 계획하는 일련의 과정
- 이 과정에서 가족 문제, 가족의 구조와 관계유형, 가족과 외부체계와의 상호작용, 가족의 강점, 문제해결을 위한 자원, 내담자 가족의 문제해결에 대한 동기 등 평가함

❖ 평가 방법

- 질적 평가 vs. 양적 평가
  - · 질적 평가 : 면접과 관찰 등
  - · 양적 평가 : 척도나 체크리스트 등
- 주관적 평가 vs. 객관적 평가
  - · 주관적 평가 : 치료자에 의한 관찰과 면접, 내담자 가족의 지각 등
  - · 객관적 평가 : 내담자에 대한 관찰이나 기록, 관련 연구문헌 등의 경험적 자료 등

◆ 가족평가(사정)의 어려움

1) 가족의 복잡성

- 두 명 이상의 구성원의 특성을 진단하여 가족 단위로 종합하여 평가하는 것은 복잡하고 어

려운 작업

⇨ 따라서 가족평가를 할 때에는 가족의 유전적 요소, 가족의 역사, 외부 사회체계와의 상호작용, 세대 간 헌신 등 가족의 특성을 통합적으로 고려해야 함

2) 평가의 철학적 근거

• 모더니즘(근대주의) 입장
  - 기능적 가족과 역기능적 가족에 대한 명확하고 보편적인 기준을 사용하여 평가함
• 포스트모더니즘 입장
  - 평가자의 가치가 내재된 여러 가지 맥락 내에서 영향을 받는다고 봄
  - 최근으로 올수록 전문가의 평가는 최소화하고 내담자의 평가를 존중하는 경향이 강해짐

3) 평가의 단위 및 정보를 얻는 방법

- 평가의 단위 및 정보 출처의 문제
  · 자기 보고식 질문지를 적용할 수 있는 연령은 몇 세부터 인가?
  · 둘 이상의 관계에 대한 평가 시 1명의 정보만 얻는 것이 적절한가?

4) 가족치료모델에 따른 평가에 대한 관점 차이

- 치료자가 선호하는 가족치료 모델에 따라 평가의 초점이 달라짐

⇨ 행동주의 치료자 : 표준검사 사용
구조주의 치료자 : 경계와 전반적인 상호교류 유형에 관심
전략주의 치료자 : 삼각화, 위계 및 증상을 유지시키는 유형의 평가에 관심
다세대 치료자 : 분화수준의 평가를 우선

• 공통점
  - 가족에 대한 관찰, 상호작용을 통한 임상적 판단

2. 가족평가의 과정

◆ 가족평가계획

1) 첫 면접에서 평가할 내용

① 현재 드러나는 문제 탐색
② 시도된 해결방안
③ 위기, 스트레스를 주는 사건

2) 잠재된 이슈 제거하기

- 자살, 가족폭력, 위협, 성폭력 등

3) 가능한 한 위험물 없애기

4) 가능한 한 신체적 문제 제거하기

5) 심리적 평가

① 정서, 행동, 인지
② 부부, 가족체계
③ 가족 외부 사회체계

(출처 : 구본용 외, 1998. 가족상담기법Ⅱ)

◆ **가족상담 단계에 따른 평가**

❖ 초기단계의 평가

· 가족이 제시하는 문제와 강점 및 의사소통 유형은 어떠한가?
· 어떻게 가족치료에 의뢰되었는가?
· 가족의 가족생활주기의 단계는 어떠하며 발달과업을 어떻게 수행되었는가?
· 가족은 문제해결을 위하여 어떤 시도를 하였는가?
· 약물 및 알코올 중독, 가정폭력, 성학대, 혼외학대 등의 문제가 있는지?
· 가족의 성역할 및 가족구조는 어떠한가?
· 가족 문제에 대한 치료자의 가설은 어떠한가?

❖ 중기단계의 평가

- 치료자는 가족평가에 기초하여 치료적 개입을 선택하며, 치료적 중재에 대한 효과성을 검증하기도 함
- 중기단계에서 회기가 거듭되어도 가족과정이 향상되지 않고 있다면 치료가 정체되는 이유에 대한 파악이 필요함
  · 가족원의 상호이해가 촉진되는가?
  · 치료가 정체되지 않았는가?
  · '피하고 싶은' 어려운 관계나 개인이 있는가?
  · 대화주제 선택에서 치료자가 지나치게 개입하고 있지 않은가?
  · 치료자가 특정 가족원의 역할(아내, 특정 자녀 등)을 맡고 있지 않은가?

❖ 종결단계의 평가

- 가족의 문제가 어느 정도 해결되었는지 파악하는 것이 중요한 평가내용이 됨
- 가족이 목표를 이루었다고 느끼고 치료자가 횟수를 줄이거나 회기 간격을 늘리는 것이 좋겠다는 생각이 든다면 종결의 신호라고 볼 수 있음
- 종결단계에서 가족은 그동안 상담에서 배운 내용을 회고해 보고 강화하는 시간을 가짐
  · 제시된 문제가 해결되었는가?
  · 가족 상호작용 유형이 개선되었는가?
  · 가족원 각자가 목적했던 바를 이루어 만족하는가?
  · 미래에 비슷한 문제가 재발했을 때 다룰 수 있는 방법을 알고 있는가?
  · 가족원이 가족 내외의 관계를 개선해 왔는가?

13주차 2교시	가족평가의 방법과 검사도구	
	수업목표	가족평가의 방법과 검사도구를 나열할 수 있다.
	세부내용	1. 가족평가의 방법 2. 가족평가 검사도구 I

1. 가족평가의 방법

◆ **면접**

❖ 가장 기본적이고 중요한 도구로서 언어를 매개로 내담자와의 내담관계에서 증상의 어려움이나 가족의 대처, 가족의 기능을 평가할 수 있는 방법

• 면접의 대상

- IP, 가족, 이웃 등 내담자와 관련된 다양한 주변인

- 면접을 통해 치료자는 가족 문제의 지속기간, 문제의 과거기록, 문제에 대해 가족원이 갖는 관점, 문제해결을 위해 기울였던 노력의 종류와 정도, 상황을 변화시키려는 의지의 정도 등 평가
- 면접을 할 때에는 관찰, 체크리스트, 구조화된 설문지 등을 병행하기도 함

• 면접 분위기

- 개방적이고 편안한 분위기, 주변의 방해를 받지 않을 만한 공간을 선택하고 녹음기 등 필요한 기자재 준비(녹음에 대해서는 내담자에게 사전동의를 구해야 함)

- 상담사는 경청해야 함. 상담사의 말은 절제되어야 하고, 내담자의 대화 양은 많아야 함
- 그러나 말하는 것을 거부하는 내담자에게는 억지로 말을 시키는 것보다는 침묵도 의사소통의 일부로 인정하고 활용하여 함

◆ **관찰**

❖ 관찰은 가족원의 실제 상호작용을 잘 살펴보고 그들의 언어적, 비언어적 교류를 평가하는 방법

- 관찰을 통해 가족 내의 연합과 동맹, 삼각관계, 역할수행, 갈등, 권력과 통제 등의 역동을 파악할 수 있으며, 치료적 개입의 효과도 알 수 있음
- 가족에 대한 정확한 평가를 위해서는 가족의 실제 생활을 관찰하는 것이 가장 이상적이나 현실적으로 불가능
- 그 대안으로 <u>합동그림 그리기, 가족조각</u> 등 활용할 수 있음

• 합동그림 그리기

· 가족에게 함께 그림을 그려 보도록 하고 합동그림을 그리는 과정에서 나타나는 권력과 연합, 규칙의 집행 등을 관찰함

• 가족조각

· 가족원이 다른 가족원을 상대로 가족원의 신체적 동작과 자세, 표정 등을 자유롭게

연출하도록 함

· 가족조각을 통해 가족원 스스로 깨닫지 못했던 정서적 관계가 시각화되는 투사적 방법으로, 언어적 능력이 부족한 내담자에게도 적용할 수 있음

· 또한 가족조각의 과정과 조각 후의 토론에 대해 관찰하여 가족관계에 대해 진단할 수 있는 자료가 됨

◆ 검사

❖ 검사도구의 형태

1) 도식적 검사

- 가족의 과거와 현재에 걸친 다세대 역동과 사회적 관계망 등을 시각적으로 확인할 수 있는 도구

  예) 가계도, 생태도

2) 계량적 검사

- 가족기능을 측정하기 위해 표준화 또는 비표준화 척도 사용

  예) MBTI, ENRICH, FACES, CRS 등

◆ 가족생활주기 활용

- 가족의 기능과 역할을 평가하기 위해 가족생활주기를 고려해야 함
- 가족이 처한 가족생활주기에 따라 수행해야 할 과업을 제대로 수행하고 있는지를 파악하고, 각 가족발달주기 또는 사건이나 상황에 따라 예상되는 위기를 인지하고 이를 점검해야 함

• 신혼부부
  - 부부간 성적 적응, 시집·처가의 부적응

• 임신 및 출산
  - 임신 시 부인의 신체적·정서적 변화에 대한 부적응, 경제적 부담, 가사노동 역할분담 등

• 자녀 유아기
  - 자녀양육에 대한 역할 분담, 부모의 양육태도 불일치 및 통제 방식의 문제, 방임

• 자녀 학동기
  - 부부간 권태기, 자녀의 학교생활 부적응, 자녀의 부모와의 불리불안, 부모의 자녀에 대한 과잉기대, 사교육비 부담으로 인한 경제적 위기 등

• 자녀 사춘기
  - 부부만족도 최하, 과도한 교육비, 부모자녀 간 세대 차이, 부모가 자녀의 독립을 수용 못함, 자녀에 대한 과잉기대, 자녀 진로지도 등

• 자녀 독립기
  - 자녀에 대한 관여 상실로 인한 우울, 부인의 주장성 증가, 가족 간 유대 약화, 노부모 부양으로 인한 경제적·심리적 부담

• 자녀의 결혼
  - 인척 간 갈등·불균형, 삼각관계, 이질적 가족문화의 충돌

• 은퇴

- 부부간 접촉시간의 극대화로 인한 갈등 재출현, 사회적·경제적 위축

• 조부모기
- 조부모와 부모 간 자녀양육에 대한 의견차, 가치관의 차이

• 사별
- 고독, 독거에 따른 가사 관리의 불편함, 죽음에 대한 두려움

- 이러한 내용을 참고로 가족의 기능과 역할 평가에 도움이 되는 정보를 수집할 수 있음
  · 현재 개인 또는 가족이 속한 발달 단계
  · 살아오면서 경험한 주요한 생활사건
  · 문제가 일어나고 표현되는 패턴 그리고 그 양상이 변화된 시기
  · 지금보다 조금 나아졌던 시기나 상황
  · 지금보다 더 나빠졌던 시기나 상황
  · 현재의 삶에 나타난 문제에 대한 가족의 시각 파악 - 영속적인지, 일시적인지 여부
  · 부모의 통제가 개인의 발달적 요구에 적합한지 여부

2. 가족평가 검사도구 I

◆ 가계도

❖ 가계도란 3세대 이상에 걸친 가족구성원에 관한 정보와 가족관계를 표준화된 형식으로 도식화 한 것

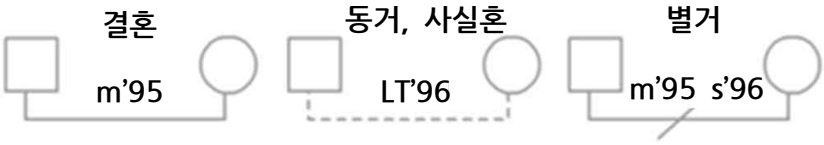
- 보웬이 대중화에 기여하고, 맥골드릭과 거슨, 카터 등에 의해 한층 발전되어 가족상담 및 치료 시 가족사정의 도구로 널리 사용되고 있음
- 일반적으로 가계도는 첫 회기에 대부분이 완성되고 새로운 정보가 나타날 때마다 수정됨
- 가계도 작성을 위해 상담사는 질문을 통해 기본적인 정보, 가족관계나 기능에 관한 정보, 가족사건 등을 표준화된 형식으로 도식화하여 복잡한 가족유형의 형태를 간단하게 정리함
- 가계도를 통해 가족을 수평적·수직적으로 동시에 파악하여 가족에 관한 구조적·관계적·기능적 정보를 관찰하여 현재와 과거의 가족유형이 지닌 역기능적 구조를 알 수 있음
- 또한 가족구조나 생활상의 큰 변화로 인한 가족관계나 과거의 질병 양상 등을 파악하고 가계도에 정리하면서, 가족에게 영향을 미친 요소 추론 가능

◆ 가계도 작성법

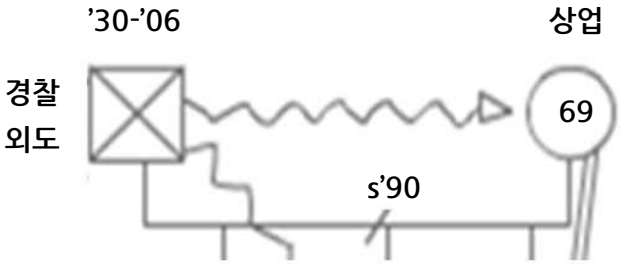
1) 가족구조의 도식화



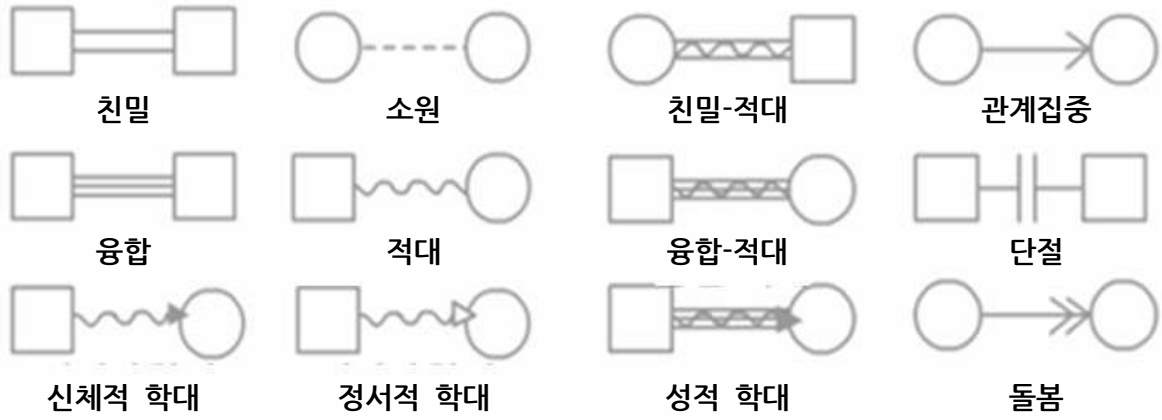




2) 가족에 관한 정보 기록
- 가족 구성원의 이력, 가족관계의 특징과 가족의 중요한 가족사건 등에 관한 정보 덧붙임
- 연령, 출생 및 사망시기, 주소, 직업, 교육 수준 등, 신체, 정서, 행동에 관한 객관적인 정보 기입



3) 가족에 관한 정보 기록
- 친밀, 소원, 적대, 적대, 융합, 신체 및 정서적 학대 등



4) 병력 및 기타 중요 정보
- 심한 질병을 앓았거나 만성 질환, 가족을 힘들게 했던 것 조사



약물·알코올 남용 **약물·알코올 남용 추정** **약물·알코올 남용에서 회복** **심각한 정신적·신체적 문제** **약물·알코올 남용과 정신적·신체적 문제**

5) 다양한 정보수집을 위한 면접의 방향

- 제시된 문제 자체로부터 문제의 배경으로
- 동거가족에서 확대가족과 더 넓은 사회체계까지
- 현재의 가족상황으로부터 가족사건의 역사적 연대기까지
- 쉽고 무난한 질문에서부터 어렵고 불안을 유발하는 질문까지
- 분명한 사실의 인식에서부터 역할이나 관계를 판단하여 가족유형에 대한 가설을 세우기까지

❖ 가계도 관찰 및 해석 시 유의사항

- 가족구조, 출생순위, 특이사항은 가족을 이해하기 위한 기초자료로 활용 가능
- 연합, 정서적 단절, 갈등유형, 역할의 과다 또는 과소 현상 등 가족불균형은 가족체계 기능을 회복시키기 위한 단서이므로 주목해야 함
- 가족의 중대한 사건과 때를 같이하여 발생한 가족의 역할이나 관계의 변화, 부적절한 가족생활주기의 변천, 즉 예상 밖의 출산, 결혼, 사망 등에 특히 주목해야 함
- 세대를 통해 증상, 관계와 역할 유형이 반복될 때, 그것은 과거만의 것이 아니라 현재와 미래에도 계속될 수 있다고 봄
- 가족의 기능과 적응력은 사회·정치·경제적 맥락 등 시대적 배경의 영향을 받으므로, 이와 관련된 해석도 고려해야 함

13주차 3교시	가족평가 검사도구 및 평가의 주체	
	수업목표	가족평가 검사도구를 나열하고, 평가의 주체를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족평가 검사도구 II 2. 평가의 주체

1. 가족평가 검사도구 II

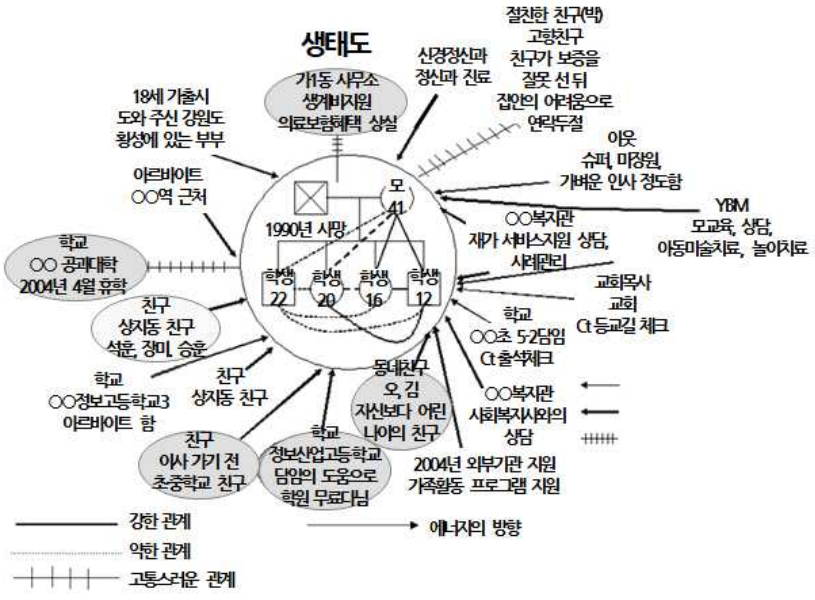
◆ 생태도

❖ 생태도의 개념

- 생태도는 가족과 가족의 생활공간 안에 있는 사람 및 기관 간의 연계를 그림으로 나타내는 방법
- 생태도를 통해 환경에서 가족으로 자원의 흐름이 어떻게 이루어지는지 표시됨으로써 내담자에게 유용한 자원, 가족에게 스트레스를 주는 자원, 가족과 환경 간의 경계 등 가족 내 역동과 가족 외 역동에 대한 많은 정보를 얻을 수 있음
- 치료자가 내담자와 함께 생태도를 그릴 수도 있고 치료자가 질문방식의 인터뷰를 하면서 정보를 수집하여 그릴 수도 있음

❖ 생태도 작성방법

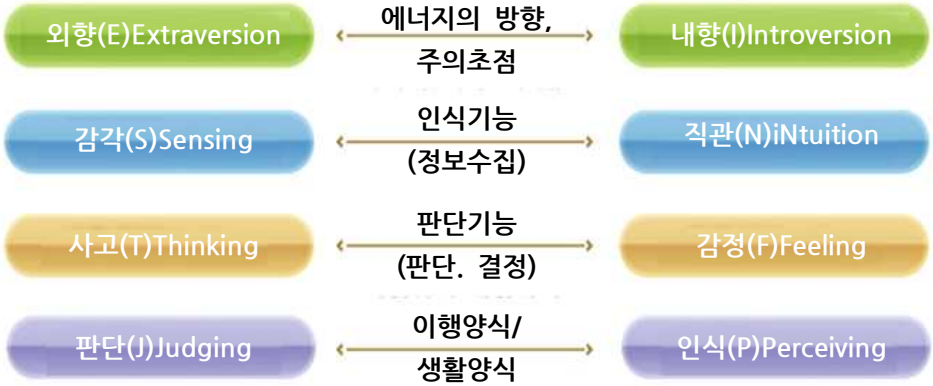
① 중앙에 원을 그리고 원 안에 내담자 가족의 가계도를 그림
② 현재 함께 살고 있지 않은 가족원은 원 밖에 배치
③ 내담자 가족에 영향을 미치는 환경체계(학교, 직장, 복지관 등)를 원 밖의 주변에 배치
④ 환경체계를 표시하는 원 안에 관련 사항을 간략하게 기입
⑤ 내담자 가족체계와 모든 환경체계 간의 상호교류를 기호로 표기(상호 교류의 성격에 따라 강한 관계, 약한 관계, 갈등 관계 등 다양한 선으로 표시)



◆ **MBTI (Myears-Briggs Type Indicator)**

❖ MBTI에 대한 이해

- Myears와 Briggs에 의해 개발된 검사로서 일상생활에 유용하게 활용할 수 있도록 고안한 자기보고식 성격유형지표로서 미국의 가족치료자들이 임상현장에서 가장 많이 활용하는 검사 중 하나
- 성격유형은 네 가지 차원의 조합으로 이루어져 있으며 16개의 유형으로 나뉘어짐
- MBTI 검사의 목적은 성격유형검사를 통해 자신의 심리적 개체성을 이해함과 동시에 타인과의 차이점을 이해하고 수용할 수 있도록 하기 위함
- 활용 영역 : 가족구성원 간 이해, 직장 내 조직원의 이해, 학교에서 진로지도 등



❖ 출처 : 한국MBTI 연구소

❖ 평가방법

- 자기보고식
- 두 가지 다른 특성을 측정하는 질문에 스스로 답변하도록 함

❖ 결과 해석과 적용

- 자신의 성격유형이 16가지 중 하나로 나옴

ISTJ	ISFJ	INFJ	INTI
책임감 강함, 현실적임, 철저하고 보수적	차분, 헌신적, 인내심 강함, 타인의 감정 변화에 주의	높은 통찰력으로 영감을 줌, 공동체 이익을 중요시함	의지가 강함, 독립적임, 분석력 뛰어남
ISTP	ISFP	INFP	INTP
과묵하고 분석적이며, 적응력 강함	온화하고 겸손함, 삶의 여유를 만끽함	성실, 이해심 많음,잘 표현하지 않으나 내적 신념 강함	지적 호기심이 높음, 잠재력과 가능성 중요시함
ESTP	ESFP	ENFP	ENTP
느긋, 관용적, 타협 잘 함, 현실적 문제 해결에 능숙	호기심 많고, 개방적, 구체적인 사실 중시함	풍부한 상상력, 순발력 뛰어남, 일상적인 활동에 지루함 느낌	박학다식, 독창적, 끊임 없이 새로운 시도를 함
ESTJ	ESFJ	ENFJ	ENTJ
체계적, 규칙 준수, 사	사람에 관심 많고 친절	사교적, 타인의 의견	철저한 준비, 활동적임,

실적 목표설정에 능함	함, 동정심 많음	존중, 비판 받으면 예민해짐	통솔력, 단호함

❖ 유형에 대한 이해

1) 외향성(extraversion)과 내향성(introversion)

- 심리적 에너지와 관심의 방향이 내부와 외부 중 어느 쪽으로 향하는지 지표

• 외향적
  - 외부 세계에 관심, 사교적, 활동적, 경험한 후 이해함
  - 자신을 숨기기보다는 드러냄

• 내향적
  - 내면에 더 주의집중, 조용하고 내적 활동 즐김
  - 생각이 많고, 말보다는 글로 표현, 생각한 후 행동

2) 감각형(sensing)과 직관형(intuition)

- 대상을 인식하고 지각하는 방식에서 감각과 직관 중 어느 쪽을 주로 더 사용하는지에 관한 지표

• 감각형
  - 오관에 의존, 현재에 집중
  - 실제적인 것 중시, 세심한 관찰 능력이 뛰어남

• 직관형
  - 상상력 풍부
  - 창조적, 육감에 의존
  - 나무보다는 숲을 보려는 경향, 비유적인 묘사 선호

3) 사고형(thinking)과 감정형(feeling)

- 판단하고 결정을 내릴 때 사고와 감정 중 어느 쪽을 선호하는지 방식에 대한 지표

• 사고형
  - 객관적인 사실에 주목, 분석적으로 판단함
  - 원칙과 규범 중요시 / 맞다-틀리다 식의 사고

• 감정형
  - 인간적인 관계나 상황적 특성에 따라 판단함
  - 좋다-나쁘다 식의 사고 / 정서적 측면에 집중
  - 논리적인 판단보다 사람들에게 미칠 결과를 중요시함

4) 판단형(judging)과 인식형(perceiving)

- 실생활에 대처하는 방식에 있어 판단과 인식 중 어느 쪽을 선호하는지에 관한 경향성

• 판단형
  - 빠르고 합리적이며 옳은 결정을 내리고자 함
  - 목적 의식 뚜렷 / 조직적이고 체계적으로 행동하는 경향

• 인식형
  - 상황에 맞추어 활동, 모험이나 변화에 대한 열망이 높음

- 호기심이 많으며, 계획보다는 상황에 따라 행동하는 경향

❖ MBTI 선호지표에 따른 부부유형의 장점과 단점

1) 에너지원 (I vs. E)

조합	장점	단점
내향-내향 (I - I)	· 서로의 깊이 이해 · 사적 공간과 개인시간에 대한 상대방의 요구 존중 · 독립적이고 조용함	· 모두 외부 인간관계를 추진하지 않음 · 표현 부족 · 정서 부담이 클 때까지 참음
외향-내향 (E - I)	· 내부-외부 에너지가 균형을 이루어 상호보완됨	· 에너지 충전방법 다름 · 갈등 해결방식 다름
외향-외향 (E - E)	· 모두 활동적 · 민첩 · 일이 지연되지 않고 사람들과 어울리며 즐거워함	· 모두 바빠 함께 할 시간이 적고 서로 경청이 어려우며 주목을 끌려고 경쟁함

2) 자료수집 기능 (S vs. N)

조합	장점	단점
직관-직관 (N - N)	· 이상과 꿈을 서로 격려 · 개방적, 추상적인 대화 즐김	· 현실적이지 않아 삶의 실제적 문제 지연 · 생활에 변화가 많아 복잡해짐
감각-직관 (S - N)	· 감각형은 단기목표에 강하고 현실적, 직관형은 장기목표에 강하여 공상을 좋아해 상호보완점임	· 서로 관심이 달라 대화가 어려울 수 있음
감각-감각 (S - S)	· '지금' 현실에 잘 적응 · 현재에서 즐거움을 찾으며 서로 안정욕구를 존중함	· 문제발생 시 대안을 찾기 어려우며 변화에 도전하기를 두려워함

3) 결정기능 (F vs. T)

조합	장점	단점
감정-감정 (F - F)	· 모두 인정 있고 따뜻한 분위기를 만들며 사람과 관련된 활동을 함	· 비판에 예민 · 갈등 두려워함 · 갈등 발생 시 회피 · 문제해결이 어려움
사고-감정 (T - F)	· 주관성과 객관성이 균형을 이루면 상호보완됨	· 사고형의 '왜'라는 질문에 감정형은 예민함 · 친밀감의 욕구에서도 갈등을 가질 수 있음
사고-사고 (T - T)	· 명백하고 편견 없는 의사 소통, 유사한 친밀감 욕구와 표현을 함	· 둘 다 정서표현이 서투르며 때로 본능적반응이 무시됨

4) 생활양식 (J vs. P)

조합	장점	단점
인식-인식 (P - P)	· 서로 자율 허용 · 문제가 해결될 것이라고보며 함께 일과 오락을 즐김	· 문제가 잘 해결되지 않고 임무가 완수되지 않고 삶이 조직화되지 않음
판단-인식 (J - P)	· 개방과 폐쇄가 균형을 이루면 상호보완됨	· 인식형은 판단형을 갇혀 있다고 느낌 · 판단형은 인식형이 무책임하다고 느낌
판단-판단 (J - J)	· 체계화되고 계획적이며 일을 빨리 결정함	· 종결에 대한 욕구가 강해 서둘러 결정하거나 둘 다 과업중심이라 함께 즐길 시간이 부족함

2. 평가의 주체

◆ 가족체계 관점에 기초한 전문가 중심의 평가

- 가족치료를 위한 평가에서는 개별 가족원 한 명 한 명에 대한 정보보다 그들의 관계유형과 구조, 그리고 이것을 유지하는 규칙에 주목하고, 평가의 초점을 전체 가족과정에 두어야 함

❖ 전체성

- 가족체계적 평가에서 평가자는 항상 개인보다는 가족 전체에 초점을 두어야 함
- 가족의 특성을 알기 위해서 가족 이미지나 가족이념을 알아보는 것이 좋음

❖ 상호 의존성의 정도

- 가족은 상호의존성의 지속기간이나 강도가 높음

❖ 경계의 투과성

- 가족의 경계가 명확한지 경직되어 있는지 파악

❖ 가족규칙의 경직성

- 역기능적인 가족일수록 자신들의 가족규칙을 어떻게 변화시킬 것인가에 대한 상위 규칙이 없음

❖ 가족신화

• 개념
  · 가족원이 공유하는 잘못된 기대와 신념
  · 현실에 대한 왜곡이나 부정의 요소 가짐

- 역기능적 가족이 상호작용을 유지하는 과정에서 이를 합리화하는 데 조직적인 신념으로 활용

❖ 위계와 가족권력

- 위계는 가족구성원이나 하위체계의 권력과 관련 있음
- 권력은 가족원이 갖는 자원에 따라 결정되며, 권력에 따라 하위체계 간에 위계질서가 조직화됨

❖ 하위체계
- 가족의 하위체계 기능을 살펴보고 재배열하거나 위계구조를 변화시키기 위한 개입을 계획함
- 역기능적인 하위체계를 평가해야 함

❖ 상위체계
- 가족의 상위체계라고 하면 주로 가족체계를 둘러싼 사회환경 또는 사회관계망을 의미함
- 관계망을 조사하기 위해 생태도나 다이어그램을 활용할 수 있음

❖ 가족의사소통
- 가족의 의사소통은 가족의 친밀감, 적응력, 권력은 물론이고 규칙, 신화, 이미지 등 총체적인 가족관계의 질을 반영하는 기준이 되므로 평가의 중요한 대상이 됨

◆ 포스트모더니즘에 기초한 내담자 중심의 평가
- 1980년대 이후 포스트모더니즘의 영향으로 사회현상에 대한 보편성과 객관성에 대한 회의가 확산되기 시작
- 가족을 평가하는 행위 역시 관찰자(치료자)의 주관적 가치와 선호하는 이론에 의해 영향을 받는다는 인식의 확산
- 포스트모더니즘 관점에서 볼 때 가족기능에 대한 평가는 사회, 문화적 맥락에 의해서, 전문가의 지식권력에 의해서, 또는 가치가 내재된 여러 맥락 내에서 영향을 받는 행위
  ⇨ 따라서 내담자에 대한 전문가의 평가는 최소화되고, 내담자 본인의 평가 비중은 증가됨

14주차 1교시	가족상담사의 역할	
	수업목표	가족상담사의 역할과 가족상담사 훈련과정에 대해 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 가족상담사의 역할 2. 상담이론별 상담사의 역할 3. 가족상담사 훈련과정

1. 가족상담사의 역할

◆ 가족상담사의 역할

- 상담사의 자질과 훈련은 상담과정에서 결정적인 역할을 함
- 상담사는 원만한 인격과 인간에 대한 관심이 있어야 하며, 감수성, 이해력, 의사소통능력 등이 필요함

1) 객관적인 지각자 역할

- 가족에게 객관적인 지각을 제공하여 가족이 자신의 관계체계 내에서 일어나고 있는 것을 명확하게 보고 알아차리도록 함

2) 교사로서의 역할

- 정보 제공, 새로운 행동방식을 학습하도록 적절한 시기를 조정함

3) 환경조정자로서의 역할

- 변화가 허용될 수 있는 안전한 환경과 분위기를 만들어 주고 이를 촉진하고 지속시킴
  - 안전한 환경
    - 새로운 행동을 시도하는 모험을 할 수 있고 이제까지 표현할 수 없었던 생각과 감정을 표현할 수 있는 환경

4) 안내자 또는 지도자 역할

- 여러 이론과 기법을 적용하여 가족원의 역기능적인 행동이 새로운 기능적인 행동방식으로 바뀌도록 돕고 변화를 촉진함

2. 상담이론별 상담사의 역할

◆ 상담이론별 상담사의 역할

	중심주제	주요개념	목표	기법
다세대 가족치료	미해결의 원가족과의 정서적 애착	자아분화, 융합, 삼각관계, 다세대 전수	불안 감소, 자아분화	가계도, 확대가족과 화해
경험적 가족치료	자유선택, 자기결정, 자아성장, 성숙	자존감, 의사소통, 명료화	결속감과 자율성 균형, 자존감 형성, 개인 성장	자아발견 , 직면, 재정의, 가족조각, 빙산 탐색

구조적 가족치료	가족구조, 교류패턴	경계, 연합, 하위체계, 위계구조	가족의 재구조화, 역기능적 교류패턴 변화	합류, 적응, 경계선 조정, 하위체계 구축
전략적 가족치료	의사소통, 가족규칙, 파괴적 게임, 잘못된 해결방법	대칭적, 보완적 의사소통	증상제거, 현재문제 해결, 가족체계 변화	역설적 게임, 가장기법, 순환질문
이야기 가족치료	삶은 이야기이다, 사람과 문제는 별개다, 가족의 이야기는 사회적 산물이다	경험은 사회적으로 구성된다, 인간은 능동적인 행위자다	내담자가 스스로 자신의 부정적인 이야기를 긍정적으로 쓰는 것	문제의 외재화, 문제의 영향 탐색하기, 외부증인 집단, 치료적 문서

1) 다세대모델의 가족상담사 역할
- 모델, 교사, 친구, 안내자, 코치역할
- 가족융합으로부터 탈삼각화 코치
- 공평한 관계의 발달 도움

2) 경험적 모델의 가족상담사 역할
- 모델, 지도자, 관찰자 역할
- 가족이 자존감이 높고 분쟁과 갈등에 잘 대처하도록 일치적 의사소통을 교육

3) 구조적 모델의 상담사 역할
- 적극적이고 활동적
- 가족구조 내에 자연스럽게 들어가 가족의 조직에 적응하고, 재구조화와 기능개선을 통해 가족원의 증상개선과 문제해결에 초점을 둠

4) 전략적 치료모델의 가족상담사 역할
- 현재와 지금 상황에서 문제를 둘러싼 가족원 간의 행동 연쇄를 관찰하여 가족원 간 관계 맺는 방식을 변화시키는 객관적 관찰자, 교사역할 수행함
- 가족원 간에 반복되는 파괴적 행동유형과 잘못된 대처방법 탐색. 전략을 세우고 처방하는 전문가 역할 수행함

5) 이야기 치료 모델의 가족상담사 역할
- 내담가족을 자신에 대한 전문가로 간주하고 존중하는 태도
- 내담가족의 이야기에 알지 못한다는 자세
- 내담가족은 자신의 문제해결에 대해 지식과 능력을 이미 갖추고 있다고 여기고 돕는 역할을 함

3. 가족상담사 훈련과정

◆ 가족상담사 자질
- 가족상담사는 대인관계기술과 의사소통기술, 그리고 내담자와의 치료적 관계형성기술 및 지지기술에 숙달하도록 노력해야 할 것임

• 유능한 가족상담사의 특성

- 전문적인 지적 능력, 건강한 자존감, 정서적 공감능력, 융통성, 자신감 및 유머 등

◆ 가족상담사 훈련과정

- 성격발달, 인간발달, 가족관계와 역동, 가족주기와 발달과제, 체계이론 등의 기초이론과 상담이론, 가족상담이론 및 기법, 연구방법, 법과 윤리, 복지 등에 대한 체계적 지식 습득해야 함
- 현장실습과 가족을 직접 다루는 상담경험을 쌓아야 하고, 전문가의 감독하에 상담 실무 훈련과정 이수해야 함
- 지식과 상담 실무 습득과 사회적 책임을 인식해야 함

14주차 2교시	가족치료의 주요 윤리원칙	
	수업목표	가족치료의 주요 윤리원칙을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 가족치료의 윤리원칙 2. 가족치료의 윤리적 딜레마

1. 가족치료의 윤리원칙

◆ 내담자에 대한 책임

1) 다양성에 대한 책임

- 치료자는 내담자의 연령, 인종, 성별, 사회·경제적 지위, 장애, 종교, 출신국가, 성적지향 등에 관계 없이 전문적 서비스를 제공하고 내담자를 공정하게 대우해야 함

2) 이중관계의 금지

- 이중관계
  - · 치료자가 내담자와의 사이에 전문적 치료관계 이외에 다른 사적 관계를 맺는 것
    예) 사적인 친밀관계, 성적관계, 동업자관계, 사제관계 등

- 이는 내담자를 객관적인 관점에서 바라보기 어렵게 함

3) 자기결정권 존중

- 자기결정권
  - · 자신의 운명을 결정할 수 있는 무조건적 권리

- 치료자는 자신의 결정이 가져올 수 있는 결과에 대해 내담자가 충분히 이해하도록 도움

4) 치료종결이나 의뢰에 대한 책임

- 치료자가 다룰 수 없거나 다루기에 부적절하다고 판단되는 경우 다른 치료서비스를 받을 수 있도록 해야 함

5) 고지된 동의

- 고지된 동의
  - · 치료를 시작하기 전에 내담자의 권리와 책임에 대해 충분히 이해한 상태에서 치료에 동의하도록 하는 절차

- 고지하고 동의해야 할 내용

- 고지해야 할 내용
  - 치료의 내용과 구조, 잠재적 혜택과 해악
  - 치료장면의 녹음/녹화/제 3자에 의한 관찰 등
  - 훈련생이 슈퍼바이저의 지도감독하에 서비스 실시할 경우
  - 제3자에게 내담자와 관련된 정보를 공개하는 것

◆ 비밀유지

1) 비밀보장의 원칙

- 비밀보장
  · 치료자가 내담자와의 신뢰관계에 근거하여 얻은 정보를 내담자의 사전 동의 없이는 타인에게 발설하지 않는 것

- 정보를 공개하기 위해서는 모든 내담가족에게 동의를 받아야 함

2) 치료대화에 대한 비밀유지 특권

- 비밀유지 특권은 치료자가 치료과정 중 알게 된 내담자에 대한 정보를 내담자의 사전 동의 없이 법정소송 중에 증인으로서 외부(법정)에 공개할 수 없도록 하는 내담자의 법적 권리

3) 비밀유지 특권의 예외 상황

① 내담자가 신체적 자해나 타해의 위험에 처해 있을 때
  - 내담자를 통해 알게 된 정보가 누군가를 즉각적인 위험에서 보호할 수 있는 경우, 내담자가 자기 자신이나 가족을 포함한 타인에게 해를 입힐 수 있다고 판단되는 경우, 내담자가 자해나 타해의 위험에 처해 있는 경우, 내담자가 자살이나 생명을 위협하는 다른 심각한 위험에 처해 있는 경우 비밀유지 하지 않아도 됨

② 아동, 장애인, 노인 등 보호대상자에 대한 학대나 유기 주장이 있을 때
  - 내담자에게 아동학대, 방임, 배우자폭력 등 가족성원에 의한 피해 사실이 있음을 치료자가 알게 되었거나 피해가 의심되는 경우 사법당국에 신고할 의무가 있음

③ 학대, 폭력, 위험성 등을 이유로 법원이 명령했을 때
  - 논란 대상이 되는 정보를 치료자가 법원의 위임을 받아 획득한 경우 비밀보장 특권이 적용되지 않음

◆ 전문성과 품위

- 높은 수준의 직업적 자격과 청렴성 유지를 위한 노력을 해야함

- 가족치료 전문직에 대한 책임
  - 자기능력의 범주에서 벗어난다고 인식되는 문제에 대해 진단하거나 치료하거나 조언하지 않음
  - 자신의 개인적 문제나 갈등 때문에 상담을 수행하거나 임상적 판단에 손상을 가져오는 경우 적합한 전문가의 도움 받음

◆ 비용에 대한 합의

- 내담자, 제3의 지불자, 수련감독을 받는 자의 비용에 대해 합리적으로 이해가 되고 전문적으로 시행되고 있는 수준에서 협약함
- 서비스에 대한 요금을 지나치게 부과하지 않음

2. 가족치료의 윤리적 딜레마

◆ 누구를 내담자로 볼 것인가

- 다수의 가족구성원 중 누구를 내담자로 볼 것인가?
- 누구의 이익을 최우선으로 할 것인가?

❖ 이러한 딜레마를 해결하기 위한 방법

① 체계로서의 가족에 초점을 두는 입장
- 개인보다 부부나 가족체계를 내담자로 설정하기
- 어느 한 개인의 대변자가 되는 상황 피하기

② 가족 대 개인의 균형을 강조하는 입장
- 가족과 개인의 역동 간 균형 이루기
- 가족체계 내 특정 개인이 심각한 억압을 받고 있지 않은지 살펴보기

③ 개인의 복지에 초점을 두는 입장
- 가족 중 누군가가 위험한 상황에 처한 징후가 발견되는 등 개인의 복지가 위협을 받는 상황에서 임상적 차원의 개입이 필요한 경우, 그 구성원의 개인적 욕구를 우선적으로 다룸

◆ 내담자가 원치 않은 치료결과가 나올 경우 어떻게 할 것인가

- 치료를 개시하기에 앞서 치료의 절차, 목표, 치료의 부작용, 치료자 자격 등에 대해 밝히고 내담자가 치료를 선택하도록 함
- 치료목표가 무엇인지 명확하게 밝히고, 내담자가 이에 대해 동의하는지, 내담자가 다른 목표를 생각하고 있지는 않은지를 확인해야 함

◆ 어떤 비밀을 어디까지 보장해야 하는가

1) 고지된 동의
- 치료자는 상담 초기에 비밀보장과 고지된 동의에 관해 설명하고, 임상적 필요에 의한 것이든 법에 의한 것이든 비밀을 지킬 수 없는 경우에 대해 알려야 함
- 치료자와 내담자 사이에 '비밀정보'가 무엇인지를 서로 동의하는 과정이 필요함
  - 부부나 가족과 관련된 비밀정보
    · 부부관계에 대한 헌신, 성행동/성적지향, 근친상간, 가정폭력이나 학대, 범죄행위, 약물사용, 자해 및 타해의 위험을 보이는 정신 상태 등
  - 청소년과 관련된 비밀정보
    · 무단결석, 약물사용, 조직폭력단활동 등

2) 비밀정보를 다루는 방법
- '분별 있는 책임성' 방침(카르펠. Karpel, 1980)
- 치료자는 다음과 같은 자신의 임상적 판단을 기초로 정보를 공유하거나 철회해야 함
  ① 특정한 정보나 그것을 모르는 사람과 어떤 관계가 있는지를 고려함
  ② 그 정보를 모르고 있는 사람의 입장에서 주어진 상황을 이해하고자 노력함
  ③ 정보공개의 시점과 그 결과에 대해 그 정보를 모르는 사람의 입장에서 생각함
- 만일 치료자가 정보를 공개하지 않은 채 관계를 지속하는 행위는 비밀을 갖고 있는 사람과 결탁하는 것인 동시에 비밀을 모르고 있는 사람의 신뢰를 저버리는 것
- 비밀보장이 경우에 따라 그 정보를 모르는 사람을 보호하기 위한 좋은 의도에서 나온 시도일 수 있으나, 예기치 못한 상황에서 공개되었을 때 구성원, 관계, 치료 자체에 부정적 영

향을 미칠 수 있음

◆ 치료자와 내담자의 이중관계는 어디서부터인가

- 치료자가 내담자나 내담자의 직계가족과 전문적 치료관계 이외의 관계를 맺음으로써 발생함
  예) 동업, 친구관계, 이성관계, 성관계 등

◆ 정신과 진단명이 가족관계에 어떤 영향을 주는가

- 정신과질환은 평생 10명 중 3명, 한 해 동안 10명 2중 2명이 앓을 정도로 흔한 병(보건복지부, 2002)
- 정신과질환은 조기발견과 지속적인 치료 및 재활이 중요하며, 이를 위해서는 진단이 우선되어야 함
- 그러나 가끔은 이 진단으로 인해 피해를 당하는 경우 발생
- 가족들이 정신과 진단을 받은 구성원에서 모든 문제를 전가하는 경우가 발생할 수 있음
  예) 이혼과정에서 양육권을 주장하는 쪽의 정신과 진단은 패소에 중대한 변수로 작용할 수 있음

◆ 치료자의 미해결된 문제는 어떻게 할 것인가

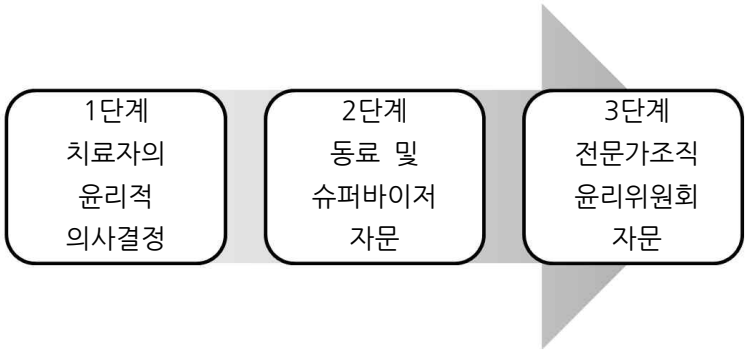
- 치료자의 원가족 경험에서 비롯되는 감정적 반응은 내담 가족과의 관계에서 반복적으로 나타날 가능성이 있고, 그러한 반응은 치료적 관계에 지속적인 장애가 됨
  예) 치료자가 폭력적인 아버지 밑에서 성장한 경우, 폭력적인 남성 내담자를 만났을 때, 직면이 필요한 상황에서 적절히 직면하지 못하고 투사적 반응을 보일 수 있음
  ⇨ 따라서 치료자가 되기 전 자신의 문제해결을 위한 노력이 필요하고, 상담 시 그러한 반응이 나올 때에는 수퍼바이징을 통해 해결해야 함

14주차 3교시	윤리적 의사결정 모델과 사이버상담 윤리	
	수업목표	윤리적 의사결정 모델과 사이버상담 윤리를 준수할 수 있다.
	세부내용	1. 윤리적 의사결정 모델 2. 사이버상담 윤리

1. 윤리적 의사결정 모델

◆ 치료자의 윤리적 의사결정

- 치료자는 가족치료 장면에서 발생하는 윤리적 딜레마에 직면했을 때, 다음의 3단계 모델을 통해 딜레마의 해결방안을 모색할 수 있음



1) 해결중심적 대화

- 다음의 순서에 따라 치료자가 당면한 윤리적 딜레마를 둘러싼 제반 쟁점을 사정함
  - 치료자가 직면하는 윤리적 딜레마와 관련이 있는 개인적 가치/사회적 가치/전문적 가치와 윤리는 무엇인가?
  - 대안적인 선택의 여지에는 어떤 것이 있는가?
  - 대안 중 그 결정으로 영향을 받게 될 사람들의 권리를 극대화시킬 수 있는 것에는 어떤 것이 있나?
  - 대안 중 사회의 이익과 권리를 최대한 보호할 수 있는 것이 있는가?
  - 각 대안이 효율적이고 효과적이며 윤리적일 수 있는가?
  - 각 대안의 단기적/장기적인 윤리적 결과에는 어떤 것이 있는가?

2) 윤리규칙 검토

- 치료자는 윤리적 딜레마 해결을 위한 대안을 두고 가족치료 전문가윤리강령에 비추어 문제가 없는지 검토해야 함
- 이러한 규칙은 치료자의 개인적 가치보다 우선시되어야 함

3) 윤리원칙 검토

- 치료자의 대안을 다음의 7원칙에 따라 점검

❖ 윤리원칙 검토 7원칙

① 윤리원칙 1 : 생명보호의 원칙
- 생명보호의 원칙은 가장 기본적인 것으로 다른 의무나 원칙에 우선해야 함

② 윤리원칙 2 : 평등과 불평등의 원칙
- 동등한 사람들은 평등하게 대우받아야 함
- 동등하지 않은 경우 동등하지 않은 점이 문제의 핵심이 될 때(예 : 학대) 불평등하게 대우받아야 한다는 원칙(예 : 학대 받는 아동의 권리가 더 우선되어야 함)

③ 윤리원칙 3 : 자율성과 자유의 원칙
- 내담자는 자신의 자율적 의사와 판단에 의해 결정해야 함
- 그러나 다른 사람에게 해가 될 경우 차단해야 함

④ 윤리원칙 4 : 최소한 손실의 원칙
- 가장 최소한의 손실과 빠른 회복이 가능한 대안 선택

⑤ 윤리원칙 5 : 삶의 질의 원칙
- 치료자, 내담자, 관련된 사람들의 삶의 질이 더욱 향상될 수 있는 대안 선택

⑥ 윤리원칙 6 : 사생활보호와 비밀보장의 원칙
- 내담자의 사생활보호와 비밀보장의 원칙이 지켜지는 대안 선택

⑦ 윤리원칙 7 : 진실성과 정보개방의 원칙
- 내담자와 그와 관련된 사람들에게 진실을 말하고 모든 관련된 정보를 충분히 개방하는 것을 허용하는 대안 선택

◆ 동료나 슈퍼바이저의 자문

- 치료자가 위의 단계를 통해 스스로 검토를 하였음에도 윤리적 딜레마가 해결되지 않을 경우 치료자 동료나 슈퍼바이저에게 자문을 구하여 자신의 시각에서 벗어나 다각적인 해결책을 모색하여야 함

◆ 전문가조직 윤리위원회의 자문

- 치료자가 주변의 동료나 슈퍼바이저와의 면담과 자문을 통해서도 윤리적 딜레마가 해결되지 못할 경우 소속 학회의 전문가조직 윤리위원회에 자문을 구할 수 있음
- 윤리위원회는 문제가 제기된 사례를 접수하고 그에 관해 조사하고 그 결과를 당사자나 회원들에게 알리는 역할을 함

2. 사이버상담 윤리

◆ 사이버상담 윤리의 필요성

❖ 사이버상담이란?

- 컴퓨터 공학이 발전한 결과 사이버 세계가 형성되면서 상담이 컴퓨터를 통해 PC 통신 상담 또는 사이버상담이 가능해졌음
- 사이버상담은 도움이 필요한 사람, 즉 내담자의 문제를 해결하고 생각, 감정, 행동 측면의 인간적 성장을 위해 사이버 공간에서 수행되는 만남을 의미함

- 그러므로 전통적 상담과 목적은 동일하지만 목적을 이루기 위해 사용하는 매체가 달라 여타 대면상담이나 전화상담과는 방법상 차이가 있음
- 사이버상담은 컴퓨터 통신이 단순한 정보교환이나 의사소통의 수준을 넘어서서 인간의 내면세계까지 다루게 된 결과, 내담자의 문제를 해결하고 성장촉진을 돕는 과정까지 담당하게 된 결과로 가능해졌음

❖ 사이버상담의 특징 및 효과

① 각종 제한에서 자유로운 편의성
- 사이버 공간에서 상담이 이루어지기 때문에 지리적 제한 없이 도서나 벽지에 있는 사람들도 원한다면 인터넷을 통해 전 세계적으로 자신이 원하는 전문상담자를 찾아서 원하는 시간에 상담을 받을 수 있음

② 익명성과 다중 정체성
- 사이버상담사와 내담자는 원한다면 자신의 실명을 사용하지 않고서도 상담을 진행할 수 있음

③ 경제성과 효율성
- 대면 상담보다 상담료가 저렴할 수 있음
- 오고 가는 시간과 비용을 절약할 수 있음

④ 문자 중심의 의사소통
- 자신의 힘든 점을 글로 남기고 거기에 대한 답변을 실시간 또는 일정 시간 이후 받아 볼 수 있음
- 따라서 문자를 읽고 쓰는 것이 원활하지 않거나 독해능력에 따라 이용에 제한이 생길 수 있음

⑤ 대면상담에 비해 심리적으로 더 편안할 수 있음
- 사이버상담은 상담자와 얼굴을 마주 대하거나 직접 말을 주고받아야 하는 부담 없이 문자만 사용하여 의사소통을 하는 과정에서 자신의 감정이나 어려움을 더 솔직히 표현할 수 있음
- 이로 인해 상담의 효과가 높아질 수 있음

⑥ 탈억제 작용이 강함
- 익명성이 보장되기 때문에 감정조절이나 표현이 덜 통제됨
- 얼굴을 알지 못하기 때문에 통제되지 않은 메시지 전달

⑦ 내담자의 주도성이 더 발휘됨
- 사이버상담은 상담자와 내담자의 평등한 관계와 자발성 속에서 내담자는 상담관계에서 보다 많은 통제력과 주도성을 갖게 됨

⑧ 친밀성과 협동성이 크게 발휘됨

⑨ 인간관계 형성 및 단절의 융통성이 있음
- 사이버 공간에서는 대면상황에서보다 인간관계를 맺거나 종결하는 일이 훨씬 더 쉽고 간단함

⑩ 기록의 저장, 유통, 가공이 쉬움
- 사이버상담 내용은 상담을 하는 동안 몇 개의 키를 입력하여 쉽게 저장할 수 있고, 따로

축어록을 만들기 위해 시간과 노력을 들이지 않아도 저장한 내용 자체가 문서화되어 남음
- 상담사례를 모아서 데이터베이스화하여 많은 사람들이 상담사례 검색 및 조회를 통해 직접 상담을 받지 않고서도 간접적으로 자신의 문제에 대한 해결을 도모할 수 있음

❖ 출처 : 상담학 사전, 2016, 김춘경 외

◆ 사이버상담의 주요 윤리 이슈

- 한국 사회에서 사이버상담이 확대되고 있고 사이버상담 과정에서의 문제점도 드러나고 있음
- 따라서 사이버상담에 대한 윤리적 기준을 마련하고 이를 현장에 적용해야 할 것임

• 사이버상담에서 상담자들이 알아야 할 윤리적 이슈
  - 사이버상담의 적절성 여부, 사이버상담자의 역량, 신원확인, 사전확인, 사전동의, 사이버상담 오리엔테이션, 장애를 가진 내담자가 활용할 수 있는 인터넷 환경 조성, 문화적 다양성 인정 등

- 사이버상담을 이용하는 내담자들에게 사이버상담의 비밀보장 이슈나 인터넷 통신, 기록유지 및 관련 한계를 통보해야 함
  • 내담자 인적사항이나 상담 내용이 유출되지 않도록 사전에 대비하고 내담자의 요청이 있을 경우 상담내용을 삭제해 주되, 교대근무로 인해 다른 상담자가 상담내용을 볼 수 있다는 점, 기관방침이 있는 경우 일정 기간 상담내용이 저장되는 점, 웹사이트의 불안정으로 비밀보장에 한계가 있을 수 있다는 점 등을 미리 설명하고 공지할 필요가 있음